Organisation, fonctionnement et procédures du système d'évaluation éthique et administrative de la recherche en santé humaine au Cameroun

TABLE DES MATIÈRES

AVANT 7
MERCI 8
Comité éditorial 9
COMITÉ DE VALIDATION 10
1.1 LIGNES DIRECTRICES POUR LA PROTECTION DES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE EN SANTÉ HUMAINE AU CAMEROUN 13
1.2. LES ACTEURS DE LA RECHERCHE AU CAMEROUN 21
1.2.1. Acteurs du Ministère de la Santé Publique 21
1.2.2. Autres parties prenantes 24
1.3. INTERACTIONS ENTRE PARTIES PRENANTES 26
1.3.1. Interactions entre les comités d'éthique et le MINSANTE 26
1.3.2. Interactions entre les comités d'éthique et les chercheurs/institutions de recherche 27
1.3.3. Interactions entre équipes de recherche dans le cadre d'études multicentriques 27
1.3.4. Interactions entre les comités d'éthique et la communauté 28
1.3.5. Interactions entre les différents comités d'éthique (CNERSH - CERSH - CIERSH) 28
1.3.6. Interactions entre le Secrétariat Technique, le bureau et les membres du comité d'éthique 29
1.3.7 Interactions entre les comités d'éthique et les partenaires de développement 29
CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTION DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE POUR LA SANTÉ HUMAINE 30
II.1. ORGANISATION DES COMITÉS D'ÉTHIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTÉ HUMAINE 30
11.1.1. Statut juridique du CERSH 30
II.1.2. Structuration des différents Comités d'Éthique 31
II.1.3. Experts indépendants ou consultants ad hoc 36
11.1.4. Formation pour les membres du CERSH 37
II.1.5. Financement du CERSH 38

II.1.6. Frais d'évaluation éthique en sessions ordinaires et extraordinaires 39
11.2. FONCTIONNEMENT DU CERSH 41
II.2.1. Mise en place d'un CERSH 41
II.2.2. Sélection des membres du CERSH 44
II.2.3. Installation du CERSH 46
II.2.4 Renouvellement de mandat des membres du CERSH 48
II.2.5. Remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé 49
11.2.6. Révocation d'un membre 50
II.2.7. Sélection d'experts et de consultants indépendants 52
II.2.8. Elaboration et validation du budget CERSH 53
II.2.9. Recouvrement des recettes du CERSH 54
II.2.11. Responsabilité du CERSH 57
II.2.12. Conduite des séances/réunions du CERSH 57
II.2.13 Participation du chercheur principal à une session du CERSH 60
II.2.14. Gestion des conflits d'intérêts lors des évaluations éthiques des protocoles de recherche 61
II.2.15. Rédaction des comptes rendus des séances du CERSH 63
II.2.16. Rédaction du rapport de session CERSH 63
II.3. SUIVI ET ÉVALUATION DE LA FONCTIONNALITÉ DU CERSH 65
Chapitre III : Évaluation éthique et administrative des protocoles de recherche pour la santé humaine 68
III.1. PROCÉDURES D'ÉVALUATION ÉTHIQUE 70
III. 1.1. Soumission des protocoles de recherche 70
III.1.2. Remise des protocoles pour cas particuliers 72
III.1.3. Attribution des protocoles de recherche aux membres et experts indépendants pour évaluation 79
III. 1.4. Critères d'évaluation éthique 80
IV.1.2. Veille continue active - suivi des modalités de participation à la recherche 83
IV.1.1. Surveillance continue passive 86
CHAPITRE IV : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROTOCOLES DE RECHERCHE ET SUIVI-ÉVALUATION DU FONCTIONNALITÉ DES COMITÉS D'ÉTHIQUE 87
IV.1. VEILLE ÉTHIQUE CONTINUE PROJET DE RECHERCHE DTJN DÉJÀ APPROUVÉ 87

III.2.5. Mettre à jour un AAR 88
III.2.4 Gestion du matériel biologique 89
III.2.3. Éléments d'évaluation administrative des protocoles de recherche 90
III.2.3. Éléments d'évaluation administrative des protocoles de recherche 92
III.2.2. Traitement d'une demande d'autorisation administrative de recherche 92
III.2. ÉVALUATION ADMINISTRATIVE DES PROTOCOLES DE RECHERCHE 93
III.2.1. Composition du dossier de demande d'Autorisation Administrative de Recherche 94
III. 1.10. Resoumission d'un protocole de recherche 96
III. 1.9. Communication de la décision CERSH 98
III.1.8. Prise de décision CERSH 98
III. 1.7. Dispense d'autorisation éthique 99
III. 1.5. Évaluer la situation de conflit d'intérêts du chercheur 100
III. 1.6. Dispense du consentement éclairé 100
IV.2. TRAÇABILITÉ/STOCKAGE DES DONNÉES DE MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE RECHERCHE 110
IV.6. LEVÉE DE LA SUSPENSION DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION ÉTHIQUE 114
IV.7. SUIVI DE LA COLLABORATION AU SEIN DE L'ÉQUIPE DE CHERCHEURS ET AVEC LES AUTRES ACTEURS DU TERRAIN/SITE DE RECHERCHE 115
IV.8. SUIVI ET ÉVALUATION DES STRUCTURES IMPLIQUÉES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE RECHERCHE 116
IV.9. SUIVI ET ÉVALUATION DES PROTOCOLES D'ESSAIS CLINIQUES PAR L'AUTORITÉ NATIONALE DE RÉGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE (ANRPH) 117
IV.10. PROCÉDURE DE RÉVISION/MISE À JOUR DE CE DOCUMENT 119
LES RÉFÉRENCES 120
ANNEXES 122
Annexe 1 : Grille d'évaluation éthique d'un projet de recherche. 122
Annexe 4 : Lignes directrices pour le suivi du comité d'éthique par DROS 148
Annexe 5 : Grille de revue du fonctionnement des Comités d'Ethique de la Recherche en Santé Humaine au Cameroun (CERSH) 157
Annexe 6 : Formulaire de déclaration de conflit d'intérêts par les représentants des établissements de recherche 164
Annexe 7 : Formulaire d'engagement de confidentialité 166

Annexe 8 : Aperçu de l'accord de transfert de matériel à des fins de recherche impliquant des êtres humains 167

Annexe 9 : Liste de contrôle d'inspection pour les essais cliniques 178

AVANT

La recherche joue un rôle essentiel pour améliorer l'accès des populations aux soins. Il produit des données probantes sur la répartition et les déterminants des problèmes de santé et fournit aux décideurs des informations pour guider leurs choix. Il contribue ainsi à améliorer la performance du système de santé. Cependant, cela doit se faire dans le respect des règles d'éthique et de protection des participants.

Par le décret n° 2002/209 du 19 août 2002 portant organisation du Ministère de la Santé Publique, révisé par le décret n° 2013/093 du 3 avril 2013, le Gouvernement a créé la Division de la Recherche Opérationnelle en Santé. Plus récemment, la loi n°2022/008 du 27 avril 2022 relative à la recherche médicale impliquant l'être humain, promulguée par le Président de la République, a achevé le processus d'encadrement de la recherche en santé humaine au Cameroun.

Bien que de réels progrès dans le développement de 1a. Bien que la réglementation de l'éthique de la recherche en santé ait été accomplie, la décentralisation des comités d'éthique au niveau régional et au sein des établissements de santé nécessite une harmonisation des procédures opérationnelles d'évaluation et de suivi éthique et administratif des projets de recherche. recherche.

Ce Guide intitulé « Organisation, fonctionnement et procédures du système d'évaluation éthique et administrative de la recherche en santé humaine au Cameroun » est un outil de travail important mis à la disposition de tous les acteurs impliqués dans la recherche en santé humaine.

A cet effet, je vous invite à vous l'approprier et à en faire bon usage au profit de la politique de recherche ainsi que des bénéficiaires des conclusions desdites recherches.

Ministre de la Santé Publique

THANKS

Nous tenons à remercier nos partenaires : Partenariat pour les essais cliniques dans les pays européens et en développement (EDCTP), Meilleur accès aux soins de santé (MA SANTE), Recherche médicale, affaires réglementaires et services de conseil en santé publique pour l'Afrique (MEDRAC Afrique), Elizabeth Glaser Pediatric. Fondation SIDA (EGPAF) ; Organisation de Coordination de Lutte contre les Endémies en Afrique Centrale (OCEAC) et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), comité de rédaction et comité de validation pour leur précieuse collaboration et leur soutien constant tout au long de la rédaction, de la relecture, de la traduction et de la validation de cet important guide de procédure intitulé : « Organisation, fonctionnement et procédures du système ! Évaluation éthique et administrative de la recherche en santé humaine au Cameroun »

Comité éditorial

Pr ZOUNG-KANYI BIS:K Anne Cécile	*C/DROS*
Dr SALIHOU Sadou	*DPMI*
Prof. ONGOLO ZOGO Pierre	*HCY/Université de Yaoimdé I*
Pr ATEUDUEU Jérôme	*C/CRC/DROS*
Pr. F OK ONE AN G Charles	*Université de Yaoundé 1/FMSB*
Pr. NGABA-MAMBO Olive Nicole	*C/C RSPE/DR OS*
Dr ABONG Thérèse	*Président par intérim du CNERSH*
Dr ONG NYEKIMOUAHA-BELL Adèle-Rose	*Université de Yaoundé I/FMBS*
Dr MBWE Maurice	*SDP/DPML*
Monsieur MPAH Julien	*CC/DAJC*
M.YOPNDOI Charles	*Chef de l'Unité de Suivi/MINSHEALTH*
Mme MELINGUI Yvette	*Assistant de recherche N°ICC//DAJC*
M. OBAM Nicolas Michel	*Assistante Chargée de Recherche N°I/C RSPE/DROS*
Le mien. NAAH Félicité	*Assistant de Recherche N°2/CRSPE/DROS*
Dr NGONO Basile	*CHMCERH*
M. ATANGA Benjamin	*Cadre/DROS*
M. NGU PAUL Nembo	*Cadre/DROS*
Dr MOULIOM Fatima	*Cadre/DROS*
Mme KITIO Ingrid	*MA SANTE*
Mme TCHIO N1GHIE KetinaHirma	*MA SANTE*
Dr PALIS SUR Tatiana	*Cadre/DROS*
Mme ZOBO Marie Charlotte	*Cadre/DROS*
Mme BAKARI BAKARI Madeleine	*Cadre/DROS*
M. NGUEMKAM Gildas	*Informaticien / DROS*
Mme, TEH MONTEH CANAPE Caroline	*Cadre/DROS*
M. NDIE Justin	*Cadre/DROS*
Mme YTMDJO SIMO Edith FloreEpse	*Cadre/DROS*
TCHOUAGA Mme MABOMA Odette	* Unité de traduction/'MINSANTE

COMITÉ DE VALIDATION

Pr ZOUNG-KANYI BIS:K Anne Cécile	*C/DROS*
Dr SALIHOU Sadou	*DPMI*
Prof. ONGOLO ZOGO Pierre	*HCY/Université de Yaoimdé I*
Pr ATEUDUEU Jérôme	*C/CRC/DROS*
Pr. F OK ONE AN G Charles	*Université de Yaoundé 1/FMSB*
Pr. NGABA-MAMBO Olive Nicole	*C/C RSPE/DR OS*
Dr ABONG Thérèse	*Président par intérim du CNERSH*
Dr ONG NYEKIMOUAHA-BELL Adèle-Rose	*Université de Yaoundé I/FMBS*
Dr MBWE Maurice	*SDP/DPML*
Monsieur MPAH Julien	*CC/DAJC*
M.YOPNDOI Charles	*Chef de l'Unité de Suivi/MINSHEALTH*
Mme MELINGUI Yvette	*Assistant de recherche N°ICC//DAJC*
M. OBAM Nicolas Michel	*Assistante Chargée de Recherche N°I/C RSPE/DROS*
Le mien. NAAH Félicité	*Assistant de Recherche N°2/CRSPE/DROS*
Dr NGONO Basile	*CHMCERH*
M. ATANGA Benjamin	*Cadre/DROS*
M. NGU PAUL Nembo	*Cadre/DROS*
Dr MOULIOM Fatima	*Cadre/DROS*
Mme KITIO Ingrid	*MA SANTE*
Mme TCHIO N1GHIE KetinaHirma	*MA SANTE*
Dr PALIS SUR Tatiana	*Cadre/DROS*
Mme ZOBO Marie Charlotte	*Cadre/DROS*
Mme BAKARI BAKARI Madeleine	*Cadre/DROS*
M. NGUEMKAM Gildas	*Informaticien / DROS*
Mme, TEH MONTEH CANAPE Caroline	*Cadre/DROS*
M. NDIE Justin	*Cadre/DROS*
Mme YTMDJO SIMO Edith FloreEpse	*Cadre/DROS*
TCHOUAGA Mme MABOMA Odette	* Unité de traduction/'MINSANTE

RAA	Autorisation administrative de recherche
AMM	Autorisation de marketing
ANRPh	Autorité nationale de réglementation pharmaceutique
CCSSRS	Commission consultative scientifique et stratégique pour la recherche en santé
CERSH	Comité d'éthique de la recherche pour la santé humaine
CIERSH	Comités institutionnels d'éthique de la recherche pour la santé humaine
CIOMS	Conseil des organisations internationales des sciences médicales
CNERSH	Comité national d'éthique de la recherche pour la santé humaine
CRERSH	Comités régionaux d'éthique de la recherche pour la santé humaine
DPML	Direction de la Pharmacie, du Médicament et du Laboratoire
DROS	Division de Recherche Opérationnelle en Santé
FDS	Département de santé familiale
DSMB	Comité de surveillance de la sécurité des données
CE	Test clinique
SAE	Evénement indésirable grave
IP	Chercheur principal
LANACOME	Laboratoire National de Contrôle Qualité des Médicaments et Expertise
MINSANTE	ministère de la Santé publique
MTA	Médicaments traditionnels améliorés
ONSP	Observatoire National de Santé Publique

► CHAPITRE I : GÉNÉRAL

La recherche en santé est définie comme une « étude méthodique visant à enrichir des connaissances généralisables » [1]. Selon l'Arrêté portant création, organisation et fonctionnement des Comités d'éthique de la recherche en santé humaine au sein des structures relevant du Ministère de la Santé publique du Cameroun [2], la recherche pour la santé humaine s'entend comme : « .... la production de connaissances dans le but de comprendre les problèmes de santé et de mieux y remédier……". Elle englobe toute intervention, collecte et analyse de données impliquant des êtres humains. Elle s'intéresse aux produits pharmaceutiques, aux outils et procédures diagnostiques et thérapeutiques, aux données personnelles, aux dossiers médicaux, aux échantillons biologiques, ainsi qu'à l'environnement et aux produits destinés à la consommation. Plusieurs acteurs interviennent et collaborent dans le paysage de la recherche en santé humaine au Cameroun,

Dans la Stratégie du secteur de la santé 2016-2027 [3], la recherche en santé est une composante clé du renforcement du système de santé (axe stratégique n°4) qui doit contribuer à l'atteinte de l'objectif spécifique n°4.5 qui est « d'ici 2027, assurer le développement des systèmes de santé ». la recherche et la disponibilité d'informations sanitaires de qualité pour une prise de décision fondée sur des données probantes à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Cela passe par le renforcement des capacités des institutions et des acteurs dans les domaines suivants : recherche de financements pour la recherche, mise en place d'un cadre législatif et réglementaire, coordination et diffusion des résultats de la recherche. Sur un autre plan, les activités de recherche seront principalement axées sur les piliers du système de santé et les plantes médicinales pour le développement d'une production locale de médicaments.

1.1 LIGNES DIRECTRICES POUR LA PROTECTION DES PARTICIPANTS À LA RECHERCHE EN SANTÉ HUMAINE AU CAMEROUN

Ligne directrice 1 : Principes directeurs pour la soumission, l'évaluation et le suivi de la demande d'autorisation éthique

La soumission, l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre des projets de recherche en santé humaine sont régis par le respect des principes suivants :

- Le bénéfice social de la population camerounaise pour tout projet de recherche mis en œuvre au Cameroun ;
- La soumission de tout protocole de recherche impliquant des humains à l'évaluation et au suivi par un comité d'éthique compétent ;
- La déclaration de conflit d'intérêts des membres du comité d'éthique impliqués dans l'évaluation et le suivi des protocoles de recherche ;
- Validité scientifique ;
- Minimiser les risques auxquels le protocole de recherche expose les participants et maximiser le bénéfice social attendu d'eux ;
- L'autonomie des participants à la recherche en garantissant que le consentement libre et éclairé de tous les participants est obtenu avant leur inclusion dans la recherche et pendant celle-ci ;
- La protection des participants vulnérables ou de ceux qui ne peuvent pas donner leur consentement libre et éclairé au moment de la recherche ;
- Accès équitable des populations à la recherche et à ses bénéfices, y compris les populations vulnérables ;
- Protection de la confidentialité des données et de la vie privée des participants à la recherche ;

- Respect des normes, des valeurs culturelles et sociales des ménages et des communautés, lors de la planification et de la mise en œuvre de projets de recherche ;
- Prévention, soin et réparation des dommages subis par tout participant à la recherche, même après la recherche ;
- Respect des réglementations locales et internationales lors de la planification et de la mise en œuvre des projets de recherche ;
- Transparence et équité dans la gestion des données de recherche et des échantillons biologiques issus de la recherche entre équipes de recherche ;
- Bonne gouvernance dans les équipes de recherche locales et celles impliquant des chercheurs étrangers ;
- Renforcer les capacités des équipes locales lors de la planification et de la mise en œuvre des projets de recherche ;
- Respect des règles de propriété intellectuelle.

Directive 2 : Institutions et personnes pouvant réaliser un projet de recherche en santé humaine au Cameroun

La recherche en santé humaine au Cameroun est réalisée par :

- Établissements universitaires ;
- Institutions de recherche ;
- Formation en santé ;
- Directions Techniques : et programmes du Ministère de la Santé ;
- Institutions gouvernementales et non gouvernementales ;
- Chercheurs indépendants.

Directive 3 : Itinéraire éthique et administratif d'un projet de recherche en santé humaine mis en œuvre au Cameroun.

Tout projet de recherche en santé humaine à mettre en œuvre au Cameroun

doit suivre les étapes éthiques et administratives suivantes :

- Obtenir l'accord de principe du chef de localité ou des sites de mise en œuvre de la recherche ;
- Souscription à une assurance pour les essais cliniques de phase 1, 2,3 ;
- Signature d'un accord de transfert de matériel biologique (accord de transfert de matériel) entre parties prenantes, pour les projets de recherche nécessitant un partage de matériel biologique avec des institutions extérieures au Cameroun ou avec des institutions locales ;
- Signature d'un accord de partage de données (data Sharing Agreement) entre parties prenantes, pour les projets de recherche nécessitant un partage de données avec des institutions hors Cameroun ou avec des institutions locales ;
- Obtenir une exemption spéciale d'importation auprès du Ministère de la Santé s'il s'agit d'une étude impliquant l'utilisation de produits non agréés au Cameroun pour des essais cliniques ou d'une étude évaluant des produits non agréés ;
- Obtention préalable de l'autorisation éthique d'un comité d'éthique compétent avant toute mise en œuvre du protocole de recherche ;
- Obtention préalable de l'Autorisation Administrative de Recherche auprès du Ministère de la Santé avant toute mise en œuvre du protocole de recherche ;
- Notification des événements indésirables dans les délais réglementaires au Comité Indépendant de Suivi des Données, au Comité d'Éthique, à la Direction de la Recherche Opérationnelle en Santé (DROS) et à la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires (DPML) ;
- Transmission des rapports d’avancement et finaux de recherche au comité d’éthique et au Ministère de la Santé Publique ;
- Retour des résultats de recherche aux autorités sanitaires y compris aux communautés avec la participation du DROS ;

- Continuité des soins aux patients à la fin des essais cliniques si le produit testé s'avère bénéfique pour la santé des participants.

Directive 4 : Sites de mise en œuvre de projets de recherche en santé humaine

Les projets de recherche sur la santé humaine peuvent être mis en œuvre dans les communautés, les établissements de santé et autres institutions appropriées.

La phase 1 des essais cliniques ne peut être mise en œuvre que dans un hôpital de première, deuxième et troisième catégorie, ou dans un établissement dédié à la recherche clinique disposant d'un plateau technique approprié.

Ligne directrice 5 : Rôles des acteurs impliqués dans la recherche pour la santé humaine au Cameroun

Du Ministère de la Santé Publique

Le rôle du Ministère de la Santé Publique est de :

- Élaborer et mettre à jour les lignes directrices et les procédures relatives à la protection des participants à la recherche en santé humaine ;
- Mettre en œuvre, suivre et évaluer les comités d'éthique de la recherche en santé humaine (CERSH);

- Assurer le respect de la réglementation concernant la recherche en santé humaine ;
- Assurer la création et la mise à jour d'un répertoire des chercheurs et d'un registre des projets de recherche en santé humaine ayant obtenu une autorisation administrative de recherche ;
- Assurer la restitution et la valorisation des résultats des projets de recherche pour améliorer l'accès de la population aux soins et aux protocoles de soins ;
- Assurer l'enregistrement des essais cliniques dans un site national ou international reconnu ;
- Assurer la protection des données individuelles des participants à la recherche ;
- Participer au renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la recherche.

Comité d'éthique de la recherche pour la santé humaine

Le rôle des comités d'éthique de la recherche en santé humaine est de :

- Protéger la dignité, les droits, la sécurité et le bien-être de tous les participants actuels ou potentiels à la recherche ;
- Élaborer et mettre à jour des lignes directrices et des procédures relatives à la protection des participants à la recherche en santé humaine ;
- Assurer le respect de la réglementation concernant la recherche en santé humaine ;
- Créer et mettre à jour un répertoire des chercheurs et un registre des projets de recherche en santé humaine ayant obtenu une autorisation éthique ;
- Assurer la protection des données individuelles des participants à la recherche ;

- Participer à la connaissance des capacités des acteurs impliqués dans la recherche ;
- Mettre en place, suivre et évaluer le CERSH.

Promoteurs de la recherche pour la santé humaine

Le promoteur est une personne physique ou morale chargée du lancement, de la gestion et du financement d'un projet de recherche. A cet effet, il est chargé de :

- Assurer l'élaboration de protocoles et d'outils de mise en œuvre du projet de recherche ;
- S'assurer que le site de recherche est adéquat et que les équipes de recherche sont compétentes pour le protocole de recherche proposé ;
- Veiller au respect des règles éthiques lors de la mise en œuvre du protocole de recherche ;
- Assurer le suivi et l'audit des essais cliniques ;
- Assurer la mise en place d'un « Data Safety Monitoring Board » (DSMB) (comité de suivi des données et de suivi des essais cliniques) ;
- Assurer la prévention et la couverture des dommages qui touchent tout participant pendant et après l'essai clinique ;
- Assurer la protection des droits des chercheurs participant à la recherche ;
- Renforcer les capacités de ses chercheurs impliqués dans la recherche ;
- Assurer le partage des données de tous les sites sur la sécurité des interventions sanitaires testées :
- Assurer l'accès des participants aux produits issus de la recherche ;
- Assurer la restitution des résultats aux parties prenantes y compris les communautés.

Institutions et sites de recherche

Le gestionnaire est responsable de :

- Donner son accord de principe pour tout projet de recherche qu'il accueille sous réserve de l'obtention d'un Attestation Ethique et d'une Autorisation Administrative de Recherche ;
- Assurer le respect, la dignité, les droits, la sécurité et le bien-être de chaque participant au projet de recherche mis en œuvre au sein de son établissement ou promu par ledit établissement ;
- Établir des procédures internes, le cas échéant, en collaboration avec le chercheur principal, pour la mise en œuvre du projet de recherche conformément au protocole approuvé ;
- Assurer le renforcement des capacités du personnel impliqué dans la recherche ;
- Assurer le renforcement des capacités des membres du comité d'éthique de la recherche institutionnelle le cas échéant ;
- Assurer le renforcement du plateau technique de votre établissement par le promoteur de recherche.

Du chercheur principal

Le chercheur principal du projet de recherche est toute personne physique responsable de la conduite scientifique d'un projet de recherche en santé humaine.

Il est responsable de:

- Obtenir l'habilitation éthique et l'autorisation administrative de recherche selon les modalités définies par la réglementation, pour fournir les informations adéquates ;
- Obtenir le consentement libre et éclairé des participants à la recherche ou de leurs représentants légaux ;

- Garantir la confidentialité des données de recherche selon les normes de bonnes pratiques cliniques ;
- Conserver les données collectées pendant au moins dix (10) ans à compter de la fin de la recherche ;
- préparer un rapport anonymisé d'avancement, de mise en œuvre annuel et final à l'intention de l'administration compétente.
- S'assurer que les catégories de population pour lesquelles les résultats de la recherche seraient utiles sont éligibles ;
- Veiller à ce que les sites d'étude soient conformes aux normes de bonnes pratiques cliniques ;
- Procéder à l'enregistrement de l'essai clinique selon les modalités définies par la réglementation
- Communiquer au participant les informations relatives à sa santé pendant et à la fin de la recherche, publier les résultats des travaux de recherche ;
- Signaler tout incident observé sur le terrain au promoteur, à l'organisme chargé de la déontologie ainsi qu'à l'administration qui a délivré l'Autorisation administrative de recherche ;
- Restituer les résultats aux parties prenantes dont les communautés en imposant le DROS.

Ligne directrice 6 : Délais d'évaluation.

Les délais d'évaluation éthique des demandes complètes d'habilitation éthique et d'autorisation administrative de recherche sont fixés comme suit.

- 30 jours pour une demande d'autorisation éthique ;

- 21 jours pour la demande d'Autorisation Administrative de Recherche.

Directive 7 : Formation des chercheurs et des membres des comités d'éthique

Avant de participer à l'évaluation éthique, tout membre d'un comité d'éthique doit recevoir une formation dans les domaines suivants :

- Les principes d'évaluation éthique et scientifique des protocoles de recherche en santé humaine ;
- Les textes réglementaires nationaux et internationaux régissant la protection des participants à la recherche ;
- Le fonctionnement des comités d'éthique en général et au Cameroun en particulier ;
- Bonnes pratiques cliniques.

1.2. LES ACTEURS DE LA RECHERCHE AU CAMEROUN

1.2.1. Acteurs du Ministère de la Santé Publique

Le décret n° 2002/209 du 19 août 2002 organisant le Ministère de la Santé Publique [4] et révisé par le décret n° 2013/093 du 3 avril 2013 [5] crée et affecte la Division de Recherche Opérationnelle en Santé (DROS) les missions de :

- Suivi d'études de recherche clinique ;
- Promotion de la recherche opérationnelle et diffusion des résultats sur la lutte contre les maladies, la santé reproductive et la nutrition, en liaison avec les administrations concernées ;
- Veille sur les questions relatives à la bioéthique, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- Traduction de résultats de recherche convaincants en propositions d'action ;

- Mise en place de réseaux scientifiques et promotion de l'éthique ;
- Relations avec l'enseignement supérieur dans le domaine de la formation initiale et continue.

Ces différentes missions illustrent le caractère multisectoriel de la mise en œuvre et de l'encadrement de la recherche pour la santé humaine.

Au sein du Ministère de la Santé (MINSANTE), plusieurs acteurs travaillent dans le domaine de la recherche pour la santé humaine. Ceux-ci inclus:

- De la Commission consultative scientifique et stratégique pour la recherche en santé (CCSSRS) [6] ;
- Organes de l'Autorité Nationale de Réglementation Pharmaceutique qui sont l'Inspection Générale des Services et Laboratoires Pharmaceutiques (IGSPL), la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires (DPML), la Division de la Recherche Opérationnelle (DROS). la Direction de la Santé Familiale (DSF), le Laboratoire National de Contrôle Qualité du Médicament et d'Expertise (LANACOME) ;
- Directions techniques : Division de la Recherche Opérationnelle (DROS), Direction de l'Organisation des Soins et des Technologies de la Santé (DOSTS), Direction de la Pharmacie, de la Médecine et du Laboratoire (DPML), Direction de la Santé Familiale (DSF), Direction de la Lutte contre les Maladies, Epidémies et Pandémies (DLMEP), Direction de la Promotion de la Santé (DPS), Direction des Ressources Humaines (DRJH) ;
- Programmes prioritaires de santé : Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS), Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT), Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), Programme Elargi de Vaccination (PEY), etc. ;
- Laboratoires : LANACOME, Laboratoire National de Sécurité Publique (LNSP), Centre Pasteur du Cameroun (CPC), Centre International de

Référence Chantal BIYA pour la recherche sur la prévention et le traitement du VIH/SIDA (CIRCB) ;

- Formations en santé servant de site de mise en œuvre de recherches pour la santé humaine ;
- Districts sanitaires ;
- De la communauté à travers les structures de dialogue : Observatoire National de Santé Publique (ONSP), Fonds Régional de Promotion de la Santé, Comité de District de Santé, Comité de Santé, Organisations de la Société Civile, etc.

Il existe également plusieurs structures et plateformes de diffusion des connaissances générées dans le secteur de la santé dont :

- L'Unité d'Information Sanitaire (CIS) chargée de : la conception, le suivi et la mise en œuvre du système d'information sanitaire, la collecte et le traitement des données statistiques sanitaires, l'établissement de bases de données relatives à la santé publique, l'élaboration d'indicateurs nationaux de santé, l'élaboration de Comptes Nationaux Publics de Santé, la mise à jour de la carte sanitaire, la sécurité des données statistiques et la publication des données de santé en lien avec l'ONSP ;
- Le Centre de Documentation Numérique du Secteur de la Santé (CDNSS) accessible à l'adresse web www.cdnss.minsante.cm, qui est une plateforme gérée par le DROS visant à diffuser les résultats des travaux de recherche en santé humaine et d'autres documents produits dans le secteur de la santé ;
- Le portail web de l'Observatoire National de Santé Publique (ONSP), disponible sur www.onsp.minsante.cm. qui vise à produire et diffuser des informations sur la santé de la population afin d’éclairer les politiques ;

- Le réseau scientifique Cameroun HIV Research Forum (CAM-HERO) qui regroupe les chercheurs travaillant sur le VIH ; dans le but de mutualiser les ressources, de partager les informations et les expériences afin de capitaliser et de valoriser les résultats de la recherche sur le VIH ;
- Le Forum Camerounais de Recherche en Santé (CAHREF) qui organise tous les deux ans, des sessions de diffusion des résultats de la recherche fondamentale et appliquée ;
- Le Centre de Développement des Bonnes Pratiques de Santé (CDBPS) de l'Hôpital Central de Yaoundé qui documente les bonnes pratiques de santé et les traduit en Notes d'Information Stratégique (NIS).

1.2.2. Autres parties prenantes

Au Cameroun, d'autres structures interviennent dans la mise en œuvre des activités de recherche en santé humaine :

- Départements Ministériels : Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MINRESI), Ministère de l'Enseignement Supérieur (MINESUP), Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER), Ministère de l'Elevage, de la Pêche et des Industries Animales (MIN EPIA), Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique (MINEP), Ministère des Affaires Sociales (MINAS), Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF) ; Ministère de la Défense (MINDEF), etc. ;
- Institutions de formation académique et professionnelle publiques ou privées : universités (facultés de médecine et des sciences biomédicales, facultés des sciences, facultés des sciences humaines, autres facultés spécifiques) et écoles de formation professionnelle (écoles d'infirmières et autres personnels de santé), etc.
- Instituts et laboratoires de recherche : Institut National de Statistique (INS), Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD),

Institut de Recherche Médicale et d'Etudes des Plantes Médicinales (IMPM), Institut de Recherche Agronomique pour le Développement (IRAD), Centre de Recherche sur Maladies Émergentes et Ré-émergentes (CREMER), Centre de Recherche sur la Santé des Armées (CRESAR), Bureau Central de Recensement et d'Etude de la Population du Cameroun (BUCREP), etc. ;

- **Partenaires de développement**: Organisation mondiale de la santé (OMS), Partenariat des pays européens et en développement sur les essais cliniques (EDCTP), Banque mondiale, Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC), Monde Programme alimentaire (PAM), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), Agence allemande de coopération internationale au développement (GIZ), Agence française de développement (AFD), Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Médecins Sans Frontières (MSF), ICAP de l'Université de Columbia, Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF), Helen Keller Intonational (HKI), Care International, Plan International Cameroun, Clinton Health Access Initiative (CHAI), Research Institute for Development (IRD), Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes Endémies en Afrique Centrale (OCEAC), École de Santé Publique Johns Hopkins Bloomberg, Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Hépatites Virales (ANRS), etc.
- Les comités d'étude : Comité national d'éthique de la recherche pour la santé humaine NERSH), Comités régionaux d'éthique de la recherche pour la santé humaine (CRERSH) et Comités institutionnels d'éthique de la recherche pour la santé Humahie (CIERSH) ;

- Partenaires de mise en œuvre : Association nationale camerounaise pour le bien-être familial (CAMNAFAW), Service de santé de la Convention baptiste du Cameroun (CBCHS), Horizon Femmes, Réseau national des jeunes positifs (RECAJ+), Réseau camerounais des associations de personnes vivant avec le VIH/SIDA (RECAP), Care et Programme de Santé (CHP), Conseil des Héritiers Mission Internationale (CHIMISSONS), etc.

1.3. INTERACTIONS ENTRE PARTIES PRENANTES

La collaboration entre les acteurs de la recherche pour la santé humaine est essentielle. Dans un esprit de cohésion, il permet de renforcer la protection des sujets. la recherche et la communauté ainsi que les capacités et la protection des membres de l'équipe de recherche. Il contribue également à améliorer le respect de la réglementation en matière de recherche. Ces interactions se déroulent à la fois sur le plan administratif et technique.

1.3.1. Interactions entre les comités d'éthique et le MINSANTE

-Administrativement

Suite au décret portant création, organisation et fonctionnement des comités d'éthique de la recherche en santé humaine au sein des entités placées sous la tutelle du ministère de la Santé publique [2], le ministre de la Santé :

- Mettre en place les comités d'éthique et déterminer leur composition par décision ;
- Nomme par décision le secrétaire permanent du comité national d'éthique de la recherche pour la santé humaine ;
- Allouer un budget et un financement opérationnel ;
- assure l'audit externe des comités d'éthique ;
- veille à l'application effective des textes régissant les comités d'éthique ;

- veiller, à travers la DROS (Délégation Régionale de la Santé Publique), à ce que les projets de recherche mis en œuvre au Cameroun soient évalués sur les aspects éthiques et scientifiques par des comités d'éthique compétents et indépendants [7] ;
- reçoit du CNERSH et duCERSH sur une base trimestrielle, les rapports de séances et la liste des projets de recherche soumis à évaluation.

-Sur le plan technique

- Le Comité National d'Éthique, dans le cadre de l'évaluation scientifique des projets de recherche tels que les essais cliniques, vérifie qu'ils sont conformes aux exigences nationales et internationales.

1.3.2. Interactions entre les comités d'éthique et les chercheurs/institutions de recherche

Dans ce contexte, les comités d'éthique doivent :

- assurer la sensibilisation des chercheurs aux procédures d'évaluation harmonisées des projets de recherche;
- assurer un suivi éthique de la recherche ;
- assurer un partenariat collaboratif au sein des équipes de recherche sur la base d'un protocole d'accord.

1.3.3. Interactions entre équipes de recherche dans le cadre d'études multicentriques

Sept critères de référence semblent essentiels dans les études multicentriques pour un partenariat collaboratif. En effet, il faut s'assurer que :

- le projet est porté par un chercheur principal local rattaché à une institution reconnue et basé au Cameroun :
- les responsables de la structure de mise en œuvre sont informés des objectifs et seront impliqués dans le processus de diffusion des résultats et, le cas échéant, dans le suivi des participants aux essais cliniques après la recherche ;

- le respect et la reconnaissance des valeurs distinctives, de la culture et des pratiques sociales de la communauté d'accueil sont intégrés dans la conception et la mise en œuvre de l'étude
- les disparités liées au projet de recherche entre les chercheurs, les promoteurs/commanditaires et la communauté d'accueil sont minimisées ;
- la communauté dans laquelle la recherche est menée est la principale bénéficiaire des bénéfices découlant de la mise en œuvre de la recherche ;
- les bases de données sont accessibles aux chercheurs locaux grâce à des accords de partage de données et de matériel biologique ;
- la collaboration garantit également le transfert de connaissances, de technologies et le renforcement des capacités des chercheurs locaux [8].

1.3.4. Interactions entre les comités d'éthique et la communauté

Conformément à la ligne directrice 7 des Lignes directrices internationales d'éthique pour la recherche en santé impliquant des participants humains (COIMS), il est recommandé aux comités d'éthique :

- tenir un fichier des acteurs communautaires ou des organismes communautaires impliqués dans la recherche afin que, le cas échéant, ils participent à l'évaluation de certains aspects de la recherche :
- impliquer les acteurs communautaires dans la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la recherche, la conception et le processus d'obtention du consentement éclairé des participants à la recherche.

1.3.5. Interactions entre les différents comités d'éthique (CNERSH - CERSH - CIERSH)

Le CNERSH interagit avec les comités d'éthique régionaux et institutionnels dans les domaines suivants :

- un soutien à la sélection de leurs membres ;

- le renforcement des capacités de leurs membres ;
- suivi et évaluation de leur fonctionnement.

A travers cette collaboration, le CERSH et le CIERSH :

- transmettre trimestriellement leurs rapports et procès-verbaux de séances ainsi que leurs rapports annuels d'activités au CNERSH ;
- demander l'expertise du CNERSH si nécessaire ;
- saisir le CNERSH de toute demande d'obtention d'une autorisation éthique ne relevant pas de sa compétence.

1.3.6. Interactions entre le Secrétariat Technique, le bureau et les membres du comité d'éthique

Cette collaboration [9] est efficace à travers :

- préparation des séances;
- suivre la mise en œuvre des recommandations du Comité ;
- la transmission des demandes d'habilitation éthique ;
- gestion administrative et financière du fonctionnement du CERSH.

1.3.7 Interactions entre les comités d'éthique et les partenaires de développement

L'interaction entre ces entités doit se limiter à un appui technique, notamment dans le renforcement des capacités des membres du CERSH pour éviter les conflits d'intérêts.

CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTION DES COMITÉS D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE POUR LA SANTÉ HUMAINE

La principale responsabilité d'un comité d'éthique de la recherche pour la santé humaine (CERSH) est de protéger les participants à la recherche. Elle doit également tenir compte des risques et des bénéfices potentiels pour la communauté dans laquelle se déroule une étude, son but ultime étant de promouvoir le respect des normes éthiques établies dans la recherche en santé humaine. À cette fin, le CERSH examine les protocoles de recherche impliquant des sujets humains pour s'assurer qu'ils respectent les principes éthiques reconnus localement et internationalement, et participe au suivi des études en cours de mise en œuvre.

II.1. ORGANISATION DES COMITÉS D'ÉTHIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTÉ HUMAINE

11.1.1. Statut juridique du CERSH

Les Comités d'Éthique de la Recherche en Santé Humaine sont des structures permanentes et indépendantes au niveau central et régional du Ministère de la Santé Publique (MINSANTE), des établissements de recherche et des établissements de santé.

Le fonctionnement de ces comités n'obéit pas aux textes régissant celui des groupes de travail des comités ministériels et des comités interministériels institués par le décret fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des comités et groupes de travail [10].

Le Ministre chargé de la Santé Publique représente les différents comités d'éthique (CNESRH, ORERSH, CIERSH) dans tous les actes de la vie civile. Il les crée et note la composition de leurs membres. Il peut intenter une action en justice si nécessaire. Le cas échéant, il peut déléguer son pouvoir de représentation à toute personne ou structure de son choix. Toutefois, la responsabilité personnelle ou pénale pourra être engagée pour toute personne ou structure ayant directement commis un acte incriminé.

II.1.2. Structuration des différents Comités d'Éthique

Un CERSH est composé d'un bureau, d'un secrétariat et de membres [2]. Le bureau comprend un président et un vice-président élus à la majorité simple des suffrages exprimés par leurs pairs, ou par consensus pour une durée de trois (03) ans renouvelable deux (02) fois. Le fonctionnement du CNERSH est assuré par un secrétariat technique placé ; sous la responsabilité du président.

❖Structuration du secrétariat technique

Le secrétariat technique du CNERSH est coordonné par un Secrétaire assisté en permanence de quatre (04) agents dont un (01) comptable, un (01) juriste, un (01) secrétaire et un (01) responsable technique, désignés par le Ministre chargé de Santé publique.

❖Structuration des secrétariats d'un CERSH

Le CRERSH et le CIERSH disposent chacun d'un secrétariat dirigé par un secrétaire, et qui est mis en place par leurs présidents. Les secrétariats du CRERSH et du CIERSH assurent les mêmes missions que le secrétariat technique du CNERSH, à savoir :

- Gérer le courrier du comité

-réception des informations utilisateurs et contrôle de conformité des fichiers reçus ;

-la collecte, l'enregistrement et la codification des dossiers de demande d'habilitation physique ;

- l'inscription et la répartition des comités ;

-la reproduction des actes individuels et de tout autre document de service ;

-notification aux utilisateurs des documents signés ;

-la création de fichiers électroniques ;

-gérer la conformité de la forme du dossier administratif (en-tête, cachets et éventuellement logo) ;

-tenir un registre spécifique des protocoles d'essais cliniques soumis ;

-tenir un registre général des protocoles de recherche soumis et approuvés ;

-présenter le rapport d'activités du comité et les transmettre périodiquement au Ministre chargé de la Santé à travers la Division de la Recherche Opérationnelle en Santé.

- préparer les séances;
- suivre la mise en œuvre des recommandations du comité;
- proposer un plan d'action budgétisé ainsi que le calendrier annuel des séances à soumettre au comité;
- participer au contrôle des dépenses du comité en cosignant les comptes bancaires ;
- tenir la comptabilité du comité ;
- veiller au respect de la réglementation dans le processus d'évaluation éthique, de la réception au suivi des protocoles de recherche ;
- contribuer à la mobilisation des ressources pour le fonctionnement du comité ;
- assurer le renforcement des capacités des membres du comité ;

- accomplir toutes autres missions qui lui sont confiées par son autorité de tutelle,

❖Rôle du président

Le président veille au bon fonctionnement du comité d'éthique.

A cet effet, il :

- représente officiellement le comité;
- convoque et préside les séances (ordinaires et extraordinaires) du comité ;
- planifie l'ordre du jour;
- organise le suivi des projets soumis à évaluation et répond aux questions des chercheurs relatives aux décisions du comité ;
- signe tous les documents relatifs aux rapports de réunion et aux autorisations éthiques ;
- organise la communication publique du comité pour les questions ou préoccupations éthiques générales liées à l'évaluation des protocoles de recherche.

Au niveau national, le président du CERSH doit organiser l'encadrement des Comités régionaux et des Comités d'éthique institutionnels.

❖Rôle du vice-président

Le vice-président:

- remplace le président en son absence ;
- assiste le président dans ses fonctions ;
- exécute toutes les autres missions qui lui sont confiées par le président.

❖Rôle des membres du CERSH

De manière générale, les membres des comités d'éthique de la recherche en santé humaine évaluent les protocoles de recherche qui leur sont soumis sur

le plan scientifique et éthique. Dans le cadre de cette évaluation, ils doivent s'assurer que toute demande d'habilitation éthique est formulée dans le respect de la dignité, du bien-être, de la sécurité, de l'intégrité et des droits de l'homme et dans le strict respect de la procédure d'évaluation des protocoles de recherche.

❖Qualité, nombre, mandat des membres d'un CERSH

Le tableau ci-dessous précise pour chaque type de comité d'éthique, la qualité, le nombre de membres, le nombre et la durée de chaque mandat [2, 11].

Tableau 1 : composition et durée des mandats selon le type de comité

Types de comités	Nombre de membres titulaires	Nombre de membres suppléants	Durée du mandat des membres	Nombre de renouvellements de mandat
CNERSH	20	/ /	03 ans	02
CRERSH	07	05	03 ans	02
CIERSH	07	05	03 ans	02

❖Sexe des membres d'un CERSH

Le genre féminin doit constituer au moins 30% des membres des différents comités d'éthique.

❖Profils des membres du CERSH

Chaque membre du CERSH doit posséder une intégrité morale reconnue. En plus de cela, il est obligatoire de présenter l'un des profils décrits ci-dessous [2]. Le CNERSH doit avoir les profils suivants :

- Un médecin avec au moins 5 ans'expérience en évaluation éthique;
- Un expert en évaluation éthique et scientifique des essais cliniques avec une expérience d'au moins 05 ans ;
- Un expert en évaluation éthique et scientifique des études épidémiologiques observationnelles avec une expérience d'au moins 05 ans ;
- Un expert en évaluation éthique et scientifique des études en sciences sociales avec une expérience d'au moins 05 ans ;
- Un expert en évaluation méthodologique et statistique des protocoles de recherche avec une expérience d'au moins 05 ans ;
- Un expert en droit de la santé avec une expérience d'au moins 05 ans ;
- Un représentant de l'ordre des médecins,
- Un représentant de l'ordre des pharmaciens
- Un représentant de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes ;
- Un représentant de l'ordre des professionnels de la santé ;
- Un représentant de l'association des tradipraticiens ;
- Un représentant du ministère chargé de la recherche scientifique et de l'innovation ;
- Un expert chargé des affaires juridiques du Ministère de la Santé Publique ;
- Un représentant du ministère chargé du renseignement supérieur ;
- Un représentant de l'Institut de Recherches Médicales et d'Etudes des Plantes Médicinales ;
- Un représentant des facultés de médecine de l'État ;
- Deux représentants des associations de patients ;
- Un représentant de la Société Civile ;
- Un représentant des confessions religieuses.

Le CERSH et le CIERSH présentent les profils suivants pour les membres titulaires et suppléants :

- Trois médecins ;
- Spécialiste en sciences sociales ;
- Un membre de la communauté;
- Un représentant des confessions religieuses ;
- Un représentant de personnes possédant des compétences particulières dans les domaines des sciences fondamentales, de la pharmacie, de l'éthique/bioéthique, de la biostatistique, de la méthodologie de la recherche ou de la santé publique.

Le CIERSH doit compter au moins 20 % de membres non affiliés à l'établissement.

II.1.3. Experts indépendants ou consultants ad hoc

Chaque comité d'éthique doit disposer d'une liste d'experts pouvant contribuer à l'évaluation de protocoles spécifiques [2]. Les raisons pour lesquelles une expertise supplémentaire ou spéciale peut être recherchée comprennent, sans s'y limiter, la nécessité de :

- fournir une expertise spécialisée pour l’examen de protocoles spécifiques ;
- apporter des connaissances statistiques, méthodologiques ou spécifiques supplémentaires sur les populations potentiellement vulnérables ;
- fournir des informations complémentaires sur un ou plusieurs aspects juridiques, éthiques, scientifiques ou socioculturels avant de réaliser des recherches ;
- examiner les protocoles ou assister à des réunions pour offrir une formation ou fournir des informations sur toute question d’intérêt général

Un expert indépendant ou un consultant ad hoc d'un comité d'éthique n'en est pas membre.

11.1.4. Formation pour les membres du CERSH

Les membres du CERSH et les autres personnes responsables de l'évaluation, de l'approbation et du suivi sur le terrain des projets de recherche menés avec des participants étrangers doivent s'imprégner des principes fondamentaux d'éthique, du cadre juridique et réglementaire existant, des lignes directrices suivies, des politiques applicables et des principes éthiques [7] . La formation des membres du CERSH est initiale (membres nouvellement sélectionnés) et continue (anciens membres). Cette formation peut être réalisée dans le cadre de la coopération entre les Comités et avec les partenaires au développement, mais également à d'autres occasions favorables.

❖Formation initiale (après installation)

Avant de prendre officiellement leurs fonctions, les membres nouvellement nommés et sélectionnés doivent bénéficier d’une formation initiale en éthique de la recherche afin de renforcer leur expertise.

Cette formation initiale doit couvrir au minimum les points suivants :

- les modalités de réception, d'évaluation et de suivi des protocoles de recherche ;
- les différents aspects de l'évaluation éthique des protocoles ;
- le système d'évaluation éthique du Cameroun ;
- organisation et fonctionnement d'un comité d'éthique;
- textes et directives locaux et internationaux ;
- les principaux principes fondamentaux de l'éthique de la recherche ;
- bonnes pratiques cliniques (bonnes pratiques cliniques tirées de la dernière Conférence Internationale sur l'Harmonisation (ICH) e6 (r2) [12] pour les membres du comité du CNERSH) ;

- transparence, sécurité et partage des données personnelles et biologiques de recherche (pour les membres du CNERSH),

Les canaux de formation peuvent être :

- cours en ligne avec ou sans certificat ;
- séminaires de formation;
- formation académique/universitaire;
- immersion professionnelle dans un autre comité d'éthique.

❖**Formation continue**

Elle doit être organisée en fonction de besoins exprimés ou dans le but d'élargir les compétences des membres du comité dans un domaine précis de l'évaluation éthique. Cela peut être fait selon un calendrier précis.

Elle peut porter soit sur le contenu de la formation initiale, soit sur les bonnes pratiques cliniques et les bonnes pratiques de laboratoire, les essais cliniques relatifs aux médicaments, vaccins et dispositifs médicaux et les essais sur le terrain ou tout autre domaine d'intérêt.

N.-B.; Le secrétariat du CERSH conserve des copies des curriculum vitae et des preuves de formation de tous les membres.

II.1.5. Financement du CERSH

Le financement des activités du CERSH (séances d'évaluation éthique, veille éthique, renforcement des capacités, fonctionnement du secrétariat, etc.) peut provenir de plusieurs sources [2] dont :

- subventions de l'État;

- paiement direct des frais d'évaluation éthique des protocoles de recherche ;
- les dons et legs ;
- la mobilisation de fonds, à travers la réponse à des appels à projets ;
- les revenus de la formation et toutes autres ressources qui pourraient y être allouées.

Cependant, le CERSH ne doit accepter aucun financement provenant des sources suivantes :

- chercheurs et/ou promoteurs de protocoles de recherche ;
- institutions ou structures de tutelle lorsque ces financements proviennent de lignes budgétaires non formellement dédiées.

II.1.6. Frais d'évaluation éthique en sessions ordinaires et extraordinaires

Les tarifs applicables au niveau du CNERSH. Le CERSH et le CIERSH sont fixés en fonction du type de protocole à évaluer, de la source de financement et du choix de la séance comme résumé dans le tableau ci-dessous. Ces honoraires servent non seulement à couvrir les frais de préparation et de tenue des réunions du comité d'éthique pour l'évaluation des protocoles de recherche, mais également au suivi de la mise en œuvre des recherches dans le domaine. Ils se répartissent selon la clé de répartition ci-dessous :

- 60 % représente les frais de votre séance de révision de protocole de recherche ; don 10% de ce montant doit être utilisé pour la formation des membres du comité;
- 40% représentent les frais de suivi et d'évaluation (Division Opérationnelle de Recherche en Santé du MINSANTE et Comité d'Ethique), dont 10% de ce montant doit être utilisé pour le fonctionnement du comité d'éthique.

Tableau 2 : Frais d'examen éthique par type de protocole, source de financement et type de séance

Type de protocole	Source de financement	Type de séance	Frais d'évaluation en
Essais cliniques de phase 1 ou 2	Financement externe ou organisation	Ordinaire	1 000 000
	International	Extraordinaire	Je 500 000
	Institution Camerounaise	Ordinaire	500 000
		Extraordinaire	750 000
	Chercheur indépendant / praticien traditionnel	Ordinaire	100 000
		Extraordinaire	150 000
Essais cliniques de phase 3 ou 4, Essais terrain, enquêtes nationales (dans plusieurs régions), études multicentriques	Financement externe ou organisation internationale	Ordinaire	600 000
		Extraordinaire	800 000
	Institution camerounaise	Ordinaire	400 000
		Extraordinaire	600 000
	Étudiant	Ordinaire	100 000
		Extraordinaire	150 000
	Chercheur indépendant/	Ordinaire	100 000
	praticien traditionnel	Extraordinaire	150 000

	Ordinaire	400 000

Attention :

- les tarifs applicables détaillés ci-dessus s'appliquent également aux protocoles de recherche promus par les programmes de santé ;
- en cas de renouvellement de l'habilitation éthique, ces frais sont réduits de moitié :
- en cas de modification majeure, les frais applicables sont ceux prévus dans le tableau ci-dessus ;
- en cas d'examen en cours et de précisions demandées par le Comité d'éthique, aucun paiement complémentaire (honoraires) n'est demandé aux chercheurs ;
- l'habilitation éthique est valable pour la durée du projet communiquée par le chercheur ;

11.2. FONCTIONNEMENT DU CERSH

II.2.1. Mise en place d'un CERSH

Initiateur	MINSANTE, Délégation Régionale de la Santé Publique (DRSP), Chef de l'Institution
Intervenant(s)	Commission Consultative Scientifique et Stratégique de la Recherche en Santé (CCSSRS), CNERSH, Responsable de la structure/Conseil d'Administration

Conditions générales[2]

- La création et l'instauration d'un Comité d'Éthique de la Recherche en Santé Humaine (CERSH) des structures relevant du MINSANTE sont prononcées par un acte du Ministre chargé de la Santé Publique, le cas échéant, par le conseil d'administration des établissements publics d'un hôpital. nature.

- La mise en place d'un Comité Régional d'Ethique de la Recherche en Santé Humaine (CRERSH) est initiée par le Délégué Régional en charge de la Santé Publique.
- La mise en place d'un Comité Institutionnel d'Éthique de la Recherche en Santé Humaine (CIERSH) est initiée par le responsable de l'établissement.
- L'acte de création d'un CERSH résulte de l'évaluation de la demande de création présentée par l'initiateur au Ministre chargé de la santé.
- L'évaluation des dossiers de demande de reconnaissance par les comités régionaux et institutionnels est réalisée conjointement par la Direction de la Recherche en Santé Opérationnelle (DROS) et le Comité National d'Éthique de la Recherche en Santé Humaine (CNERSH).

❖Conditions spécifiques

L'observation de la composition du Comité National d'Ethique de la Recherche pour la Santé Humaine (CNERSH) relève de la compétence du Ministre chargé de la Santé Publique après avis du Tableau 1 : composition et durée des mandats selon le type de comité (CCSSRS).

❖Description de la procédure

Les étapes de mise en place d'un CERSH sont les suivantes :

- appel à candidatures pour le recrutement de membres ; indiquant les conditions d'éligibilité, la date limite et le lieu de dépôt des dossiers effectués respectivement par le Ministre de la Santé Publique pour le CNERSH ; Délégués Régionaux des Délégués de Santé Publique pour le CERSH ; le chef de l'hôpital ou de l'établissement de recherche concerné pour le CIERSH ;
- sélection des membres du CERSH et du CIERSH par une commission qui comprend au moins un représentant du CNERSH et un représentant du

DROS (voir section 11.2.2. Procédure de sélection des membres du CERSH) ;

- tenue de l'Assemblée Constitutive du Comité avec élection du bureau exécutif par vote ou par consensus avec comme observateurs/facilitateurs au moins un représentant du CNERSH et un représentant de la DROS ;
- transmission du dossier d'observation du CERSH et du CIERSH au Ministre chargé de la Santé Publique et au responsable de la structure pour les structures relevant de la tutelle du Ministère de la Santé Publique. Ce fichier est composé de :
    - une demande d'observation adressée au ministre chargé de la santé publique, le cas échéant aux conseils d'administration des établissements publics hospitaliers ;
    - le procès-verbal de l'Assemblée Constitutive du CERSH accompagné des principales résolutions, daté et signé par le rapporteur et le président de séance ;
    - la feuille de présence des participants à l'Assemblée Constitutive du comité comprenant : noms et prénoms, structure, numéros de téléphone, adresse e-mail et adresse ;
    - la liste complète des membres désignés pour la création du Comité incluant leurs noms et prénoms ; profession, structure d'accueil et 1 statut au sein du comité (titulaire ou suppléant) ;
    - le Curriculum Vitae de chaque membre ;
    - la composition du bureau exécutif (noms, prénoms et fonctions) ;
    - les éléments de domiciliation du comité (siège, contacts/adresse, etc.).

- Mise en place dudit CERSH (voir section 11.2,3. Procédure de mise en place d'un comité d'éthique).

❖Documents justifiant la procédure :

- la demande d'observation du CERSH ;
- le procès-verbal de l'Assemblée Constitutive du CERSH ;
- la feuille de présence des participants à l'Assemblée Constitutive du Comité ;
- le Curriculum Vitae de chaque membre ;
- les éléments de domiciliation du Comité.

II.2.2. Sélection des membres du CERSH

Initiateur:	Responsable en charge de la structure DRSP/Chef du MINSANTE/DRSP/Institution
Intervenant(s) :	MINSANTE/DRSP/Chef d'établissement, membres du comité de sélection

- **Calendrier de sélection des membres**

La sélection des membres se fait dès la constitution du Comité, puis un semestre avant la fin du mandat réglementaire des membres, lorsqu'il s'agit d'un renouvellement [13],

- **Commission de sélection des membres**

Le responsable en charge de la structure souhaitant procéder à la sélection des membres, désigne par note une commission indépendante et compétente pour l'examen des dossiers de candidature comme suit :

- le Ministre de la Santé Publique du CNERSH ;
- le Délégué Régional de Santé Publique du CERSH ;

- Le responsable de l'hôpital/établissement/recherche du CIERSH

❖**Description de la procédure**

- Appels à candidatures, indiquant les conditions d'éligibilité, la date limite et le lieu de dépôt des dossiers lancés respectivement par le Ministre de la Santé Publique de la Public pour le CNERSH, les Délégués Régionaux de la Santé Publique pour le CERSH ; le chef de l'établissement hospitalier ou de recherche concerné pour le CIERSH.
- clôture de l'enregistrement des dossiers de candidature dans un délai de trente (30) jours suivant l'appel à candidature.

Ce fichier comprend :

- une demande de candidature adressée au gestionnaire qui a lancé l'appel à candidatures ;
- un CV;
- une lettre de motivation ;
- tout document prouvant l'expérience du candidat ;
- une lettre de désignation signée par un dirigeant de l'établissement dont il est le représentant, pour les membres représentant les établissements.

• Traitement des dossiers de candidature : les différents dossiers de candidature sont évalués à l'aide d'une grille permettant d'explorer les points suivants :
    - les conditions d'éligibilité énoncées ci-dessus ;
    - Formation sur l'éthique et la recherche (durée estimée en heures) ;
    - contributions à l'éthique de la recherche;
    - expérience en matière de protection des participants à la recherche;

- lieu de résidence;
- genre
- adhésion institutionnelle;
- la fonction administrative ;
- appartenance socioculturelle et religieuse.

- Classement des candidats :

Elle se fait selon les critères de priorité qui sont : le rang occupé après étude du dossier ; sexe, affiliation institutionnelle, lieu de résidence, appartenance socioculturelle et religieuse.

- Etablissement de la liste des membres retenus par le secrétariat.
- Transmission de la liste des membres retenus par l'autorité compétente au Ministre chargé de la Santé pour décision de constitution.
- **Documents justifiant la procédure**
    - Appel à candidatures pour la sélection des membres du CERSH ;
    - note de nomination des membres de la commission de sélection ;
    - dossiers de candidature ;
    - grille d'évaluation des dossiers de candidature ;
    - procès-verbaux d'évaluation/étude des dossiers de candidature ;
    - liste des membres sélectionnés.

II.2.3. Installation du CERSH

Initiateur;	Responsable en charge de la structure (MINSANTE/ DRSP/'Chef d'établissement)
Intervenant(s):	DROS/DRSP/ÇNERSH/Institution, membres nouvellement sélectionné suite à l'appel à candidatures

La création du bureau et des membres d'un comité d'éthique est soumise à la décision du Ministre chargé de la Santé créant ledit CERSH [2].

Lors de cette cérémonie d'installation du CERSH, la fonction de président de séance est exercée par le Ministre de la Santé Publique ou son représentant.

❖Description de la procédure

Le MINSANTE établit le calendrier d'installation du CERSH, et son

bureau par une note officielle au moins 30 jours avant la date prévue pour l'installation. Cette note mentionne le lieu, la date et l'heure.

Le Secrétaire Permanent pour le CNERSH, la DRSP pour le CERSH, et le chef d'établissement pour le CIERSH, sont chargés de convoquer par écrit les membres et le bureau dudit comité dans un délai d'au moins 21 jours avant la date du installation. La convocation doit mentionner la date, le lieu et l'heure de la réunion, et indiquer les questions portées à l'ordre du jour.

L'ordre du jour comprend les points suivants :

- vérification de la présence des membres sélectionnés et du bureau élu ;
- message de bienvenue du responsable local ;
- présentation du rôle de l'organisme en charge de la recherche opérationnelle en santé ;
- présentation des attributions dites du comité d'éthique ;
- lecture de la décision du MINSANTE constatant la composition des membres dudit comité ;
- discours d'installation des membres et de bureau par le MSP ou son représentant ;
- poignée de main de félicitations avec les membres du bureau ;
- élection du bureau du comité;

- discours du président du comité nouvellement installé ;
- livraison d'outils et de matériel au bureau du comité, si disponible ;
- des photos de famille.

❖**Documents justifiant la procédure**

- décision du Ministre de la Santé constatant la composition du CERSH ;
- Feuilles de présence ;
- Minutes d'installation ;
- Contribution à la mission ;
- Des photos

II.2.4 Renouvellement de mandat des membres du CERSH

Initiateur:	Responsable en charge de la structure (MINSANTE/ 'DRSP/Responsable de l'établissement)
Intervenant(s):	MINSANTE/DRSP/Chef de l'institution, Commission de sélection des membres

La durée du mandat des membres est de 03 ans [11], renouvelable deux fois sous réserve de l'approbation du comité de sélection des membres de la structure concernée.

La procédure de renouvellement est déclenchée six mois avant la fin du mandat en cours par le président du comité. Celui-ci informe par écrit l'autorité compétente de la nécessité de renouveler les membres du comité. Dans le cas contraire, l'autorité de contrôle engage le renouvellement.

Ce renouvellement s'effectue dans les mêmes conditions que celles préconisées pour la nomination desdits membres, à condition que le membre dépose son dossier de renouvellement de mandat dans les délais et conditions requis par l'appel à candidatures.

Les membres conservent leur siège jusqu'à la fin du processus de renouvellement de leur mandat, ou jusqu'à la désignation d'une personne susceptible de les remplacer le cas échéant.

❖**Description de la procédure**

- l'autorité compétente en informe par écrit le président du CERSH dans un délai n'excédant pas six mois.
- l'autorité compétente déclenche la procédure de création du comité (Voir procédure de création du CERSH),
- une passation technique de service est effectuée entre l'ancien et le nouveau siège en cas de changement.
- les procès-verbaux et les rapports y afférents sont transmis à l'autorité compétente.

- **Documents justifiant la procédure**
- lettre d'information de l'autorité compétente adressée au président du comité pour le renouvellement des membres du comité ;
- appel à candidatures pour la sélection des membres du CERSH ;
- dossiers de demande de renouvellement de mandat ;
- procès-verbaux et rapports associés

II.2.5. Remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé

Initiateur:	Président du CERSH
Haut-parleurs):	Président du CERSH, Autorité Compétente (MINSANTE/DRSP/Chef d'établissement)

Si un membre du CERSH souhaite démissionner [13], il doit en aviser le président par écrit, au moins trois mois avant la date effective de sa démission. Si un remplacement immédiat n'est pas nécessaire, la sélection du nouveau membre sera effectuée à la fin prévue du mandat.

Ce mode de remplacement s'applique également en cas d'absence prolongée (six séances consécutives) ou de décès d'un membre.

❖Description de la procédure

- le membre démissionnaire en informe par écrit le président du CERSH dans un délai d'au moins trois mois avant la date effective de sa démission ; le président du CERSH accuse réception de la lettre de démission ;
- le président du CERSH notifie à l'autorité compétente la démission d'un de ses membres ;
- l'autorité compétente organise le remplacement dudit membre (Voir procédure de sélection des membres du CERSH) ;
- le membre démissionnaire est remplacé lors d'une séance du comité par un membre suppléant dont le profil est le plus proche possible et après délibération du comité ;
- le procès-verbal et le rapport de séance doivent clairement mentionner les informations relatives au remplacement dudit membre démissionnaire ;
- une notification de remplacement est adressée à l'autorité compétente.

❖Documents justifiant la procédure

- lettre de démission du membre;
- lettre de notification adressée à l'autorité compétente par le président du CERSH ;
- procès-verbal et rapport de réunion mentionnant le remplacement du membre démissionnaire.

11.2.6. Révocation d'un membre

Initiateur: Président du CERSH

Intervenant(s) : Président du CËRSH, tous les membres, autorité compétente

---

- Un membre peut être révoqué par le comité [13] qui s'exprime à la majorité des 2/3 des membres présents ; une session ordinaire pour les raisons suivantes :
- absences prolongées aux sessions : six (06) absences injustifiées consécutives pendant un (01) an ;
- non-respect de la confidentialité, violences verbales et/ou physiques répétées,
- non-déclaration de situations de conflits d'intérêts.

❖Description de la procédure

- le président du CERSH a inscrit à l'ordre du jour d'une séance ordinaire, la délibération au sujet de l'évocation d'un membre ;
- le membre concerné doit être contacté par écrit huit (08) jours avant la tenue de cette séance pour lui fournir des explications sur le(s) manquement(s) qui lui sont reprochés ;
- les membres du comité expriment leur avis par vote, la décision de révocation est prise si le quota favorable à la révocation est de 2/3 des membres présents ;
- le président du CERSH adresse une lettre informant l'autorité compétente de la décision du CERSH, en joignant le procès-verbal des délibérations ;
- l'autorité compétente procède à la révocation par un acte motivé et la notifie au membre concerné ;
- l'autorité compétente organise le remplacement dudit membre (Voir procédure de remplacement des membres du CERSH).

❖Documents justifiant la procédure

- Convocation adressée au membre accusé par le président du CERSH ;
- justification écrite du membre convoqué ;
- procès-verbaux des délibérations ;
- lettre d'information sur la révocation d'un membre, adressée par le président du CERSH à l'autorité compétente ;
- lettre de décision de licenciement adressée par l'autorité compétente au membre du CERSH concerné.

II.2.7. Sélection d'experts et de consultants indépendants

- **initiateur:** **Président du CERSH**
- **Intervenant(s) :** **Président CERSH, Secrétariat Technique. Expert/consultant, autorité compétente**

Si nécessaire, le CEHSH peut faire appel à des experts externes pour l'évaluation d'un projet de recherche nécessitant des conseils spécifiques sur certains aspects [2,13].

Le ou les membres peuvent être invités à participer à une séance du comité, mais ils ne prennent pas part aux délibérations du comité.

- **La description de la procédure**

- Le secrétaire du CERSH et soumet au président le(s) expert(s) potentiel(s) à partir de la base de données d'experts disponible au secrétariat technique du comité, et recueille les informations suivantes sur le candidat, Nom, adresses personnelles et institutionnelles, profil et domaines. d'expertise. L'expert ne doit pas être affilié aux chercheurs ou à l'institution proposant les protocoles de recherche.
- le président du comité adresse une lettre d'invitation au(x) expert(s) dont le profil correspond au besoin exprimé dans le protocole à évaluer. Cette lettre précise tous les aspects de la dévaluation demandée (ex : éthique, scientifique, juridique, socioculturel, sociologique, anthropologique, etc.), ainsi que les délais accordés pour cette évaluation.

- Après avoir accusé réception de la demande d'expertise, le ou les experts doivent faire une déclaration écrite de conflit d'intérêts et signer également un engagement de respect de la confidentialité au secrétariat technique du comité ;
- le secrétariat technique, sur ordre du président, confie à l'expert contre décharge dans un registre spécifique, une copie du protocole de recherche à évaluer, ainsi qu'une grille d'évaluation du protocole contenant le(s) aspect(s) éthique(s) et/ ou scientifique(s) que le ou les experts seront amenés à examiner ;

  Dans un délai défini par le président du CERSH dans sa lettre d'invitation, le ou les experts adresseront au secrétariat technique du comité son ou ses rapports d'évaluation contre décharge dans un registre spécifique.

❖ **Documents justifiant la procédure**

- liste d'experts/base de données ;
- lettre d'invitation à l'expert du Président du CERSH formulaire de déclaration de conflits d'intérêts ;
- fiche de confidentialité;
- registre spécifique d'experts;
- Protocole d'étude;
- grille d'évaluation du protocole ;
- rapport d'évaluation du protocole

II.2.8. Elaboration et validation du budget CERSH

Initiateur:	Président du CERSH
Intervenant(s)	Président, Secrétariat Technique, membres du CERSH, autorité compétente

Le budget du CERSH [2, 9, 14-16] résulte d'un plan d'action annuel validé par le bureau et les membres du comité assistés des représentants de l'autorité compétente.

- **Description de la procédure**
- le secrétariat exprime les besoins nécessaires au bon déroulement de chaque activité ;
- le CERSH élabore un plan d'action. annuel détaillé;

- le secrétaire compile les besoins exprimés, prépare les documents relatifs à la réunion de validation du budget, notamment le rapport et le bilan financier de l'année n-1 ;
- le secrétariat et le bureau du CERSH préparent une proposition de budget qui doit comprendre les lignes suivantes : sources de revenus, frais de fonctionnement, frais de séance d'évaluation du protocole, frais de formation et évaluation des frais de suivi et de diffusion ;
- le président du CERSH signe la note de convocation à la réunion de validation ; une assemblée composée d'au moins un représentant de l'autorité compétente, des membres du CERSH et de toute autre personne de son choix ;
- le secrétaire présente la proposition de budget à valider lors d'une séance du CERSH ;
- l'assemblée amende, valide et adopte le projet de budget ;
- le budget validé est partagé avec l'autorité compétente.

- **Documents justifiant la procédure**
  - plan d'action avec proposition d'avant-projet de budget ;
  - procès-verbal de la réunion de validation du budget ;
  - rapport de la réunion de validation du budget ;
  - le budget validé par l'assemblée générale.

II.2.9. Recouvrement des recettes du CERSH

Initiateur:	**Président du CERSH**
Haut-parleurs):	**Président CERSH, Secrétariat Technique, comptabilité, autorité compétente**

La collecte des recettes se fait dans le respect de la réglementation en vigueur en matière de gestion financière.

Ces revenus peuvent provenir du paiement direct de frais d'évaluation des protocoles [16], de subventions de l'État, de dons et legs ou de frais institutionnels (overheads).

❖Description de la procédure

- le CERSH rend public son relevé d'identité bancaire et la grille tarifaire du protocole ;

- le chercheur verse à la banque où le compte est domicilié contre récépissé, le montant correspondant au protocole présenté ;
- le reçu de paiement est joint au dossier de soumission du protocole ;
- la confirmation des paiements (historique du compte) est présentée au CERSH lors de chaque séance ;
- le paiement est enregistré dans les pièces comptables CERSH,

❖**Documents justifiant la procédure**

- Coordonnées bancaires;
- bulletin de versement;
- documents comptables (livre de journal, rapport de trésorerie, historique du compte bancaire)

- **Description de la procédure pour les subventions, dons et legs des partenaires**

  - Les documents de subvention, de don et de legs sont présentés au comité par un représentant du bailleur ou du donateur.
  - le comité prend connaissance et valide le financement ;
  - le contrat est signé avec le bailleur suivant les clauses validées par les deux parties ;
  - les fonds sont transférés sur le compte CERSH ;
  - la confirmation du transfert est présentée au comité lors d'une séance;
  - Chaque paiement est enregistré dans les pièces comptables CERSH.

- **Documents justificatifs de votre démarche**

- les documents justifiant le financement ;
- rapport de réunion du comité incluant la validation du financement ;
- contrat signé entre le bailleur et le CERSH ;
- documents comptables (livre de journal, rapport de trésorerie, historique du compte bancaire).

- **Description de la procédure d'octroi des subventions de l'État**

L'allocation et la récupération de cette source de financement se font selon les dispositions de la loi de finances en vigueur.

- **Documents d'appui à la procédure de subvention d'évaluation**
- titres d'accréditation budgétaire;
- Acheter en ligne;
- bons d'engagement.

Gestion des dépenses du CERSH

Initiateur:	**Président du CERSH**
Haut-parleurs):	**Président Secrétaire et Comptable de la Commission du Contrôle Financier de l'Etat**

Tous les fonds générés et gérés par les comités d'éthique constituent des fonds publics et sont donc soumis aux règles de gestion et de comptabilité publique [14].

- Description de la procédure
- le président du CERSH est l'ordonnateur principal des dépenses ;
- les opérations financières dans les comptes sont soumises à l'exigence d'une triple signature du Président du Comité, du Secrétaire Permanent (CNERSH) ou secrétaire (CRERSH ou CIERSH) et du comptable ou de tout autre membre dûment désigné par le Président, le cas échéant ;
- le contrôle financier vérifie et valide l'alignement budgétaire des dépenses ;
- le comptable vérifie la conformité de la note de frais ;
- le comptable débourse et liquide toutes les dépenses ordonnées par le président ;
- la dépense engagée est inscrite au journal des dépenses ;
- les documents relatifs à chaque dépense exécutée sont conservés par le comptable qui en fait copie au président et au secrétariat technique du comité.

- **Documents justifiant la procédure**
- autorisation de dépenses;
- paquet de dépenses;
- livre de journal comptable.

II.2.11. Responsabilité du CERSH

Initiateur: Président du CERSH

Intervenant(s) : Président, secrétaire et comptable du comité, contrôle financier de l'État

À la fin de chaque exercice budgétaire, la responsabilisation constitue une étape essentielle du processus de gestion.

- **Description de la procédure**

- le comptable ou tout autre membre dûment désigné par le président du comité
- La déontologie établit tous relevés relatifs à la situation du compte bancaire et de toutes ressources allouées au CERSH et les transmet au secrétariat du comité ;
- le secrétaire permanent ou secrétaire prépare et présente le rapport financier de l'exercice écoulé ainsi qu'un rapport sur l'état du patrimoine du Comité [9] ;
- les membres du comité valident l'ensemble des documents financiers lors d'une séance au cours de laquelle l'autorité de contrôle du CERSH est représentée ;
- le président du CERSH peut ordonner un audit financier annuel réalisé par un expert indépendant.

- **Documents justifiant la procédure**

- rapports financiers;
- comptes d'emploi :
- évaluation de l'état du patrimoine ;
- relevé de comptes bancaires;
- paquet de dépenses;
- rapport d'audit financier, le cas échéant.

II.2.12. Conduite des séances/réunions du CERSH

Initiateur: Président du CERSH

Haut-parleurs): Membres du CERSH, secrétaire permanent/secrétaire

---

Le comité se réunit en séances ordinaires et extraordinaires.

- **La séance ordinaire**

Les séances ordinaires du comité se tiennent mensuellement. Le calendrier annuel est publié à l'avance au plus tard le 30 octobre de chaque année. En cas de modification du calendrier initial, le président du comité rendra publiques la ou les nouvelles dates au plus tard un mois avant la ou les dates modifiées.

Les séances se déroulent sur le principe du respect des aspects suivants : temps de parole, bienveillance et confidentialité.

Des experts indépendants peuvent être invités aux séances et/ou envoyer leurs commentaires sur des points ou des sujets qui leur sont demandés par la commission.

Des chercheurs principaux, des sponsors ou des chercheurs pourront être invités lors des séances pour apporter des précisions sur leurs projets si nécessaire.

- **Description de la procédure de la session ordinaire**

-le président du comité envoie un avis aux membres qui comprend le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la séance ;

-les convocations sont adressées par lettre, télécopie ou tout autre moyen laissant une trace écrite, par le Président au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la séance ;

-le président vérifie le quorum requis pour la tenue d'une séance soit 2/3 des membres présents ;

- Le président présente l'ordre du jour, qui est validé tel quel ou modifié par les membres ;

-les participants à la séance se présentent chacun individuellement :

-chaque évaluateur signe la déclaration de conflits d'intérêts et le formulaire de confidentialité ;

-le secrétaire présente la liste des protocoles à évaluer ;

-les évaluateurs présentent chacun leur rapport d'évaluation ;

-les membres du comité prennent leurs décisions par consensus ou par vote (voir procédure de décision Pxx) ;

-le secrétaire permanent établit et présente un compte rendu de séance à la fin des travaux ;

-les membres approuvent et valident le procès-verbal de la séance.

Documents justificatifs de la procédure

- lettre d'invitation des membres du CERSH;
- Ordre du jour de la 85e séance ;
- Liste de présence aux séances ;
- procès-verbal de séance,

- **Description de la procédure pour la session extraordinaire**

Il s'agit d'une séance dont la nécessité est dictée par une situation d'urgence sanitaire et/ou administrative documentée [13]. Les urgences sanitaires sont définies comme l'apparition ou la menace imminente d'une maladie ou d'une urgence. état de santé qui présente un risque important de survenance de nombreux incidents de destruction d'installations. invalidité humaine, permanente ou de longue durée. Ils peuvent avoir des causes [17], notamment (séparément ou en combinaison) :

- les épidémies/pandémies de maladies infectieuses telles que la maladie à virus Ebola, la rougeole, la maladie à virus Zika ou la fièvre de Lassa, etc. ;
- les catastrophes naturelles, par exemple les tremblements de terre, les tsunamis, les inondations ou les cyclones ;
- catastrophes d'origine humaine, telles que les accidents industriels à grande échelle, les conflits et les déplacements massifs de population.

❖Description de la procédure

- l'investigateur principal ou l'autorité de santé demande la tenue d'une séance extraordinaire au président du CERSH et dépose le dossier de soumission du protocole de recherche (voir procédure associée) ;
- le Président du CERSH convoque la séance extraordinaire au plus tard cinq (05) jours après enregistrement de la demande du chercheur principal, informe et attribue immédiatement les protocoles aux membres évaluateurs ;
- la séance implique au maximum un tiers (1/3) des membres du comité ;
- la réunion d'évaluation du protocole soumis a lieu au plus tard dix (10) jours après l'enregistrement du dossier de demande d'habilitation éthique ;
- le comité dispose d'un délai maximum de cinq (05) jours après la séance pour rendre la décision au chercheur principal.

❖ **Documents justifiant la procédure**

- demande de tenue d'une séance extraordinaire adressée au président du CERSH par l'autorité sanitaire ou le chercheur principal ;
- convocation de la session extraordinaire ;
- ordre du jour de la séance ;
- feuille de présence aux séances ;
- procès-verbal de séance.

II.2.13 Participation du chercheur principal à une session du CERSH

Initiateur:	Président du comité/chercheur principal
Haut-parleurs):	Président du CERSH, Secrétariat Technique. Enquêteur directeur/co-chercheur(s), membres du CERSH

Lorsque le CERSH a besoin d'informations complémentaires sur un dossier pour prendre une décision, il peut inviter l'investigateur principal à assister à une séance [13]. Toutefois, sa présence n'est pas obligatoire, mais souhaitable. Le chercheur principal peut également demander sa présence à la séance d'évaluation de son protocole.

❖**Description de la procédure**

- le président de la commission informe le chercheur principal de la date de la séance 14 jours avant la date prévue pour une séance ordinaire, et cinq jours pour une séance extraordinaire (le(s) co-chercheur(s) peuvent également se présenter à la place du chercheur principal) ;
- le chercheur principal peut être invité à faire une présentation de 15 à 20 minutes de son protocole, avant de répondre aux questions, préoccupations et suggestions des membres du comité ;
- A l'issue des échanges, le chercheur principal sera invité à quitter la salle lors des délibérations sur son protocole de recherche ;
- les membres du CERSH délibèrent et prennent des décisions par vote ou par consensus ;
- le chercheur principal sera informé de la décision du comité par la procédure habituelle (. PageXXX).

❖ **Documents justificatifs de la procédure**

- lettre d'invitation à la séance adressée au chercheur principal par le président du CERSH ;
- Accusé de réception du chercheur principal ;
- ordre du jour de la séance ;
- registre de présence;

- rapport de séance.

II.2.14. Gestion des conflits d'intérêts lors des évaluations éthiques de protocoles de recherche

Initiateur:	**Président, membres du CERSH, Secrétariat technique du CERSH**
Haut-parleurs):	**Président, secrétariat technique, membres du CERSH**

Un conflit d'intérêts survient lorsqu'il existe une tension entre les obligations ou responsabilités d'une personne participant à un processus d'évaluation et ses intérêts personnels, professionnels, institutionnels ou financiers [7]. Un manque d'impartialité peut être craint lorsque le jugement ou la décision d'une personne est susceptible d'être influencé par des intérêts concurrents.

Par exemple, il peut y avoir un conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent lorsque le membre participant au processus d'évaluation se trouve dans l'une des situations suivantes :

- le membre peut recevoir un avantage ou subir un désavantage personnel, de nature professionnelle, institutionnelle, financière ou autre, résultant de la conduite des recherches effectuées ;
- un membre de la famille immédiate (conjoint, enfant ou parents), de la famille élargie, un ami ou une personne pour laquelle l'évaluateur démontre un intérêt particulier, peut recevoir un avantage ou subir un désavantage personnel, d'ordre professionnel, institutionnel, financier ou autre , résultant de la conduite des recherches réalisées :
- le membre entretient une relation professionnelle récente ou significative, de manière à créer un préjudice favorable ou défavorable (relation conflictuelle) avec une personne susceptible de bénéficier d'un avantage ou de subir un désavantage personnel de nature professionnelle, institutionnelle, financière ou autre, résultant du déroulement des recherches menées ;
- le membre a un lien institutionnel ou organisationnel, voire une affiliation disciplinaire avec le chercheur principal, un co-chercheur ou une personne impliquée dans l'élaboration ou la mise en œuvre du protocole de recherche ;
- le membre participe à l'élaboration ou à la mise en œuvre du protocole de recherche;

- le président du comité ou l'un des membres présente une candidature à titre de chercheur principal, co-chercheur ou collaborateur;
- toute autre situation suggérant un conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent.

Les évaluateurs sont tenus de déclarer toute situation de conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent au président du comité. Le président du comité a la responsabilité de déterminer si le conflit d'intérêts exprimé est susceptible d'influencer l'indépendance et l'intégrité de l'évaluateur.

En cas de conflit d'intérêts du président du comité, le vice-président ou le membre le plus âgé sans conflit d'intérêts préside la séance.

Les membres du CERSH impliqués dans l'élaboration ou la mise en œuvre d'un protocole de recherche ne peuvent participer au suivi de la mise en œuvre de cette recherche sur le terrain.

❖Description de la procédure

Une fois les demandes d'autorisation éthique soumises :

- le secrétaire permanent transmet la liste des protocoles déposés, les noms de l'investigateur principal et des co-investigateurs au président du CERSH ;
- le président du comité vérifie auprès de chaque évaluateur potentiel la présence d'un conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent avant d'attribuer des protocoles d'évaluation;
- les évaluateurs auxquels est attribué un protocole de recherche signent le formulaire de déclaration de conflit d'intérêts ;
- en cas de conflit d'intérêt déclaré, le président du comité identifie de nouveaux évaluateurs sans conflit d'intérêt pour les candidatures concernées ;
- au début de la séance du comité, le président demande aux évaluateurs d'annoncer aux autres membres du comité d'évaluation s'ils se trouvent en conflit d'intérêts réel, apparent, potentiel ou non ; et rappelle aux membres en conflit d'intérêts qu'ils doivent se retirer de la salle ;
- En cas de dénonciation d'un conflit d'intérêt pour un évaluateur, le président suspend les débats et procède à la vérification ; si le conflit d'intérêts est avéré, le rapport d'évaluation préétabli par l'évaluateur concerné est purement et simplement annulé,

❖ Documents justifiant la procédure

Formulaire de déclaration de conflit d'intérêts.

II.2.15. Rédaction des comptes rendus des séances du CERSH

Initiateur: Secrétaire Permanent/Secrétaire du CERSH

Haut-parleurs): Secrétaire permanent/Secrétaire, Président de la CERSH, membres du CERSH

Les décisions du CERSH prises en séance doivent faire l'objet d'un procès-verbal afin de documenter les délibérations [2, 13].

❖Description de la procédure

-les procès-verbaux des séances sont établis par le Secrétaire Permanent/Secrétaire du CERSH, et doivent contenir au minimum les informations suivantes :

- La date, l'heure d'ouverture et de clôture de la séance ;
- Les noms des membres du CERSH présents et absents et, le cas échéant, ceux des experts externes et des invités ;
- La liste des protocoles évalués lors de la session avec les références de versions ;
- Les noms des enquêteurs principaux. projets de recherche évalués;
- L'origine du financement des projets de recherche ;
- Les résultats des discussions, notamment le nombre de protocoles approuvés, le nombre de refus et le nombre de demandes approuvées sous réserve,
- le procès-verbal doit être signé par chaque membre du CERSH présent à la séance ;
- le secrétaire permanent archive les procès-verbaux validés ;
- les procès-verbaux définitifs des séances sont adressés à tous les membres du CERSH et archivés par le secrétariat technique avec tous les autres documents relatifs aux protocoles évalués.

❖Documents justifiant la procédure

Minutes de séance validées.

II.2.16. Rédaction du rapport de session CERSH

Initiateur: Secrétaire Permanent/Secrétaire du CESH

Haut-parleurs):	Secrétaire permanent/Secrétaire. Président du CERSH, membres du CERSH

La lecture du rapport devrait permettre de suivre le raisonnement qui a motivé la décision et, le cas échéant, les dilemmes auxquels le Comité a été confronté ou les positions divergentes.

❖Description de la procédure

- les rapports de séance préparés par le Secrétaire Permanent/Secrétaire du CERSH [9] doivent contenir au moins les informations suivantes :
- la date, l'heure d'ouverture et de clôture de la session ;
- les noms des membres du CERSH présents et absents et, le cas échéant, ceux des experts externes et des invités ;
- la liste des protocoles évalués lors de la session avec les références des versions ;
- les noms des chercheurs principaux des projets de recherche ;
- l'origine du financement des projets de recherche ;
- les résumés des projets, notamment les objectifs, le profil des participants à la recherche attendus, la durée prévue, la nature des démarches ;
- la synthèse des discussions, notamment les avis exprimés, les points controversés, la conclusion du CERSH clairement justifiée sur le plan éthique et scientifique, ainsi que les désaccords sur les justifications ;
- le résultat des discussions, notamment :
- le nombre de protocoles approuvés ;
- le nombre de refus et leurs motivations ;
- le nombre de candidatures approuvées sous réserve et la description de toutes les exigences posées par le CERSH au chercheur principal ;
- en cas de prise de décision par vote, le nombre de voix pour, contre et d'abstention ;
- toute situation de conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel et le retrait d'un membre en cours de délibérations.
- le rapport doit être envoyé à chaque membre du CERSH ayant participé à la séance par voie électronique.

❖ Documents justifiant la procédure

- procès-verbaux des séances ;
- rapport de séance.

II.3. SUIVI ET ÉVALUATION DE LA FONCTIONNALITÉ DU CERSH

Initiateur: Autorité de régulation compétente

Haut-parleurs): Responsables des institutions compétentes : MINSANTE. CNERSH, DRSP. Institutions de recherche

La Division de Recherche Opérationnelle en Santé (DROS), la Délégation Régionale de Santé Publique (DRSP) et le chef d'établissement veillent respectivement au fonctionnement du CNERSH, du CERSH central et du CIERSH central.

Le CERSH sera supervisé sur des indicateurs relatifs à :

- la constitution des comités d'éthique (le bureau, les membres, le Secrétariat Technique) ;
- conformité de la composition des membres (profil, aspect genre, nombre)
- formation des membres;
- respecter la fréquence des séances d'évaluation des protocoles de recherche;
- le respect des procédures de soumission et d'évaluation des protocoles ;
- suivre les projets de recherche ayant obtenu une autorisation éthique et une AAR ;
- le renouvellement des membres du Comité ;
- l'existence de matériel de bureau et informatique ;
- l'indépendance du comité vis-à-vis de l'institution qui l'accueille, des chercheurs, du promoteur et du mécène ;
- les sources de financement du comité;
- gestion des conflits d'intérêts;
- le partenariat;
- et la production de rapports d'activités.

Par ailleurs, le CNERSH supervise le CERSH et le CIERSH [2]. Ces structures seront encadrées sur des indicateurs relatifs à :

- la constitution des comités d'éthique (le bureau, les membres, le Secrétariat Technique) ;
- conformité de la composition des membres (profil, aspect genre, nombre)
- formation des membres;
- respecter la fréquence des séances d'évaluation des protocoles de recherche;
- le respect des procédures de soumission et d'évaluation des protocoles ;
- suivre les projets de recherche ayant obtenu une autorisation éthique et une AAR ;

- le renouvellement des membres des comités;
- l'existence de matériel de bureau et informatique ;
- l'indépendance du comité vis-à-vis de l'institution qui l'accueille, des chercheurs, du promoteur et du mécène ;
- les sources de financement du comité;
- gestion des conflits d'intérêts;
- partenariat et réalisation de rapports d'activités ;
- la qualité de l'évaluation éthique des protocoles de recherche.

La grille de suivi et d'évaluation des comités d'éthique de la recherche en santé humaine (CERSH) est présentée en annexe de ce guide.

❖ **Description de la procédure**

Chaque comité d'éthique adressera un rapport annuel le concernant à :

- Ministre chargé de la santé du CNERSH ;
- Délégué régional à la santé publique et au CNERSH pour le CRESH ;
- Responsable de l'établissement du CIERSH.

Le rapport annuel d'un comité d'éthique doit contenir au moins les informations suivantes :

- la liste des membres, précisant leurs compétences (profession et affiliations professionnelles) ainsi que leur rôle au sein du CERSH ;
- la liste des protocoles soumis, ceux ayant reçu l'approbation et ceux rejetés avec des informations telles que le nom du promoteur, le domaine de recherche, le promoteur, la cible, le domaine de mise en œuvre et la période de l'étude ;
- le nombre de déclarations de conflits d'intérêts ;
- le nombre de séances tenues au cours de l'année, et les procès-verbaux des séances qui doivent comprendre :
- la date, l'heure d'ouverture et de clôture de la session ;
- les noms des membres du CERSH présents et absents et, le cas échéant, ceux des experts externes et des invités ;
- la liste des protocoles évalués lors de la session avec les références des versions ;
- Les noms des chercheurs principaux des projets de recherche évalués ;
- l'origine du financement des projets de recherche ;
- le résultat des discussions, y compris le nombre de protocoles approuvés, le nombre de refus et le nombre de demandes approuvées avec réserves.
- les activités de veille éthique des projets de recherche réalisés ;
- la fréquence des activités liées à la formation continue en éthique;
- la proportion de membres ayant suivi une formation en éthique de la recherche

Le DROS doit superviser activement le CERSH, dans le but de vérifier l'état des infrastructures, du matériel de bureau et des consommables, les documents des conclusions de la commission, les procès-verbaux des séances et autres documents jugés pertinents par l'équipe d'encadrement.

La supervision des comités d'éthique peut être formative et/ou évaluative.

❖Documents à l'appui :

- Rapport annuel du CERSH ;
- notes des missions de supervision ;
- grille de supervision
- rapports de surveillance,

Chapitre III : Évaluation éthique et administrative des protocoles de recherche pour la santé humaine

Toutes les recherches menées avec des participants humains sont évaluées et approuvées par un CERSH et un MINSANTE. Les organes de décision et de suivi pour la conduite de tout projet de recherche en santé humaine au Cameroun sont : le Comité d'Ethique compétent et le DROS.

Selon l'article 34 de la loi du 27 avril 2022, tout protocole de recherche doit, avant sa mise en œuvre, obtenir une Autorisation Éthique délivrée par la commission d'éthique compétente et une Autorisation Administrative de Recherche (AAR) délivrée par le MINSANTE [1]. Le DROS examine uniquement les dossiers ayant préalablement obtenu une autorisation éthique.

Aucune intervention ou interaction ne peut être entreprise avec des participants humains à la recherche, y compris le recrutement, sans l'approbation d'un protocole d'évaluation et de recherche, de documents de consentement et de matériel de recrutement.

Le schéma ci-dessous représente le processus de traitement des dossiers d’habilitation éthique et d’Autorisation Administrative de Recherche (AAR), et de suivi de la mise en œuvre d’un projet de recherche en santé au Cameroun.

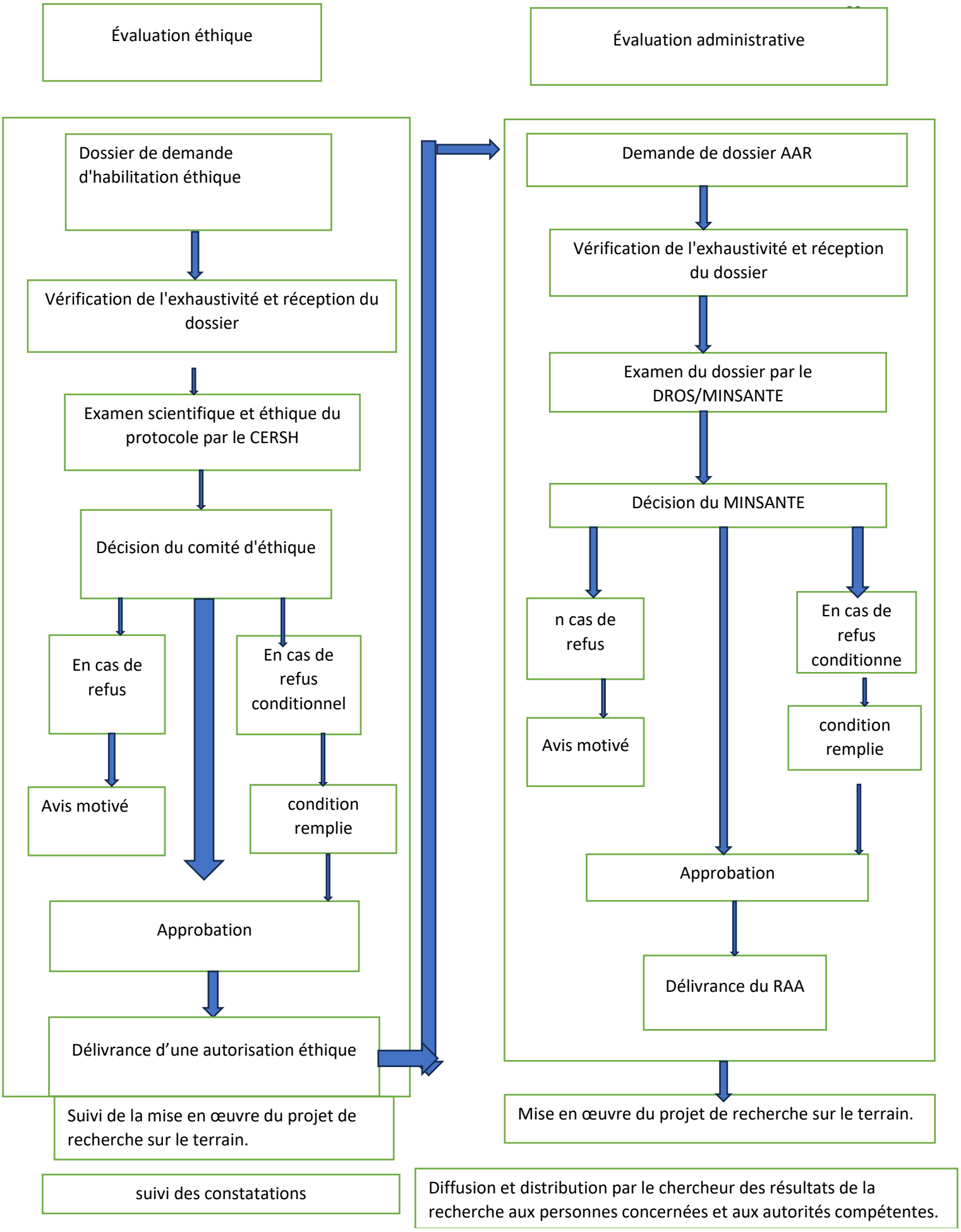

Figure 1 : Processus de traitement des demandes d'autorisation éthique et administrative, ainsi que de suivi de la mise en œuvre d'un projet de recherche en santé humaine au Cameroun

III.1. PROCÉDURES D'ÉVALUATION ÉTHIQUE

III. 1.1. Soumission des protocoles de recherche

Initiateur:	**Tout chercheur principal souhaitant mener un projet de recherche en santé humaine au Cameroun**
Haut-parleurs):	**CERSH**

- **Condition d'acceptabilité des protocoles**

Tout protocole de recherche en santé humaine est éligible à l'évaluation éthique du CERSH si l'objet de l'étude concerne la personne humaine et/ou ses interactions avec son environnement, notamment des données biologiques, sociodémographiques et des récits de vie [1]. Les recherches liées à l'environnement, à l'agriculture, à l'eau ou à l'alimentation ayant des effets sur la biologie, la physiologie ou la santé humaine sont donc également considérées comme des recherches pour la santé humaine.

Une demande d'évaluation éthique d'un projet de recherche impliquant une personne humaine doit être soumise par un chercheur/investigateur principal, responsable de la conduite éthique et scientifique du projet de recherche. Le chercheur principal doit avoir une adresse physique au Cameroun et, le cas échéant, avoir un co-chercheur (chercheur principal local) avec une adresse physique au Cameroun.

Le chercheur principal doit être « une personne ayant acquis une éducation, une formation et des qualifications appropriées en éthique et en sciences, y compris des médecins de toutes spécialités, des pharmaciens et des médecins bucco-dentaires [1].

Le CERSH ne peut recevoir que les protocoles relevant de sa compétence. Le dépôt d'un dossier complet doit être effectué au moins vingt (20) jours avant la date de la session concernée.

- **Description de la procédure**

Pour le dépôt initial du dossier de demande d'habilitation éthique d'un projet de recherche au CERSH :

- Le chercheur principal doit soumettre toute la documentation requise en versions physique et numérique au secrétariat du CERSH. Ce dossier comprend les documents suivants [18J :
- Une demande d'autorisation éthique adressée au président du comité et signée par le chercheur principal. Lorsque le chercheur principal ne dispose pas d'adresse institutionnelle et/ou physique au Cameroun, la

demande est cosignée par le chercheur principal et le chercheur résidant au Cameroun ;

- Un protocole de recherche paginé, rédigé soit en français soit en anglais, signé par tous les enquêteurs et : comprenant P l'adresse postale, l'email, le contact téléphonique et l'affiliation institutionnelle des enquêteurs. Ce protocole est présenté selon le plan ci-dessous :
- la page de garde comprenant : le titre du protocole, le numéro d'identification du protocole, le numéro et la date de la version, le nom et l'adresse du promoteur et/ou du sponsor, le nom et les coordonnées détaillées de l'investigateur principal (affiliation institutionnelle, contact postal, numéros de téléphone et de fax)), signature des enquêteurs ;
- Le résumé indiquant les pages, titres et sous-titres détaillés dans le protocole ;
- La liste des abréviations ;
- Le glossaire présenté par ordre alphabétique ; o La liste et les contacts des enquêteurs ;
- Des synthèses structurées en français et en anglais (justification - objectifs-méthodologie-résultats attendus-mots-clés) ;
- L'introduction (contexte et justification) ;
- Questions de recherche et hypothèses le cas échéant ;
- Les objectifs;
- La revue de la littérature ;
- La méthodologie comprenant le type d'étude, le site, la période et la population étudiée, les critères de sélection, la procédure d'échantillonnage et l'estimation de la taille de l'échantillon, la définition des variables clés de l'étude, les outils et techniques de collecte de données, l'étude procédures, plan d'analyse des données, considérations éthiques et plan de diffusion des résultats.

NB : Dans le cas d'essais cliniques, préciser la phase de l'essai, la méthode de randomisation, les caractéristiques des interventions reçues par le groupe d'intervention et le groupe témoin, la méthode de mesure de l'effet principal recherché et son estimation. calendrier de mise en œuvre ;

o le budget détaillé en monnaie locale du projet qui indique les sources de financement, le nom et les coordonnées du promoteur (sponsor) ;

- des références bibliographiques conformes à une norme de référence ;
- les documents de consentement éclairé (notice d'information, formulaire de consentement et éventuellement formulaire d'assentiment et autorisation parentale) rédigés en anglais et en

français et, le cas échéant, dans toute autre langue les rendant accessibles à la communauté d'étude ;
- outils de collecte de données en français et en anglais ;
- les curriculum vitae du chercheur principal et des co-chercheurs de l'équipe de recherche à jour, signés et datés, indiquant au moins la formation reçue, leurs affiliations, les projets de recherche dans lesquels ils ont été impliqués, la liste des publications démontrant leur expérience dans la mise en œuvre du protocole de recherche soumis ;
- les différentes autorisations éthiques obtenues le cas échéant ;
- la brochure du chercheur principal (essais cliniques) ;
- l'accord de transfert de matériel le cas échéant ;
- l'accord de transfert de données le cas échéant
- une lettre d'engagement sur l'honneur de restituer les résultats de la recherche accessibles à la population recherchée ;
- un accord de principe du gestionnaire des sites où seront effectuées les recherches.

-le secrétariat vérifie l'exhaustivité du dossier dès réception et à réception du versement des frais sur le compte CERSH ;

-le secrétariat délivre un récépissé de dépôt au soumissionnaire sous forme d'une liste de contrôle de complétude du dossier signée et datée par le secrétariat.

❖**Documents justificatifs de la procédure ;**

- compléter le dossier de soumission du protocole de recherche au CERSH ;
- liste de contrôle permettant de vérifier l'exhaustivité du dossier de soumission ;
- reçu de dépôt au soumissionnaire,

III.1.2. Remise des protocoles pour cas particuliers

Pour les cas particuliers d'études interventionnelles tels que les essais cliniques avec des produits d'intervention (tels que les médicaments, les médecines traditionnelles améliorées (MTA), les dispositifs médicaux et les techniques médicales), en plus des éléments généraux mentionnés ci-dessus, d'autres éléments spécifiques doivent être inclus dans le protocole. dossier de soumission au Comité national d'éthique de la recherche en santé humaine.

- **Supplément au dossier de soumission de protocole pour les Essais Cliniques avec produits d'intervention**

Pour les essais cliniques, le dossier de soumission du protocole de recherche doit être complété avec les éléments décrits ci-dessous :

- l'engagement du promoteur à assurer l'accès au produit de l'adhérent n'ayant pas encore obtenu une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) si celle-ci s'avère efficace ; ceci sur une période d'au moins 3 ans ;
- une exemption spéciale pour l'importation de produits expérimentaux qui ne disposent pas encore d'une autorisation de mise sur le marché ;
- une police d'assurance valide pour les chercheurs et tous les participants à la recherche couvrant les dommages liés à l'administration du produit et à la mise en œuvre des procédures et erreurs de la méthodologie ;
- la « brochure de l'investigateur » concernant le produit objet de l'expérimentation et/ou sa notice d'information si le produit dispose d'une AMM.

En fonction de la phase d'expérimentation, la brochure de l'investigateur doit contenir les informations précisées dans le tableau 3.

Tableau 3 : Informations de la brochure de l'investigateur selon les phases de l'essai clinique

Phases CE	Informations à retrouver dans la brochure de l'enquêteur
Phase 1 (préclinique)	- L'ingrédient actif - La liste des excipients Les différentes posologies testées avec leur pharmacocinétique et pharmacodynamique (toxicité aiguë et chronique sur les organes nobles, tératogénicité, dose létale et dose tolérée) ; les effets in vitro et in vivo sur les germes ciblés s'il s'agit d'un anti-infectieux - Le nombre et le type d'animaux utilisés pour l'expérience - Indications et contre-indications - Interactions médicamenteuses - Conditions de stockage - Référence pour d'éventuelles publications 1
Phase 2	Informations de la phase l complétées par : données pharmacocinétiques et pharmacodynamiques chez l'homme (fréquence et sévérité des effets sur les organes nobles, les différentes doses testées, liste des événements indésirables graves et mineurs détectés ainsi que analyse de leur imputabilité ; le nombre, le sexe et l'âge des sujets humains (participants) ; le résumé de la méthodologie et des procédures de la phase 1 ; Indications et contre-indications chez l'homme ; - Interactions médicamenteuses ; - Conditions de stockage ; Références pour d'éventuelles publications.
Phase 3	Informations des phases I et 2 complétées par : le nombre de participants. ;

Phase 4(après obtention d'une AMM)	les protocoles d'administration de la phase 2 et l'estimation des indicateurs de leur efficacité* : la liste des événements indésirables graves et mineurs détectés ainsi que l'analyse de leur imputabilité ; - Résumé de la méthodologie et des procédures de la phase 2 - Indications et contre-indications ; - Interactions médicamenteuses ; - Conditions de stockage; Références pour d'éventuelles publications Les propriétés physiques, chimiques et la formulation du produit (le Indications et contre-indications : interactions médicamenteuses et conditions de conservation) - Le nombre d'individus chez lesquels le produit a été utilisé en phase préclinique 1, 2 et 3 et la probabilité d'efficacité - Effets indésirables graves (EIG) déjà enregistrés dans toutes les phases précédentes - Protocoles d'administration de phase 3 et estimation de leurs indicateurs d'efficacité - La liste des événements indésirables graves et mineurs détectés ainsi que l'analyse de leur imputabilité - Résumé de la méthodologie et des procédures de la phase 3 - Références pour d'éventuelles publications

❖ Supplément au dossier de soumission du protocole pour les Médecines Traditionnelles Améliorées (ATM)

La Médecine Traditionnelle Améliorée (MTA) est tout médicament/produit développé et développé par un tradipraticien ou un chercheur sur la base de connaissances ou d'informations issues du patrimoine thérapeutique traditionnel [19].

Toute demande d'évaluation de protocoles de recherche clinique avec MTA doit être complétée par les documents suivants i

- une lettre de motivation pour réaliser cette recherche dûment signée par le promoteur ;
- preuves ethno-pharmacologiques ;
- P identification des métabolites (catégories MITA 3 et 4) ;
- les résultats des études d'efficacité et de toxicité (catégories MTA 3 et 4) ;
- la formulation galénique ;

- la description des principes actifs et des molécules pures (catégories MTA 3 et 4) ;

- la description de la relation structure-activité (processus par lequel une structure chimique est corrélée à un effet bien déterminé tel qu'une activité biologique ou une réactivité chimique) (catégories MTA 3 et 4) ;

- le résultat de l'évaluation de non-toxicité réalisée par la DPML et LANACQME (catégories MTA 3 et 4).

NB : Selon la catégorie indiquée dans le tableau ci-dessous, le dossier doit être complété par les éléments correspondants.

Tableau 4 Le dossier de soumission du protocole de recherche complète en fonction de l'identification de la catégorie, des preuves de sécurité et d'efficacité du MTA.

Catégories [19]	**Éléments d'identification**	**Méthodes pour prouver la sécurité et l'efficacité**	**Compléter le dossier**
Médicaments de catégorie 1	Médicament préparé par le tradipraticien de la santé pour un patient de manière externe selon les méthodes traditionnelles de production et de normalisation, et qui répond aux caractéristiques suivantes i)sa sécurité et son efficacité sont garanties par une longue expérience de son utilisation (trois générations) ; ii) les matières premières sont bien connues du	Utilisation traditionnelle avec une vaste expérience de son utilisation sur plus de 3 générations.	Rapport d'études ethno-pharmacologiques sur le terrain

	tradipraticien et peuvent être fraîches ou sèches ; iii) sa conservation est généralement de courte durée.		
Médicament de catégorie 2	Médicament issu du patrimoine thérapeutique traditionnel couramment utilisé dans la communauté qui répond aux caractéristiques suivantes : i) il est préparé à l'avance, conditionné avec un numéro de lot ; ii) les matières premières entrant dans sa composition sont très connues de la population ; iii) sa production est réalisée selon des méthodes garantissant sa stabilité et sa standardisation ; iv) sa production est industrielle ou semi-industrielle ; v) sa sécurité et son efficacité sont garanties par des preuves ethnomédicales issues d'une longue expérience d'utilisation ou par des essais cliniques ouverts si cela est jugé nécessaire par l'autorité compétente ; vi) les principes actifs qui le composent sont des matières premières ; vii) les principaux groupes chimiques des matières premières sont connus ;	La preuve ethnomédicale d'une longue histoire d'utilisation ou par le biais d'essais cliniques ouverts si l'autorité compétente le juge nécessaire.	Un rapport de l'étude ethno-pharmacologique de terrain. ou Un rapport sur les résultats d'études utilisant des méthodes rétrospectives de résultats de traitement lorsque les doses selon les indications sont déjà connues et pratiquées dans la population (pharmacologie inverse).

	viii) sa durée de conservation est déterminée par des tests de stabilité.		
Médicament de catégorie 3	Médicament issu de la recherche scientifique dont les principes actifs sont des extraits standardisés et qui répond aux caractéristiques suivantes : i) il est préparé à l'avance, conditionné avec un numéro de lot ; ii) sa production est semi-industrielle ou industrielle ; iii) la durée de sa conservation est fixée par des essais de stabilité iv) Les principes actifs sont des extraits standardisés v) Elle prend en compte les propriétés biologiques des matières premières, les nouvelles indications thérapeutiques, la formulation galénique avec spécifications posologiques et la connaissance des molécules biologiques actives. vi) Il est standardisé et produit selon les normes des bonnes pratiques de fabrication vii) Son efficacité et sa sécurité sont prouvées par des essais précliniques et cliniques menés selon des protocoles standard.	études précliniques et cliniques menées selon des protocoles standards	Résultats d'études précliniques (étude botanique/ethnobotanique, pharmacologique et toxicologique) et résultats de traitements lorsque les doses selon les indications sont déjà connues et pratiquées dans la population (pharmacologie inverse).
Médicament de catégorie 4	Médicament issu de la recherche scientifique dont les principes actifs sont des molécules	Essais études précliniques et cliniques menées selon	Résultats d'études précliniques (étude botanique/ethnobotanique, pharmacologique et

	purifiées et qui répond aux caractéristiques suivantes :	des protocoles standards	toxicologique) et Essai clinique / Méthode rétrospective de traitement-résultat lorsque les doses selon les indications sont déjà connues et pratiquées dans la population (pharmacologie inverse)
	i) il est préparé à l'avance, conditionné avec un numéro de lot : ii) sa production est semi-industrielle ou industrielle : iii) sa durée de conservation est déterminée par des tests de stabilité ; iv) les principes actifs sont des molécules purifiées : v) il prend en compte les propriétés biologiques des matières premières, les nouvelles indications thérapeutiques, une formulation galénique avec une spécification de dosage, la connaissance des molécules biologiquement actives ; vi) il est standardisé et produit selon les normes des bonnes pratiques de fabrication : vii) son efficacité et sa sécurité sont prouvées par des essais précliniques et cliniques menés selon des protocoles standards		

❖Complément au dossier de dépôt de protocole pour les projets impliquant un transfert de matériel/données biologiques entre équipes d'investigateurs

Le dossier doit être complété par l'accord de transfert de matériel et/ou l'accord de partage de données [1].

- L'accord de transfert de matériel comprend les informations suivantes :
- la nature, la quantité et la fréquence du transfert des échantillons ;
- la description des échantillons en termes d'origine, de volume, de méthode de conservation et de transport ;
- le nom et l'adresse de l'expéditeur et de son institution ;
- le nom et l'adresse du destinataire et de son institution ;
- le mode de destruction et les conditions de transformation des produits dérivés ;
- les conditions de partage avec d'autres laboratoires ;
- la loi applicable à la sécurité des échantillons ;

NB : le contrat de transfert de matériel doit être signé par les responsables de l'expédition et de la sécurité des échantillons,

- L'accord de partage de données comprend les informations suivantes :
  - la liste des outils de collecte de données ;
  - les bases de données générées et leur localisation ;
  - les personnes ayant accès à ces bases ;
  - mécanismes de sécurité des itinéraires et des données ;
  - les personnes qui peuvent modifier les bases ;
  - la durée de conservation des bases de données ;
  - délais et conditions de publication des bases de données
  - la liste des publications et des auteurs attendus.

III.1.3. Attribution des protocoles de recherche aux membres et experts indépendants pour évaluation

Initiateur: Secrétaire Permanent/Secrétaire Technique

Haut-parleurs); Secrétariat technique, membres du CERSH

Le secrétariat technique d'un comité d'éthique attribue les protocoles à des membres ou à des experts indépendants en fonction de leur expertise. Le nombre minimum de réviseurs pour un protocole est de trois (03). Une proposition d'attribution du protocole examiné est alors faite par le secrétariat et préalablement soumise pour validation par le Président au moins deux semaines avant la tenue d'une séance. Les protocoles doivent être remis aux membres évaluateurs quatorze (14) jours avant la séance.

❖Description de la procédure

- Le secrétariat technique compile les protocoles de recherche nouvellement élaborés reçus.

- Avant la séance, la version électronique du dossier de demande d'habilitation éthique est partagée par le Secrétariat Technique à au moins trois évaluateurs. Ces derniers peuvent être des membres de comités ou des évaluateurs externes choisis en fonction de leur domaine d'expertise. Ces évaluateurs externes doivent faire partie d'une liste approuvée par le comité.
- La déclaration de conflits d'intérêts des évaluateurs par rapport au protocole à évaluer est faite immédiatement après réception du protocole à évaluer,
- Le secrétariat technique diffuse ensuite les protocoles aux membres désignés et note les éléments ci-dessous dans son registre :
  - Date de réception du protocole ;
  - Titre du protocole ;
  - Nom du chercheur principal ;
  - Noms des membres affectés à l'évaluation ;
  - Date de distribution des protocoles aux membres concernés.

❖Documents justifiant la procédure

- Liste des protocoles soumis pour évaluation éthique avant la date de la séance
- Feuille d'attribution du protocole pour les membres évaluateurs
- Registre du secrétariat technique

III. 1.4. Critères d'évaluation éthique

Initiateur: Président du CERSH

Intervenant(s) : Secrétariat technique, membres du CERSH ; des enquêteurs, des experts et des évaluateurs externes invités.

L'objectif de cette procédure est de décrire les critères d'évaluation éthiques du protocole soumis. Cette évaluation se fait en deux étapes, dont une première avant la séance et une autre pendant la séance. Il doit prendre en compte les éléments suivants [7, 12, 20] :

- valeur sociale;
- validité scientifique;
- analyse du rapport bénéfice-risque ;
- sélection équitable des participants;
- le processus de consentement éclairé ;
- le respect de la confidentialité ;

- partenariat collaboratif pour améliorer l'accès aux résultats de la recherche
- le respect de la dignité humaine ;
- le respect des normes sociales et culturelles au niveau individuel et communautaire ;
- la situation de conflit d'intérêts du chercheur ;
- plan de restitution des résultats.

❖ **Description de la procédure**

Après attribution des protocoles de recherche à évaluer :

- les évaluateurs doivent adresser leurs commentaires au secrétariat technique sous forme physique ou par email au plus tard 24 heures avant la session ; ces rapports doivent être conformes à la grille d'évaluation éthique du comité ;
- le secrétaire permanent/technique doit s'assurer qu'au moins deux rapports d'évaluation sur trois ont été reçus pour chaque protocole ; dans le cas contraire, il réattribue en urgence ce protocole à un autre évaluateur présent à la séance :
- les rapports d'évaluation sont présentés par chaque évaluateur ou par le secrétaire permanent/technique lors de la session ;
- les avis sur chaque protocole sont discutés sous la modération du président de séance ;
- la décision est adoptée par consensus : dans le cas contraire, on procède par vote et les réserves sont inscrites au procès-verbal ;
- le procès-verbal de la séance doit être validé et signé par les membres présents.

❖ Documents justifiant la procédure

- fiche de traitement des dossiers de dépôt de protocole
- grille d'évaluation éthique physique et numérique du protocole
- rapports d'évaluation éthique des évaluateurs
- feuille de présence à la séance
- procès-verbal de la séance

- éléments et critères d'évaluation éthique des protocoles de recherche (voir grille en annexe)

a) valeur sociale

Il fait référence à la pertinence et au niveau de priorités de la thématique de recherche pour une communauté, les bénéficiaires directs et indirects conformément à ceux définis par le ministère en charge de la santé publique.

Les évaluateurs vérifient si :

- le thème est pertinent aux objectifs de recherche en santé des populations;
- le projet est conforme aux besoins prioritaires en matière de santé au niveau national et/ou mondial ;
- le projet présente un bénéfice direct et/ou indirect pour les populations ;
- le plan de diffusion des résultats implique les participants, la communauté, les autorités sanitaires locales et nationales, les partenaires œuvrant dans le domaine de santé concerné et la communauté scientifique.

b) Validité scientifique

- De manière générale, les évaluateurs doivent vérifier si :
- la question de recherche naît de sa justification ;
- les hypothèses pour répondre aux questions de recherche ;
- les objectifs permettent de répondre aux questions de recherche ;
- le plan d'étude proposé et la méthode de sélection des participants sont adaptés pour atteindre les objectifs fixés ;
- la sélection des participants, l'estimation de la taille de l'échantillon et les méthodes de mesure proposées contribuent à minimiser les biais de sélection, les biais d'information, les fluctuations d'échantillonnage et les facteurs de confusion ;
- le processus d'étude naît des objectifs et des hypothèses ;
- la méthode reflète les caractéristiques des sujets étudiés ;
- le plan d'analyse estime correctement les indicateurs des objectifs spécifiques fixés ;
- les outils de collecte permettent d'atteindre les objectifs ;
- chaque objectif possède les variables attendues dans l'outil de collecte ;
- le chercheur principal possède les compétences et l’expérience requises pour mener la recherche ;
- l'équipe de recherche est compétente pour atteindre les objectifs de la recherche.

▪ S'il s'agit d'un essai clinique, vérifiez si :
- la méthode de randomisation proposée permet une répartition équilibrée des participants à l'étude

- P l'intervention, le contrôle et les mesures des variables d'intérêt sont clairs et précis ;
- les moyens prévus pour leur diffusion future ;
- publications à venir, le cas échéant.

Lorsque la durée du projet est inférieure à un an, le chercheur doit produire un rapport final contenant des informations similaires au rapport annuel d'un projet de recherche.

IV.1.2. Veille continue active - suivi des modalités de participation à la recherche

Initiateur:	CERSH et MINSANTE
Haut-parleurs):	CERSH, DROS, équipe de recherche

Le suivi des modalités de participation à la recherche [12, 13] consiste à capter toute information concernant l'efficacité des modalités auxquelles le chercheur principal s'est engagé, à savoir :

- information/sensibilisation du participant ;
- la collecte sans contrainte de son consentement ;
- participation à la recherche sans contraintes;
- le respect de la dignité du participant et de la confidentialité de la participation à la recherche ;
- l'avancement des recherches conformément au calendrier annoncé.

Le CERSH et le MINSANTE ont le pouvoir d'exercer d'autres moyens de suivi concernant les projets ; recherches pour lesquelles ils ont donné leur accord. Ces moyens peuvent être

observer le processus d'obtention d'un consentement libre et éclairé ;

b) Rapport annuel

L’investigateur principal doit remettre au comité d’éthique et au MINSANTE un rapport annuel contenant les informations suivantes :

- la date du début effectif et de la fin prévue de l'activité de recherche ;
- l'avancement et l'avancement des travaux ;
- durée totale de recrutement et d'enrôlement ;
- le nombre de sujets initialement abordés et le nombre de ceux qui ont accepté de participer au projet ;

- le nombre de sujets qui ont abandonné en cours de route et leurs raisons si elles sont connues ;
- les problèmes, événements indésirables ou incidents thérapeutiques autres que graves survenus au cours de l'année, avec des explications sommaires les concernant et une description des moyens mis en place pour aider les sujets de recherche ;
- évaluation du risque actuel, des bénéfices potentiels et du rapport risque/bénéfice global de l'étude ;
- résultats partiels possibles ;
- le statut du procès (en cours ou non) ;
- tout autre point préalablement soulevé lors de l'évaluation éthique et administrative.

c) Notification de la fin du projet

L'investigateur principal informera le comité d'éthique et le MINSANTE de la fin du projet, et fournira les informations suivantes :

- Les résultats obtenus ;

Dans le cas d'essais cliniques, le rapport doit contenir les informations suivantes :

- le type et les caractéristiques cliniques de l'événement ;
- les dates de survenance, de notification et d'enquête de l'événement ;
- description de l'équipe d'enquête sur l'événement ;
- la relation causale entre l'événement et l'intervention ;
- le nombre de sujets concernés par cet événement ;
- la description de la prise en charge et de l'évolution clinique des cas
- les répercussions de cet événement sur la suite du projet et sur les sujets ;
- les mesures prises pour prévenir ces événements indésirables.

a) Notification d'arrêt prématuré du projet

Que l'arrêt prématuré de l'étude soit temporaire ou définitif, l'investigateur principal remettra au comité d'éthique et au MINSANTE un rapport contenant les informations suivantes :

- les raisons de l'arrêt du projet (abandon ou interruption) ;
- le nombre de sujets recrutés à ce jour ;
- les mesures prises pour informer les sujets recrutés ;
- les répercussions de l'arrêt du projet sur les sujets et les mesures prises pour y remédier ;
- résultats sommaires.

Le chercheur doit conserver les dossiers de recherche pendant une durée d'au moins 10 ans [26].

❖Description de la procédure

- le CERSH et le MINSANTE ont, chacun pour ce qui le concerne, la responsabilité d'établir le calendrier de suivi de chaque projet de recherche lors de son évaluation initiale ;
- l'investigateur principal du projet de recherche est chargé d'informer le CERSH et le MINSANTE des découvertes importantes qui affecteraient le rapport bénéfice/risque [1] ;
- le chercheur principal est responsable du respect des procédures et des délais de remise des rapports ;
- en réponse au rapport annuel, le CERSH et le MINSANTE doivent indiquer toute modification, suspension ou résiliation de la décision initiale, ou confirmer que cette décision reste valable.

❖Documents de procédure

L'enquêteur principal a le devoir de présenter au moins les documents :

ci-dessous:

•- les notifications de modifications du projet de recherche ou des documents qui y sont liés ;

- un rapport de fin de projet qu'il soit prématuré, temporaire ou définitif ;

- notification de tout événement indésirable survenu au cours d'une recherche ;

- tout autre document jugé pertinent.

Traçabilité de ces derniers. L'équipe de veille aspire également à assumer une mission pédagogique auprès des équipes de recherche afin qu'elles intègrent l'éthique à la réalité quotidienne de l'avancement de leur projet de recherche. Ces aspects sont assurés par des équipes conjointes, représentant le MINSANTE et le CERSH. Une décision de contrôle de suivi doit être communiquée au demandeur.

La surveillance peut être passive et/ou active. Ainsi, les mécanismes de suivi peuvent inclure :

■ rapports des chercheurs principaux ;

■rapports d'organismes indépendants (tels qu'un comité de surveillance des données et de la sécurité) ;

■examiner les rapports d'événements indésirables et/ou inattendus ;

■rencontrer le(s) chercheur(s) pour les interroger sur le recrutement des sujets de recherche ;

■inspections ou surveillance inopinées de sites de recherche, de données, d'enregistrements ou de documents de consentement, observation de la mise en œuvre de la procédure de consentement [1] ;

■entretiens avec les participants à la recherche et/ou commentaires de leur part.

IV.1.1. Surveillance continue passive

Initiateur: Tout chercheur principal dont le projet a été approuvé

par le, CERSH et MINSANTE

Haut-parleurs):CERSH. MINSANTE

Tous les chercheurs principaux doivent soumettre des rapports d'avancement au secrétariat du CERSH ayant délivré l'autorisation éthique et au MINSANTE.

CHAPITRE IV : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROTOCOLES DE RECHERCHE ET SUIVI-ÉVALUATION DU FONCTIONNALITÉ DES COMITÉS D'ÉTHIQUE

Tout projet de recherche doit être mis en œuvre dans les 12 mois suivant l'approbation du CERSH et du MINSANTE. Si l'étude ne démarre pas dans un délai de 12 mois, l'investigateur principal informe par écrit le comité d'éthique et le MINS ANTE du retard de démarrage.

À la discrétion du comité, l'avis éthique favorable peut être révoqué et le chercheur principal devra présenter une nouvelle demande une fois que les problèmes liés au retard de l'étude auront été entièrement résolus ; ou un délai supplémentaire peut également être accordé.

IV.1. VEILLE ÉTHIQUE CONTINUE PROJET DE RECHERCHE DTJN DÉJÀ APPROUVÉ

Tous les projets de recherche approuvés doivent faire l'objet d'un suivi continu depuis la date à laquelle la décision d'approbation a été prise jusqu'à la fin de la recherche ; intervalles de contrôle de suivi, à déterminer en fonction de la nature des études, mais au moins une fois par an [13].

L'objectif de cette surveillance est de maintenir le respect des principes éthiques des projets en cours en s'assurant que les travaux correspondent au protocole de recherche approuvé par les autorités de régulation de la recherche. De ce fait, il assurera la protection des participants et des chercheurs ainsi que celle des

-En cas d'amélioration mineure, un accusé de réception de l'avenant signé par le Chef de Division. La Recherche Opérationnelle en santé est adressée au chercheur après notification de ce dernier,

❖Documents de votre démarche

- la lettre de notification de l'avenant au MINSANTE ;

- la lettre d'approbation de l'amendement CERSH ou de la nouvelle autorisation éthique ;

- la nouvelle version du protocole amendé ;

- accusé de réception de la notification C/DROS le cas échéant ;

-le nouveau AAR-pour les modifications majeures.

-l'investigateur principal justifiant de la nécessité de ce transfert de matériel a remis au MINSANTE une convention de transfert de matériel ;

-le DROS vérifie l'autorisation de transfert de matériel du chercheur principal ;

- le chercheur principal fournit une mise à jour écrite annuelle sur l'utilisation et les résultats obtenus à partir des échantillons biologiques exportés du Cameroun vers le DROS.

❖Documents de procédure L'accord de transfert de matériel

III.2.5. Mettre à jour un AAR

Initiateur: Chercheur principal

Haut-parleurs): MINSANTE (DROS)

Pour chaque projet de recherche, le MINSANTE délivre une seule Autorisation Administrative de Recherche.

❖Description de la procédure

En cas de modification, le Chercheur Principal doit notifier au Ministère en charge de la Santé Publique si la modification a reçu l'accord du CERSH. Cette notification prendra la forme d'une lettre à laquelle sera jointe une copie d'approbation de l'amendement CERSH ou de la nouvelle autorisation éthique, et la nouvelle version du protocole modifié, datée d'un numéro de version comprenant un résumé des pages modifiées. des documents initialement approuvés, où les modifications apportées à la version approuvée seront clairement indiquées.

- En cas de modification majeure, une mise à jour suite à la procédure de traitement des AAR est initiée.

- facilite le renforcement des capacités locales en matière de recherche et d'accès aux soins ;

- respecte les valeurs culturelles.

Valeur scientifique

L’évaluation administrative d’un protocole de recherche porte également sur sa valeur scientifique. Il s'assure que les objectifs affichés sont cohérents avec la méthodologie proposée dans le protocole ainsi qu'avec les résultats attendus.

❖Garantie de partage des résultats de recherche par l’investigateur principal

L'évaluation administrative permet enfin de s'assurer que le chercheur principal présente des garanties de partage des résultats de la recherche. Cette garantie se concrétise à travers ;

- la lettre d'engagement sur l'honneur du chercheur principal à restituer les résultats de la recherche ;

- prise en compte/planification de la restitution dans le calendrier de mise en œuvre des activités d'étude ;

- inclusion des frais de restitution dans le budget de l'étude.

III.2.4 Gestion du matériel biologique

Initiateur:	Chercheur principal
Haut-parleurs):	MINSANTE (DROS)

❖Description de la procédure

Dans le cas où il serait nécessaire d'exporter des échantillons biologiques à l'extérieur

du Cameroun (11 •

❖Vérification de l'authenticité des documents [24]

L'authenticité est essentielle pour les documents suivants :

-Autorisation éthique ;

-Accord du gestionnaire du site où sera réalisée l'étude ;

-le Contrat d'Assurance dûment émis par une compagnie d'assurance agréée ;

-Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) délivrée par DPML/MINSANTE.

Les éléments d'authentification suivants doivent apparaître : Titre du protocole / Nom du médicament / Numéro de référence / Date de signature / Pouvoir signataire / Cachet officiel.

❖Vérification des valeurs sociales et scientifiques

L'évaluation administrative des protocoles de recherche porte également sur la valeur sociale et la pertinence scientifique du projet de recherche.

■ Valeur sociale

La valeur sociale d'un projet de recherche repose sur le principe selon lequel la recherche en santé doit améliorer les conditions de vie des humains dans la communauté et dans l'environnement.

L'évaluation administrative permet de vérifier que le protocole de recherche :

-est conforme à la politique nationale de santé et à la réglementation en vigueur ;

-justifie un bénéfice pour la collectivité en tenant compte du rapport risque/bénéfice ;

-protège le participant à la recherche ;

-l'investigateur principal retire son AAR au DROS contre décharge,

Tout rejet de dossier doit être dûment motivé et notifié au chercheur principal contre décharge. La réévaluation du dossier est conditionnée à la prise en compte des observations ayant motivé le rejet.

❖Documents de procédure

-l'Autorisation Ethique du CERSH compétent ;

-l'accord de principe du gestionnaire de chaque site où l'étude sera mise en œuvre ;

-une exemption d'importation en cas d'essais cliniques utilisant des médicaments ne disposant pas d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) ;

-une police d'assurance valide pour les participants et, le cas échéant, pour les chercheurs pendant la durée de l'essai clinique ;

-Le RAA signé par le MINSANTE.

III.2.3. Éléments d'évaluation administrative des protocoles de recherche

L'évaluation administrative permet d'apprécier le respect des principes éthiques, de protection des participants, le respect institutionnel, les valeurs sociales et scientifiques, l'engagement de 1 à 5 chercheurs principaux à restituer les résultats de l'étude [5].

❖Vérification du respect des principes éthiques

L'évaluation administrative comprend également le contrôle des principes éthiques pour assurer la protection des participants. 11 est une double mesure pour garantir la protection efficace des participants après l'évaluation faite par le comité d'éthique.

❖Vérification de l'authenticité des documents [24]

L'authenticité est essentielle pour les documents suivants :

-Autorisation éthique ;

-l'accord du gestionnaire du site où l'étude sera réalisée ;

■la Police d'Assurance dûment émise par une compagnie d'assurance agréée ;

-Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) délivrée par DPML/MINSANTE.

Les éléments d'authentification suivants doivent apparaître : Titre du protocole / Nom du médicament / Numéro de référence / Date de signature / Pouvoir de signature / Cachet officiel.

♦Vérification des valeurs sociales et scientifiques

L'évaluation administrative des protocoles de recherche porte également sur la valeur sociale et la pertinence scientifique du projet de recherche.

■ Valeur sociale

La valeur sociale d'un projet de recherche repose sur le principe selon lequel la recherche en santé doit améliorer les conditions de vie des humains dans la communauté et dans l'environnement.

L'évaluation administrative permet de vérifier que le protocole de recherche :

- est conforme à la politique nationale de santé et à la réglementation en vigueur ;

- justifie un bénéfice pour la collectivité compte tenu du rapport bénéfice/risque ;

- protège le participant à la recherche ;

- l'investigateur principal retire son AAR au DROS contre décharge,

Tout rejet de dossier doit être dûment motivé et notifié au chercheur principal contre décharge. La réévaluation du dossier est conditionnée à la prise en compte des observations ayant motivé le rejet.

♦Documents de procédure

-l'Autorisation Ethique du CERSH compétent ;

-l'accord de principe du gestionnaire de chaque site où l'étude sera mise en œuvre ;

-une exemption d'importation en cas d'essais cliniques utilisant des médicaments ne disposant pas d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) ;

-une police d'assurance valide pour les participants et, le cas échéant, pour les chercheurs pendant la période de l'essai clinique ;

-Le RAA signé par le MINSANTE,

III.2.3. Éléments d'évaluation administrative des protocoles de recherche

L'évaluation administrative permet d'apprécier le respect des principes éthiques, la protection des participants, le respect institutionnel, la valeur sociale et scientifique et l'engagement du chercheur principal à rendre compte des résultats de l'étude [5].

❖ **Vérification du respect des principes éthiques**

L'évaluation administrative comprend également le contrôle des principes éthiques pour assurer la protection des participants. Il s'agit d'une double mesure pour garantir la protection efficace des participants après l'évaluation faite par le comité d'éthique.

♦Lorsque la recherche est multicentrique ou lorsqu'elle prévoit le transfert de données ou de matériel de recherche biologique entre plusieurs établissements, les documents suivants sont requis :

- un accord de transfert de données (Data Sharing Agreement) ;
- un accord de transfert de matériel.

III.2.2. Traitement d'une demande d'autorisation administrative de recherche

Initiateur: Chercheur principal

Haut-parleurs): MINSANTE

❖Description de la procédure

Immédiatement après avoir obtenu l'autorisation éthique :

- l'investigateur principal dépose le dossier physique complet de demande d'Autorisation Administrative de Recherche (voir 3.2.1 Composition du dossier de demande d'AAR) au Ministère en charge de la Santé Publique du Cameroun contre décharge ;
- l'enquêteur doit adresser par email, la copie scannée du récépissé de dépôt et dudit dossier en un (01) seul document PDF à l'adresse DROS : minsantedros@vahoo.com ;
- le dossier déposé au courrier du MINSANTE est transmis à la DROS pour traitement ;

- après examen d'un dossier conforme, la DROS donne son avis au Ministre chargé de la Santé Publique dans un délai de 14 jours ouvrés à compter de sa réception ;
- l'approbation du RAA signé par le Ministre de la Santé Publique revient au secrétariat de la DROS qui en informe l'investigateur principal ;
- le formulaire de consentement éclairé du participant à la recherche en français et en anglais ;
- Autorisation éthique délivrée par un CERSH ;
- le Curriculum Vitae daté et signé de chaque chercheur participant à la recherche ;
- le budget détaillé, les sources de financement et l'adresse complète du promoteur et du sponsor du projet ;
- l'engagement sur l'honneur du Chercheur Principal de se soumettre au contrôle des organes de suivi-évaluation des autorités compétentes, et de rendre compte des résultats à la fin du projet
- le plan de diffusion des résultats des travaux ; ,
- l'accord de principe préalable signé par le responsable de chaque structure/établissement de santé où l'étude sera mise en œuvre,

♦Pour le cas spécifique des essais cliniques, les documents suivants seront également requis :

- une photocopie de la police d'assurance valable pour les participants et, le cas échéant, pour les chercheurs pendant la durée de l'essai clinique ;
- l'engagement du promoteur à prendre en charge les sujets victimes d'incidents/accidents liés à leur participation à l'essai clinique et pouvant survenir à moyen ou long terme ;
- la brochure de l'investigateur concernant le produit soumis à l'investigation et/ou sa notice d'information si le 4ème produit dispose d'une AMM.
- lettre de référence au CERSH du chercheur principal ;
- Rapports d'évaluation du CERSH ;
- le procès-verbal de la séance du CERSH ;
- le document notifiant la décision CERSH.

III.2. ÉVALUATION ADMINISTRATIVE DES PROTOCOLES DE RECHERCHE

Initiateur: Chercheur principal

Haut-parleurs): MINSANTE

L'évaluation administrative des projets de recherche relève de la compétence de la Division de la Recherche Opérationnelle en Santé (DROS) du Ministère de la Santé Publique [5, 24, 25],

III.2.1. Composition du dossier de demande d'Autorisation Administrative de Recherche

Les documents énumérés ci-dessous doivent être soumis dans l'ordre dans un seul document relié :

- la demande d'Autorisation Administrative de Recherche (AAR) adressée au Ministre chargé de la Santé Publique et signée par le Chercheur Principal ou le responsable de l'établissement de recherche ;
- le protocole de recherche daté et signé par le chercheur principal, approuvé par le promoteur ou le promoteur, et comprenant l'adresse de la personne physique ou morale qui soumet la demande (boîte postale, fax, téléphone, adresse email et le siège de l'établissement ou du centre de recherche);
- la fiche d'information du participant à la recherche en français et en anglais;
- le secrétaire permanent/technique en informe le président de la commission de resoumission ;
- le président du comité décide si le protocole nécessite un examen accéléré ou une évaluation normale par le comité ;
- si la modification est majeure, la resoumission est programmée à la prochaine session du CERSH pour être évaluée. Si la modification est considérée comme mineure, elle est confiée à un membre évaluateur qui en présente le rapport en séance ;
- les membres du CERSH décident de l'amendement majeur proposé. La décision prise à ce sujet par les membres sera transmise au chercheur principal ;
- le secrétariat technique mettra à disposition le compte rendu de la séance ;
- le Secrétaire Permanent/Technique conserve tous les documents et correspondances soumis pour modification.

b) Recours après avis défavorable du CERSH

Tout chercheur principal peut faire appel d'une décision défavorable ou d'une demande de modification obligatoire qu'il estime non justifiée.

❖Description de la procédure

- Le chercheur principal doit adresser au président du comité une demande dans laquelle il justifie son désaccord dans un délai maximum

de trente (30) jours à compter de la réception de la décision du CERSH ;
- le président du comité doit répondre au chercheur principal dans un délai de quatre à cinq (45) jours à compter de la date de saisine. Cette réponse pourra être une explication, rédigée lors de la réévaluation complète ou partielle du dossier de candidature. Celui-ci est tenu de répondre soit par écrit, soit lors d'une audience.

Les modifications mineures sont des corrections administratives dans le protocole, des changements d'adresse du promoteur, etc. Elles doivent être notifiées aux différents comités d'éthique concernés.

a. Resoumission d'une demande déjà approuvée/Modifications

Des modifications ne peuvent être apportées au projet de recherche sans l'approbation préalable du comité d'éthique.

❖Description de la procédure

- Le chercheur principal soumet au CERSH une demande d'approbation de modification contenant les éléments suivants :
- une lettre adressée au président de la commission expliquant les raisons de l'amendement ;
- une liste des modifications et leurs emplacements dans le protocole/formulaire de consentement éclairé ;
- les pages modifiées des documents initialement approuvés, où les modifications apportées à la version approuvée seront clairement décrites (fonction de suivi des modifications) ;
- la nouvelle version du protocole amendé, datée d'un numéro de version
- description des considérations éthiques liées à la modification ;
- la déclaration de toutes les démarches entreprises auprès des autres comités d'éthique et de leurs décisions en vue d'obtenir l'approbation des documents modifiés ;
- autorisation administrative de recherche le cas échéant ;
- le compte rendu des étapes protocolaires déjà réalisées le cas échéant.

❖Documents justifiant la procédure

- le document portant la décision finale du CERSH (habilitation éthique, lettre d'information, lettre de dérogation) ;
- le registre de déchargement du courrier du secrétariat du CERSH.

III. 1.10. Resoumission d'un protocole de recherche

Initiateur: Tout chercheur principal demandant une resoumission du projet de recherche au CERSH

Intervenant(s) : CERSH

Un protocole peut être soumis à nouveau dans le cas de [13] :

- les changements majeurs ayant un impact sur le rapport risque/bénéfice ou sur les informations contenues dans le formulaire de consentement ;
- avis défavorable du comité d'éthique ;
- amendements.

Une modification est considérée comme majeure lorsqu'elle a un impact significatif sur les objectifs, les hypothèses et/ou le design de l'étude, le site de réalisation de l'étude, les changements dans l'équipe de recherche, la sécurité des participants, l'interprétation des données scientifiques et la qualité. du produit médical étudié dans l'étude/l'essai clinique.

D'autres changements nécessitant une nouvelle soumission pour modification sont : les modifications apportées au protocole après approbation, les changements dans l'équipe de recherche, l'ajout de nouveaux sites de recherche ou la prolongation de la durée du projet, les changements dans les cibles de la recherche et l'éthique retenue par le comité du directeur. chercheur au plus tard, dans les quinze (15) jours suivant la délibération du protocole de recherche soumis.

Le tableau ci-dessous récapitule les délais de transmission et les éléments du communiqué de décision spécifiques à certains contextes.

Tableau 5 : contextes particuliers, types de décisions, contenu du document et délais de transmission du document contenant la décision CERSH

Contextes	Type de décision	Délai de transmission de la décision	Contenu du document communiquant la décision du CERSH

	Avis favorablesans modifications à apporter au projet de recherche soumis. **Avis favorable**sous réserve de modifications recommandées par le CERSH. Avis défavorable à la mise en œuvre du projet de recherche soumis.			i) titre exact du protocole de recherche examiné : ii) ii. Identification claire du protocole de recherche ou de la modification proposée : noms, dates et numéro de version des documents examinés iii) iii. Suggestions éventuellement faites par le comité par lettre d'information structurée selon le plan de revue éthique ; iv) Décision finale; v) Justification claire de la désapprobation et de l'exemption de l'autorisation éthique.
Cas d'urgence	Renonciation/exemption à l'autorisation éthique.	72 heures		
Session ordinaire	Comme dans les situations d'urgence.	15 heures	Même	

- pendant le processus d'évaluation, le CERSH peut demander des informations complémentaires
- les informations ou modifications à apporter au protocole avant d'émettre un avis ;
- en cas de réserves exprimées sur le bien-fondé d'un protocole, un nouvel examen par le CERSH est requis,

A l'issue de l'évaluation de la validité des aspects scientifiques et éthiques du protocole de recherche par le CERSH, les résultats suivants sont possibles :

- avis favorable sans modifications à apporter au projet de recherche soumis ;
- avis favorable sous réserve des modifications recommandées par le CERSH ;
- avis défavorable à la mise en œuvre du projet de recherche soumis ;
- exemption/dispense d'autorisation éthique ».

Toute décision du comité d'éthique doit être motivée et notifiée par écrit au soumissionnaire.

En cas d'avis défavorable, le chercheur principal peut faire appel par écrit auprès du président de la commission (3.1.10.2. Recours après avis défavorable du CERSH).

❖Documents justifiant la procédure

- procès-verbal de la séance d'évaluation du protocole de recherche ;
- autorisation éthique ou lettre d'information sur la décision CERSH.

III. 1.9. Communication de la décision CERSH

Initiateur: Secrétaire permanent ou technique du CERSH

Haut-parleurs): Secrétariat technique du CERSH, enquêteurprincipal

❖Description de la procédure

- le chercheur principal doit justifier que son projet de recherche répond aux critères ci-dessus ;
- en séance, le CERSH évalue la demande et décide d'accorder ou non une dispense d'évaluation ;
- le chercheur principal est informé si l'exemption d'autorisation éthique a été accordée ou non par le CERSH ;
- le chercheur principal ayant obtenu une réponse défavorable peut présenter un amendement, ou demander sa participation à la prochaine séance du comité pour apporter des explications complémentaires.

❖Documents justifiant la procédure

- grille d'évaluation du protocole de recherche;
- notification de dispense d'habilitation déontologique signée par le Président,

III.1.8. Prise de décision CERSH

Initiateur : , Président du comité

Haut-parleurs): Membres du CERSH

- Tous les membres du CERSH doivent avoir la possibilité de s'exprimer et être invités à le faire [13]. Ils sont tenus au secret des délibérations tenues. Un engagement devra être signé à cet effet lors de la sélection des membres.vau CERSH,

❖Description du processus

- après présentation du rapport d'évaluation par les membres du CERSH et/ou les experts indépendants qui en disposent. étant donné cette responsabilité, un consensus est souhaitable pour la prise de décision.

A défaut, un vote est organisé et les décisions sont prises à la majorité simple ;
- si l'étude porte sur des données secondaires de patients, ces données pourront être utilisées à condition qu'elles soient anonymes et à usage confidentiel,

❖**Documents justifiant la procédure**

- Justification de la renonciation au consentement éclairé dans le protocole ;
- grille d'évaluation du protocole soumis;
- procès-verbal de la séance ;
- rapports de synthèse évaluant le protocole soumis.

III. 1.7. Dispense d'autorisation éthique

Initiateur: Tout chercheur principal dont le projet de recherche n'implique pas explicitement l'obtention d'une autorisation éthique

Intervenant(s) : CERSH

Certaines études peuvent notamment être exemptées d'autorisation éthique ;

- études utilisant des bases de données en ligne publiées et autorisées dans le cadre de recherches ;
- études utilisant des données codées (bases de données anonymes, codage de noms individuels) ;
- études relatives à l'examen de documents publiés ou placés dans le domaine public (articles scientifiques, textes législatifs et réglementaires, directives, etc.) ;
- des études relatives à l'évaluation d'un programme/service de santé ou d'un protocole de soins dont les résultats serviront uniquement à améliorer la performance du programme/service concerné.

NB : La décision de renoncer à l'habilitation éthique est néanmoins prise par le CERSH après analyse.

- si l'obtention du consentement pourrait compromettre le résultat de l'étude (utilisation de données anonymes, utilisation de matériel biologique anonyme, études de type écologique et migratoire où la cible est un groupe et non un individu) ;
- si l'étude implique des données secondaires ;
- si des données individuelles ne sont pas collectées.

Dans le cas où l'étude répond aux situations ci-dessus, le chercheur doit demander au CERSH, une dispense de consentement éclairé.

♦Description de la procédure

- le chercheur principal doit justifier que son projet de recherche est conforme aux critères évoqués ;
- en séance, le CERSH évalue la demande et décide d'accorder ou non une renonciation au consentement ;

A cette fin, les évaluateurs doivent vérifier que :

- l'utilisation des registres/bases de données est autorisée par les institutions qui les hébergent ;
- la procédure de confidentialité utilisée permet de protéger l'accès ou l'utilisation des renseignements personnels dans les registres/base de données ;
- l'exemption du consentement éclairé n'affecte pas les droits et le bien-être des participants à la recherche ;
- l'étude concerne des échantillons biologiques et/ou des données personnelles collectées dans le cadre d'une recherche avec le consentement préalable et éclairé des participants pour/l'utilisation ultérieure de leurs données/échantillons ;
- technologie, prestations médicales ou participation aux droits de propriété intellectuelle) ;
- un plan de sécurité et de surveillance des données est joint au protocole ;
- le processus d'obtention et de documentation du consentement suit les normes ;
- le chercheur principal doit fournir la brochure du chercheur : données précliniques (expérimentation animale) et résultats des essais cliniques de phase précoce (le cas échéant).

III. 1.5. Évaluer la situation de conflit d'intérêts du chercheur

Quel que soit le type de recherche, les évaluateurs devront s'assurer que le chercheur a déclaré un conflit d'intérêts [7]. Voir la procédure dans la section [2.2.14], Gestion des conflits d'intérêts lors des évaluations éthiques des protocoles de recherche.

III. 1.6. Dispense du consentement éclairé

Initiateur : Tout chercheur principal dont l'étude n'implique pas l'obtention

consentement éclairé pour l'utilisation d'informations, de données et/ou d'échantillons

Intervenant(s) : Membres du CERSH

Situations d'exemption du consentement éclairé pour l'étude

Les situations décrites ci-dessous peuvent conduire à une dispense du consentement éclairé pour la recherche.

- S'il n'est pas possible d'accéder au participant.
- Si le risque de violation de l'autonomie et de la confidentialité est mineur
- Les tests à effectuer sur les échantillons sont répertoriés et limités à répondre aux questions de recherche décrites dans le protocole.
- il existe une justification claire pour la nécessité de transférer les échantillons (vérifier qu'il n'y a aucune possibilité de faire les tests nécessaires localement) ;
- un accord de transfert de matériel (Material Transfer Agreement) est signé entre le site de prélèvement des échantillons, l'équipe de recherche qui envoie les échantillons et l'équipe qui reçoit les échantillons ;
- Le contrat de transfert de matériel est établi selon le schéma ci-joint,

d) Critères spécifiques d'évaluation des protocoles de recherche sur les médecines traditionnelles améliorées (MTA)

Pour le cas particulier des essais cliniques avec des produits de phytothérapie ou. Pour toute autre thérapie alternative, l'évaluation des protocoles de recherche se fait uniquement pour les catégories MTA 3 et 4. Cette catégorisation est faite par la DPML.

Le CERSH, outre les éléments requis pour une demande d'habilitation éthique, examine et évalue les éléments suivants [23] :

- la composition de l'équipe de recherche comprend au moins une personne possédant des compétences en médecine clinique ;
- il existe des plans pour préserver les pratiques traditionnelles et les droits de propriété intellectuelle ;
- le respect des normes internationales sur l'accès et le partage des avantages (APA) :
- l'existence d'un plan de partage des bénéfices en cas de commercialisation du produit ou du procédé de recherche ou d'obtention d'un brevet (cession de
- le site de recherche : les capacités du site en termes de plateau technique pour répondre aux urgences pouvant naître de la mise en œuvre et du suivi de l'intervention dans le cadre de l'étude ;
- notification, investigation et réponse aux événements indésirables : circuit compatible avec le système national de notification des

événements indésirables ; procédure d'enquête pour établir l'imputabilité des événements indésirables graves (EIG) et des signaux ; protocole pour leur traitement ;
- certification d'une police d'assurance qui couvre les participants pendant toute la durée de l'étude et disponibilité des ressources pour son renouvellement et sa validité ;
- le fonctionnement du Data Safety Monitoring Board (DSMB) : sa composition (présence obligatoire d'experts capables de comprendre et d'enquêter sur les EIG), l'indépendance de ses membres par rapport à l'équipe d'enquête, une fréquence adaptée des réunions de suivi des EIG, la composition des membres accès à la procédure de mise en aveugle ; les conditions et le pouvoir de décision pour arrêter l'essai clinique en cas de risque majeur détecté ;
- suivi et audit de l'essai : vérifier s'il existe un plan de suivi interne et externe ; un plan d'utilisation des résultats de ce suivi pour améliorer les résultats de l'essai ; un audit prévu à la fin du test.

c)Critères spécifiques d'évaluation des protocoles de recherche impliquant un transfert de matériel biologique entre équipes d'investigateurs [7]

Le comité doit s'assurer lors de l'évaluation que :

- le transfert permet de répondre à une question de recherche ;
- l'imputabilité des événements indésirables graves et les signaux et protocoles pour leur gestion ;
- certification d'une police d'assurance qui protège les participants pendant toute la durée de l'étude et que des ressources sont disponibles pour son renouvellement et sa validité ;
- l'adéquation de la composition et du fonctionnement du Data Safety Monitoring Board (DSMB) (Pour les phases 1, 2 et 3) : la présence obligatoire d'experts capables de comprendre et d'enquêter sur les événements indésirables graves, l'indépendance des membres de l'équipe d'enquête, un fréquence appropriée des réunions de suivi des événements indésirables graves, accès des membres à la procédure d'aveugle ; les conditions et le pouvoir de décision pour arrêter l'essai clinique en cas de risque majeur détecté ;
- l'existence d'un plan de surveillance et d'audit interne et externe de l'essai : un plan d'utilisation des résultats de ce suivi pour améliorer les résultats de l'essai et un audit prévu à la fin de l'essai.

d) Critères d'évaluation spécifiques pour les essais cliniques impliquant des interventions médicales [22]

L'évaluateur doit vérifier :

- la description de l'intervention testée : procédure détaillée en termes d'actions et d'équipements, les résultats des expériences antérieures,

l'inventaire des risques pouvant survenir et des mesures d'intervention, les avantages par rapport aux normes en vigueur ;
- la description de l'intervention de contrôle : procédure détaillée en termes d'actions et d'équipements, l'inventaire des risques pouvant survenir et des mesures de réponse, les avantages par rapport aux normes en vigueur ;

NB : Le document de convention doit être signé par les personnes suivantes : l'expéditeur, le destinataire et le responsable de la sécurité de l'échantillon.

❖Critères d'évaluation des protocoles de recherche pour des cas particuliers
a) Critères d'évaluation des protocoles de recherche pour les essais cliniques avec des produits d'intervention [22]

Pour ce cas particulier, il s'agira de comparer les inconvénients prévisibles avec les avantages attendus pour les participants et les communautés concernées par la recherche. A cette fin, les évaluateurs vérifieront que :

- la brochure de l'enquêteur contient toutes les informations (telles que présentées dans le tableau 3) ;
- le bilan du médicament est complet et systématisé : description du médicament galénique, posologies et conditions de conservation ; personne en charge de l'administration, de l'adéquation du stock par rapport à la demande, du système de contrôle qualité, de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion des stocks, des procédures de destruction du médicament à la fin de l'essai ;
- la description du médicament témoin et/ou placebo correspond au protocole/médicament standard, justification de l'utilisation d'un placebo ;
- le site de recherche a la capacité en termes de plateau technique pour répondre aux urgences pouvant survenir dès la première administration du produit aux participants (phase 1) et pour la mise en œuvre et le suivi de l'intervention dans le cadre de l'étude (phases 1,2 ,3 et 4);
- la notification, l'investigation et la réponse aux événements indésirables sont clairement décrites : circuit compatible avec le système national de notification des événements indésirables ;
- procédure d'enquête pour établir
- L'accord de partage de données doit prévoir ce qui suit :
- la base de données collectée est hébergée au Cameroun ;
- des procédures de sécurisation des données collectées existent (méthode d'archivage) ;
- l'ordre des auteurs dans les publications est précis et juste ;
- l'accès à la base de données collectée est équitable (accès des enquêteurs locaux à la base de données de tous les sites d'une étude multi-pays ou multicentrique).

■L'accord de transfert de matériel

Il doit être signé pour les études impliquant un échange de matériel biologique entre les établissements intervenants. Les évaluateurs veilleront à ce que cet accord comprenne au moins les informations suivantes :

- la nature, la quantité et la fréquence du transfert des échantillons ;
- la description des échantillons en termes d'origine, de volume, de méthode et de durée de stockage et de transport ;
- le nom et l'adresse de l'expéditeur et de son institution ;
- le nom et l'adresse du destinataire et de son institution ;
- la méthode de destruction ;
- les conditions de transformation des produits dérivés ;
- les conditions de partage avec d'autres laboratoires ;

équité dans le partage des bénéfices générés par les produits dérivés du matériel biologique transféré (propriété intellectuelle, brevet d'exploitation et commercialisation) ;

- la loi applicable à la sécurité des échantillons et la personne référente. des informations disponibles et pertinentes sur les risques et les avantages pour maintenir leur consentement éclairé ;
- La procédure comprend des dispositions pour recevoir et répondre aux préoccupations/plaintes des participants ou de leurs représentants avant et pendant l'étude.

f) Respect de la confidentialité

Les évaluateurs doivent s'assurer que les outils de collecte de données et les procédures de collecte, d'analyse et de présentation des résultats ne permettent pas l'identification des participants.

Pour ce faire, ils vérifieront que :

- l'accès aux bases de données est réservé à l'équipe de recherche ;
- le système de codage est approprié (dans le cas où il existe un registre de codes).

g) Partenariat collaboratif pour améliorer l'accès aux résultats de la recherche

La garantie du partage des résultats de la recherche doit être assurée [1, 7].

Les évaluateurs devront vérifier que le protocole de recherche prévoit un plan de collaboration entre les acteurs (gouvernement, sponsor, autorités sanitaires et communauté), garantissant l'accès des populations aux résultats

de la recherche sur les plans financier et technologique (plateforme technique). et la formation des ressources humaines.

Si les données proviennent et/ou sont utilisées par plusieurs institutions, les évaluateurs vérifieront qu'il existe un accord de partage de données signé par toutes les parties prenantes ainsi qu'un plan de diffusion des résultats de la recherche.

❖Consentement parmi les groupes/individus vulnérables

Une personne vulnérable [1, 7] est toute personne présentant une situation

de santé, physique, sociale et/ou économique qui ne leur permet pas d'assumer leur autonomie et/ou de donner librement leur consentement (enfants, femmes enceintes, nouveau-nés, fœtus, jeunes sans abri, personnes atteintes de troubles mentaux/psychiatriques, économiques ou scolaires) défavorisés, marginalisés, personnes en phase terminale, prisonniers, etc.).

Outre la notice d'information contenant des informations générales, les évaluateurs vérifieront que :

- l'étude fournit un formulaire de consentement permettant au représentant légal d'autoriser la personne à participer à l'étude ;

- l'étude donne la possibilité au participant vulnérable ayant retrouvé son autonomie de donner son consentement.

♦Consentement des participants à une urgence médicale [1]

Nous parlons ici d'urgences prévisibles (les personnes confrontées à des urgences non prévisibles sont classées parmi les groupes vulnérables).

Les évaluateurs doivent vérifier que la collecte du consentement est planifiée avant que l'urgence ne survienne.

e3) Suivi du consentement éclairé

La procédure d'obtention du consentement éclairé doit également décrire la manière dont le suivi sera effectué pendant la période de mise en œuvre du projet de recherche.

Pour ce faire, les évaluateurs vérifieront que :

- la procédure prévoit les modalités de réception des participants pendant l'étude (essais cliniques et cohortes) et à une périodicité définie

- le formulaire de consentement éclairé contient les informations suivantes : titre du projet, la phrase d'acceptation, l'espace pour le nom du participant, l'espace pour la signature du participant et des éventuels témoins ;

- Le langage utilisé sur les documents de consentement est simple et compréhensible pour le participant.

❖Consentement pour les enfants de moins de 12 ans

Les évaluateurs vérifieront que :

-la notice d'information contenant des informations générales destinées à obtenir le consentement est offerte au parent ou au tuteur ;

-le formulaire d'autorisation parentale est offert au parent/tuteur de l'enfant.

❖Consentement pour les mineurs de 12 à 20 ans

Les évaluateurs vérifieront que :

-la notice d'information contenant des informations générales destinées à obtenir le consentement est offerte au parent ou au tuteur ;

- un formulaire d'assentiment est proposé à l'enfant ; ce formulaire doit comporter les informations suivantes : titre du projet, phrase d'acceptation, espace pour le nom du participant, espace pour la signature du participant et des éventuels témoins ;

-un formulaire d'autorisation parentale est disponible.

❖Consentement d'un mineur émancipé

Selon les dispositions du code civil applicable au Cameroun [21], est considérée comme mineur émancipé toute personne âgée de moins de 21 ans (mineur) qui est mariée, ou déclarée comme telle par une décision légalement valable des parents à compter de l'âge de quinze.

Dans ce cas, les évaluateurs s'assureront que l'étude prévoit d'appliquer la même procédure d'obtention du consentement que chez l'adulte.

- le lieu où le consentement est recueilli respecte la confidentialité, le confort et la sécurité des participants ;
- si l'étude prévoit l'auto-collecte du consentement, qu'un membre de l'équipe lise et explique au participant ;
- la langue et le langage utilisés sont appropriés et compréhensibles pour le participant ;

La procédure de collecte de consentement permet au participant de poser des questions de clarification avant de participer.

Outre les conditions générales citées ci-dessus, les critères spécifiques suivants feront l'objet de l'évaluation du processus d'obtention du consentement éclairé des participants à une étude,

e2) Conditions particulières

❖Consentement des adultes

Les évaluateurs vérifieront que :

- la notice d'information comprend les informations suivantes : titre du projet, nom et adresse complète du chercheur principal, objectifs, modalités de l'étude (mode d'administration du questionnaire, prélèvement des échantillons, échantillonnage, randomisation, analyse des données, durée de la collecte et du suivi des données , fréquence des visites), risques et bénéfices de l'étude, information sur le caractère volontaire et refus sans conséquences de la participation du sujet à l'étude, indemnisation éventuelle et justification des montants, possibilité de retirer le consentement l'adresse des personnes à contact en cas de soucis ; l'étude prévoit qu'une copie de l'avis soit remise au participant;

e) Le processus d'obtention du consentement éclairé

Cela varie en fonction du type de participant et de la source de données. On distingue ainsi :

- sources de données directes : adulte (21 ans et plus) ; enfant (moins de 12 ans) ; adolescent (12 à 20 ans) ; personnes vulnérables; participants aux situations d'urgence;
- sources de données indirectes : dossiers patients, base de données, bibliothèque de sérums ou biobanque ;
- une communauté ou un groupe.

e1) Conditions générales

Quel que soit le type de participant à l'étude et la source de données, l'évaluation du processus d'obtention du consentement des participants à la recherche se concentrera sur la vérification des aspects suivants :

- la documentation de consentement/assentiment pertinente est disponible (notice d'information, formulaire de consentement éclairé, formulaire d'assentiment, formulaire d'autorisation parentale), rédigée en français et en anglais ;
- la procédure d'obtention du consentement est clairement décrite dans le protocole et prévoit, le cas échéant, une traduction dans les dialectes locaux ;
- cette procédure n'expose pas le participant à : la subordination, l'induction, la pression et/ou l'exploitation ;
- la procédure offre au participant la possibilité d'accepter ou de refuser son consentement pour l'utilisation de ses données ou échantillons pour des études ultérieures ;

À cette fin, les évaluateurs doivent :

- faire un état des lieux des bénéfices attendus (améliorations de l'efficacité, de la sécurité ou amélioration de l'accessibilité aux soins), qui couvriront les aspects suivants : individuels (physiques, physiologiques, psychologiques, émotionnels, dignité et droits) ; sociaux (perturbations des normes et des organisations familiales, sociales et culturelles) et environnementaux pouvant avoir un impact sur les individus ou la société ;
- juger si les bénéfices sont raisonnables par rapport aux risques ;
- identifier les avantages directs et indirects de l'étude ;
- vérifier s'il existe une alternative ou une procédure susceptible d'améliorer le rapport risque/bénéfice.

d) Sélection équitable des participants

Le choix des participants à la recherche doit être fait équitablement. Pour ce faire, les évaluateurs doivent vérifier si :

- les critères d'éligibilité sont clairement définis ;
- les critères de retrait ou d'interruption de la participation à l'étude sont clairement définis ;
- toutes les strates pouvant bénéficier de la recherche seront éligibles au recrutement ;
- des précautions de protection spéciales pour les populations vulnérables sont prises ;
- les personnes éligibles ou incluses correspondent aux bénéficiaires directs de la recherche ;
- les personnes présentant le plus grand risque de préjudice sont exclues ;
- la sélection des participants est faite de manière à ne pas influencer le résultat.
- le produit a fait l'objet d'une description claire, la phase du test est précisée ;
- les résultats des phases précédentes sont clairement décrits ;
- le choix des variables d'intérêt est justifié.

Si la recherche nécessite des examens paracliniques, s'assurer qu'une procédure de contrôle qualité est planifiée et décrite.

Le cas échéant, assurez-vous que :

l'instrument à tester est annexé ou les éléments à collecter sont au moins décrits ;

- le pré-test des instruments est décrit.

L'évaluation de la validité scientifique permet également de préciser dans quelle perspective se situe la recherche et de quel type d'étude il s'agit :

- recherche observationnelle (descriptive, analytique, etc.);
- recherche interventionnelle (essai : essai thérapeutique, essai vaccinal, évaluation d'équipement biomédical, évaluation d'un dispositif médical ou d'une technique médicale) ;
- Recherche & Développement;
- étude nationale, régionale ou institutionnelle ;
- étude multi-pays.

c) Analyse risques-avantages

Il s'agit d'un jugement de valeur entre les risques encourus par les participants, la morbidité et la mortalité et l'impact socio-économique du problème de santé ciblé et l'apport attendu du protocole à évaluer.

- vérification aléatoire des formulaires de consentement éclairé conservés par le chercheur dans les dossiers des participants ;
- examen sur place des mesures prises pour assurer la confidentialité des informations ;
- visiter des sites de recherche;
- la revue périodique des documents produits dans le cadre du projet de recherche (questionnaires, formulaires de consentement, rapports d'événements graves).

❖Description de la procédure

- le superviseur et le chercheur principal conviennent de la date, de l'heure et du lieu du suivi, ainsi que des documents nécessaires ;
- à l'aide des check-lists/grille de suivi, l'encadrant examine tout ou partie des aspects des modalités de participation à la recherche (voir annexe n° 2) ;
- après une visite de suivi, une réunion est organisée avec le chercheur principal pour l'informer des conclusions éventuelles ;
- les données collectées sont ensuite analysées et un rapport est rédigé, tous les commentaires, recommandations et mesures correctives et préventives appropriées (si le suivi révèle des problèmes ou des déficiences) sont inclus dans le rapport qui sera envoyé au chercheur principal
- le rapport écrit est conservé simultanément au CERSH et au MINSANTE.

Le rapport de toute information nouvelle sur des éléments susceptibles d'augmenter les risques et les inconvénients pour les sujets, de nuire au bon déroulement du projet ou d'avoir un impact sur le désir d'un sujet de continuer à participer au projet doit contenir les informations suivantes : :

- le nom de l'autorité effectuant la surveillance ou le contrôle ;
- la nature des nouvelles informations/problèmes notés ;
- le nombre de sujets concernés par ces éléments ;
- les répercussions de ces éléments sur la suite du projet et sur les sujets ;
- mesures correctives et préventives;
- tout promoteur externe doit également être informé des résultats ;
- L'enquêteur a la possibilité de répondre par écrit aux conclusions du rapport, en fournissant des preuves supplémentaires à l'appui et/ou en prenant les mesures requises spécifiées dans le rapport.
- Si des mesures correctives et préventives ne sont pas prises en compte ou si un risque immédiat est détecté, un arrêt temporaire de l'étude pourra être envisagé.

❖**Documents de procédure**

- note organisant la supervision
- preuve de notification/informations de suivi auprès du chercheur principal ;
- grilles de suivi complétées ;
- registres de présence/listes des personnes supervisées ;
- rapports de supervision/suivi ;
- preuve de notification et transmission du rapport d'enquête à l'investigateur principal, au secrétariat du CERSH, au MINSANTE et au promoteur/sponsor de la recherche.

IV.2. TRAÇABILITÉ/STOCKAGE DES DONNÉES DE MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE DE RECHERCHE

Initiateur: Secrétariat du CERSH, MINSANTE

Haut-parleurs): CERSH, DROS

Pour le CERSH et le MINSANTE, il s'agit d'assurer la traçabilité de chaque travail de recherche réalisé [1].

❖Description de la procédure

- Toute la documentation relative à la mise en œuvre d'un projet de recherche doit être enregistrée dans une base de données sur support numérique (clé USB), au secrétariat du comité d'éthique et au MINSANTE.

- Cette base de données contiendra au minimum les informations suivantes :
- les coordonnées du chercheur principal et du ou des co-chercheurs ;
- la composition de l'équipe de recherche;
- les références de l'habilitation éthique et de l'autorisation administrative de recherche ;
- sites de recherche;
- les étapes clés du calendrier final de mise en œuvre des travaux de recherche ;
- preuve de restitution des résultats de recherche (articles scientifiques, résumés de conférences scientifiques, compte rendu de séances de restitution, etc.) ;
- rapport d'évaluation éthique et scientifique du projet ;
- tout document soumis par le chercheur au cours du projet, incluant les documents relatifs au suivi continu ;
- tout échange entre le comité d'éthique et l'équipe de recherche ou les parties concernées ;
- tout échange entre les membres du comité d'éthique relatif au projet de recherche.
- Un dossier physique complet comprenant toute la documentation liée à un protocole de recherche doit également être conservé par le secrétariat du CERSH et le MINSANTE.

❖**Documents de procédure**

- support numérique ;
- dossier physique complet du protocole de recherche.

IV.3. MESURES À PRENDRE EN CAS DE PROBLÈMES D'INTÉGRITÉ ET DE NON-RESPECT DE L'ÉTHIQUE IDENTIFIÉS PAR UN SUIVI CONTINU.

Lorsqu'un superviseur/examinateur a des raisons de croire que la poursuite d'un projet de recherche compromettra le bien-être des participants [1], les autorités de réglementation et/ou le comité d'éthique peuvent :

- retirer respectivement l'AAR et/ou l'autorisation éthique d'un projet de recherche si nécessaire ;
- signaler aux autorités administratives ou étatiques toute violation grave ou répétée des normes éthiques ;
- demander aux autorités compétentes la suspension de l'autorisation de bénéficier de financements pour la recherche, de réaliser des interventions expérimentales ou de l'autorisation d'exercer la médecine ;

- demander aux revues scientifiques qui ont publié les résultats d'une étude de retirer tout article qui s'avère ensuite fondé sur des données falsifiées ou qui repose sur des recherches contraires à l'éthique.

IV,4. GESTION DES DEMANDES, NON-RESPECT OU DÉVIATION DE PROTOCOLE

Initiateur: CERSH, Secrétariat DROS

Haut-parleurs): CERSH, MINSANTE

Suite aux activités de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre d'un projet de recherche, le CERSH ou le MINSANTE peuvent exiger la modification de la recherche, suspendre ou retirer l'agrément éthique et administratif de la recherche [1].

- La suspension d'une autorisation éthique/AAR signifie que toutes les activités du projet doivent cesser (recrutement de sujets, analyses de données et publication de données existantes) jusqu'à ce que tous les problèmes en suspens soient résolus. manière satisfaisante. Les études suspendues sont toujours approuvées, mais dans un statut « en attente » jusqu'à ce que les problèmes en suspens soient résolus.
- Le retrait d'une autorisation éthique/AAR signifie que l'étude n'est plus approuvée. Toutes les activités du projet doivent cesser immédiatement, y compris l'analyse des données. Toute donnée ou analyse résultante est nulle.

Les situations suivantes peuvent être sources d'inquiétude pour le MINSANTE et le CERSH :

- la poursuite des recherches ne permet pas de respecter un équilibre acceptable entre les risques et les bénéfices potentiels pour les participants ;
- la recherche n'est pas réalisée conformément au protocole approuvé par les autorités et aux exigences réglementaires ;
- la recherche est associée à des préjudices graves et imprévus pour les participants (qui peuvent avoir été déterminés à la suite d'un examen des événements à signaler par le CERSH ou le MINSANTE (DROS/DPML) ou des rapports du comité de surveillance sur la sécurité des données/du comité de surveillance de la sécurité des données) ;
- falsification de fichiers ou de données de recherche ;
- non-respect des conditions préalablement imposées par le CERSH ou le MINSANTE ;

- échec répété ou délibéré d'obtenir le consentement ou de documenter correctement le processus de consentement des participants à la recherche ;
- le non-respect répété ou volontaire des conditions imposées par le CERSH, le promoteur ou le MINSANTE ;
- non-respect répété ou volontaire de l'obtention de l'agrément du CERSH et du MINSANTE, modifications ou changements apportés au protocole de recherche ;
- le non-respect répété ou délibéré de la bonne tenue des dossiers de recherche ou de la déclaration des événements devant être signalés au CERSH/à l'autorité de réglementation.
- Le président du CERSH n'est pas autorisé à retirer l'approbation d'une recherche sans consultation des autres membres du comité d'éthique.
- Toutefois, il est autorisé à suspendre l'approbation d'une recherche en cas d'urgence lorsque les droits, la sécurité ou le bien-être des sujets sont en danger immédiat. Cette suspension doit alors être déclarée respectivement au CERSH lors de sa prochaine séance plénière et à une commission d'experts constituée par le MINSANTE. Le CERSH et/ou le MINSANTE peuvent retirer leur agrément après étude de la question en séance plénière avec les membres du comité ou de la commission.
- La décision de suspendre ou de retirer l'approbation de la recherche par le CERSH/MINSANTE doit tenir compte de la sécurité, des droits et du bien-être des participants déjà inscrits à la recherche. Il prend également en compte les mesures à prendre pour garantir la qualité des soins reçus par les participants, les mesures prises pour aviser les participants de la suspension ou de l'arrêt de la recherche, ainsi que le délai approprié pour leur transmettre ces informations.

❖ **Description de la procédure**

- le président du CERSH ou le Ministre de la Santé Publique notifie par lettre officielle à l'investigateur toute suspension ou retrait d'agrément de la recherche par le CERSH/MINSANTE en précisant les motifs de l'adoption de cette mesure et les mesures correctives proposées, le cas échéant.
- le président du CERSH ou le Ministre de la Santé Publique informe les établissements/sites abritant le projet et les organismes de réglementation (le cas échéant).
- Le chercheur principal est responsable d'informer en temps opportun tous les co-chercheurs, l'équipe de recherche et les partenaires associés au projet, ainsi que les sujets inscrits à l'étude.
- Le chercheur principal devra élaborer des procédures de retrait qui protègent les droits, la sécurité et le bien-être des participants et les décrire aux participants.

❖ **Documents de procédure**

- Lettre de suspension ou de retrait de l'habilitation éthique ou de l'autorisation administrative de recherche.

IV.6. LEVÉE DE LA SUSPENSION DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE RECHERCHE ET DE L'AUTORISATION ÉTHIQUE

Initiateur: Chercheur principal

Haut-parleurs): CERSH, Président du CERSH, Ministre de la Santé, DROS, Chercheur principal

- La suspension pourra être levée après que des mesures correctives auront été prises à la satisfaction du CERSH, du MINSANTE et des autres organismes concernés, le cas échéant.
- Pour rétablir un projet de recherche suspendu, l'investigateur doit « résoudre de manière satisfaisante toutes les questions en suspens. Après un an de suspension ou la date d'expiration de l'étude, si aucun progrès n'a été réalisé sur les questions en suspens, le CERSH et le MINSANTE sont procéder au retrait de l'autorisation éthique et de l'AAR.

❖ **Description de la procédure**

- Le chercheur principal doit contacter le CERSH/MINSANTE par écrit dans les 60 jours suivant la suspension. Il doit présenter une candidature comprenant et répondant aux exigences suivantes :
- le motif de la demande de reprise de l'étude ;
- un bref résumé de l'objectif de l'étude et des objectifs/résultats attendus ; ceux-ci peuvent être incorporés dans le protocole, en notant tout changement, révision ou clarification du protocole ;
- description des modifications apportées, le cas échéant, depuis l'approbation initiale ;
- un résumé de l'avancement de l'étude comprenant : le nombre de sujets déjà inscrits, la phase de mise en œuvre des procédures au moment de la suspension, tout événement indésirable survenu et la manière dont ces événements indésirables seront atténués une fois terminé, tout complément pertinent information;
- une procédure et un engagement sur l'honneur démontrant que le motif de suspension ne se reproduira pas et que l'étude sera conforme à toutes les lois et réglementations applicables.

- la demande de levée de suspension fait l'objet d'un examen lors d'une séance du CERSH et d'une réunion de la commission d'experts du MINSANTE ;
- les examinateurs analysent et décident selon la procédure connue ;
- en cas de rétablissement de l'approbation d'un protocole par le CERSH/MIN SANTE, il peut être exigé que les sujets précédemment inscrits soient réinscrits ;
- la décision est notifiée au chercheur principal ; et à toute autre personne concernée (promoteur, plaignants, gestionnaires de sites de recherche, autres).

♦Documents de la procédure

- dossier demandant la levée de l'autorisation éthique/suspension de l'AAR ;
- procès-verbal de l'évaluation du CERSH et de la réunion de la commission ;
- le rapport CERSH ;
- la notification de décision du CERSH et du MINSANTE.

IV.7. SUIVI DE LA COLLABORATION AU SEIN DE L'ÉQUIPE DE CHERCHEURS ET AVEC LES AUTRES ACTEURS DU TERRAIN/SITE DE RECHERCHE

- La responsabilité de mettre en place un comité de gouvernance du projet de recherche incombe au promoteur de l'étude. Il s'agit de capturer toutes les informations concernant l'efficacité de :
- sites de recherche annoncés ;
- collaboration entre équipes de recherche et gestionnaires de sites de recherche (suivi interne du site de recherche) [1,7] ;
- encadrement des travaux de recherche par l'équipe de recherche annoncée dans le protocole ;
- l'échange de données/matériels au sein de l'équipe de recherche.

La plupart des collaborations nécessiteront généralement que certains des éléments suivants soient pris en compte :

- des engagements en termes de financement et de ressources en nature ;
- les tâches et responsabilités essentielles des partenaires ;
- les modalités de gestion de projet, y compris les canaux hiérarchiques et de communication ;
- exigences et responsabilités en matière de formation ;
- les dispositions en matière de santé et de sécurité pour le personnel ;
- paternité des publications;
- Propriété intellectuelle ;

- un bref résumé de l'objectif de l'étude et des objectifs/résultats attendus ; ceux-ci peuvent être incorporés dans le protocole, en notant tout changement, révision ou clarification du protocole ;
- description des modifications apportées, le cas échéant, depuis l'approbation initiale ;
- un résumé de l'avancement de l'étude comprenant : le nombre de sujets déjà inscrits, la phase de mise en œuvre des procédures au moment de la suspension, tout événement indésirable survenu et la manière dont ces événements indésirables seront atténués une fois terminé, tout complément pertinent information;
- une procédure et un engagement sur l'honneur démontrant que le motif de suspension ne se reproduira pas et que l'étude sera conforme à toutes les lois et réglementations applicables.
- la demande de levée de suspension fait l'objet d'un examen lors d'une séance du CERSH et d'une réunion de la commission d'experts du MINSANTE ;
- les examinateurs analysent et décident selon la procédure connue
- en cas de rétablissement de l'approbation d'un protocole par le CERSH/MINSANTE, il peut être nécessaire que les sujets précédemment inscrits soient réinscrits ;
- la décision est notifiée au chercheur principal ; et à toute autre personne concernée (promoteur, plaignants, gestionnaires de sites de recherche, autres).
- le stockage, le transfert et les conditions d'utilisation future des données et des échantillons de recherche (y compris le retour ou la destruction) ;
- les exigences spécifiques en matière de gouvernance et de sécurité de l'information, y compris la tenue, la gestion et le traitement des dossiers ;
- contributions/ressources financières et responsabilités/rémunération.

Il s'agira de vérifier l'existence et la connaissance par toutes les parties prenantes des procédures opérationnelles standard (SOP), de gestion du projet de recherche.

IV.8. SUIVI ET ÉVALUATION DES STRUCTURES IMPLIQUÉES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE RECHERCHE

Ce suivi est effectué annuellement par la Division de la Recherche Opérationnelle en Santé (DROS) du Ministère de la Santé Publique. Cela implique de s'assurer que :

- ces structures disposent des ressources leur permettant d'assurer la protection des participants à la recherche lors de la planification et de la mise en œuvre des projets de recherche en santé humaine ;

- la mise en œuvre des protocoles se fait conformément aux réglementations nationales ;
- des mesures sont prises pour rendre les résultats de la recherche accessibles aux communautés bénéficiaires de la recherche, aux décideurs et aux scientifiques.

Les indicateurs retenus sont présentés dans la grille d'encadrement des sites menant ou accueillant des projets de recherche en santé humaine (voir annexe).

IV.9. SUIVI ET ÉVALUATION DES PROTOCOLES D'ESSAIS CLINIQUES PAR L'AUTORITÉ NATIONALE DE RÉGLEMENTATION PHARMACEUTIQUE (ANRPH)

Le suivi et l'évaluation des protocoles d'essais cliniques par l'ANRPH [27] sont réalisés conjointement entre les institutions impliquées (l'Inspection générale des services et laboratoires pharmaceutiques, la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires, le Laboratoire national de contrôle qualité du médicament et Expertise, la Direction de la Santé Familiale et la Division de la Recherche Opérationnelle en Santé), à travers le comité coordonnant ses activités.

Le tableau ci-dessous présente les différents indicateurs de performance pour le suivi et l'évaluation des projets de recherche.

Tableau 6 : Indicateurs de suivi/évaluation des protocoles d'essais cliniques de l'Autorité Nationale de Réglementation Pharmaceutique (ANRPH)

Non.	Indicateurs
1)	Proportion de protocoles d'essais cliniques mis en œuvre dans les structures du MINSANTE avec autorisation éthique
2)	Proportion d'essais cliniques mis en œuvre dans les structures du MTNSANTE avec autorisation éthique et AAR
3)	Proportion de demandes AAR avec réponse au demandeur
4)	Proportion de demandes d'AAR avec une réponse favorable au demandeur
5)	Délai moyen entre le dépôt du dossier complet de demande d'AAR et la réponse finale au demandeur
6)	Proportion de demandes d'exemption spéciale pour les importations de médicaments soumis à des essais cliniques traitées
7)	Délai moyen de traitement des dossiers de demande d'exemption pour l'importation de médicaments destinés à des essais cliniques
8)	Proportion des essais cliniques dont les médicaments ont été importés après exemption spéciale d'importation et qui ont bénéficié de la levée de lot
9)	Proportion d'essais cliniques ayant bénéficié d'une visite de suivi administratif au cours des 12 derniers mois
dix)	Proportion des essais cliniques de phase I ou II ayant bénéficié d'une visite administrative annuelle de suivi au cours des 12 derniers mois
11)	Proportion de visites de contrôle éthique réalisées
12)	Proportion des textes réglementaires et directives relatifs aux essais cliniques revisités au cours des 36 derniers mois

IV.10. PROCÉDURE DE RÉVISION/MISE À JOUR DE CE DOCUMENT

Initiateur : MINSANTE, CNERSH,

Intervenant(s) : Tous les acteurs de la recherche au Cameroun

La responsabilité de la maintenance et de la mise à jour de ce document (Organisation, fonctionnement et procédures du système d'évaluation éthique et administrative de la recherche en santé humaine au Cameroun) incombe au MINSANTE et au CNERSH. La décision de modifier les procédures existantes est prise à l'initiative de la DROS et portée à la connaissance du Ministre chargé de la Santé. Cette mise à jour doit faire l'objet d'une note du ministre de la Santé. Une numérotation appropriée des versions relatives à la mise à jour dudit Document doit permettre d'en contrôler l'exhaustivité.

La mise à jour du Document peut être motivée par :

- l'évolution du cadre juridique de la recherche pour la santé humaine
- l'évolution des meilleures pratiques nationales et internationales;
- les changements dans l'organisation ou les activités des structures techniques régulant la recherche pour la santé humaine suite aux décisions des responsables ;
- la nécessité de modifier les systèmes et les procédures pour faire face à de nouvelles situations ;
- retours des utilisateurs sur les difficultés de mise en œuvre des procédures existantes.

❖Description de la procédure

Lorsque la décision de modifier des procédures existantes ou d'insérer de nouvelles procédures est envisagée :

- le chef du pôle recherche opérationnelle en santé soumet au ministre chargé de la santé un projet de création d'un groupe de travail composé des acteurs de la régulation de la recherche en santé ;
- le groupe de travail est invité par le Ministre de la Santé aux séances de travail ;
- les objectifs de la revue sont discutés en groupe et sont approuvés ;
- des experts en la matière rédigent les procédures identifiées ;
- les procédures écrites ou révisées sont présentées au groupe pour discussion ;

- après discussion, les procédures sont adoptées ainsi que la nouvelle version du document ;
- la nouvelle version ainsi que les comptes rendus des réunions sont soumis au Ministre chargé de la Santé pour validation par décision.
- la version validée par le Ministre de la Santé est réalisée en français et en anglais et partagée par la DROS.
- décision de créer un groupe de travail relatif à la révision du document ;
- rapport d'activité du groupe de travail ;
- nouvelle version mise à jour du document ;
- décision rendant le document exécutoire.

LES RÉFÉRENCES

1. Loi n°2022/008 du 27 avril 2022 relative à la recherche médicale impliquant l'être humain au Cameroun. Edité par le Parlement. Yaoundé : Journal Officiel du Cameroun ; 2022.
2. Arrêté n°0977/MINSANTE/SESP/SG/DROS du 18 avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Comités d'éthique de la recherche en santé humaine au sein des structures relevant du Ministère de la Santé Publique du Cameroun. 2012.
3. MINSANTE : Stratégie Sectorielle Santé 2016 - 2027. Yaoundé : Ministère de la Santé ; 2016.
4. MINSANTE : Décret n°2002/209 du 19 août 2002 organisant le Ministère de la Santé Publique. Dans : 2002/209 . Edité par santé Mdl. Yaoundé : Ministère de la Santé ; 2002.

5. MINSANTE : Décret n°2013/093 du 3 avril 2013 organisant le Ministère de la Santé Publique. Edité par Santé Mdl. Yaoundé : Ministère de la Santé ; 2013. –
6. MINSANTE : Décision n°0286/D/MSP/CAB du 5 juillet 2014 portant création d'une Commission Consultative de Recherche Scientifique et Stratégique au Ministère de la Santé Publique. Yaoundé : MINSANTE ; 2014.
7. Lignes directrices éthiques internationales pour la recherche en santé impliquant des participants humains, quatrième édition. Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) 2016.
8. Emanuel EJ, Wendler D. Gradv C : Qu'est-ce qui fait l'éthique de la recherche clinique ?Jam« 2000, 283(20) :2701-2711.
9. MINSANTE : Décision n° 2096/D/MINSANTE/SG/DROS/DAJC du 21 juin 2021 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Technique du Comité d'Ethique de la Recherche en Santé Humaine. Edité par MINSANTE. Yaoundé : M3NSANTE ; 2021.
10. Décret N° 2018/9387/PM du 30 novembre 2018 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des commissions et groupes de travail. Yaoundé : Cabinet du Premier Ministre ; 2018.
11. Décision N° 1090/D/MINSANTE/SESP/SG/DROS du 13 juillet 2012 constatant la composition du Comité national d'éthique de la recherche en santé humaine. MINANT; 2012.
12. Des lignes directrices pour les Bonnes Pratiques Cliniques, thème ICH E6(R2). Conférence internationale sur l'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain (ICH) 2016.
13. Des lignes directrices pour les comités d'éthique chargés de l'évaluation de la recherche biomédicale. Genève : Organisation mondiale de la santé ; 2000.
14. Circulaire N°003/PM du 6 juillet 2015 relative au contrôle de gestion dans lesLe contexte de l'élaboration et de l'exécution du budget de l'État. Bureau du Premier Ministre, Cameroun ; 2015.
15. MINSANTE : Lettre circulaire n°6/CAB/PM du 27 mai 2010 relative à la détermination du montant des indemnités des membres des comités et secrétariats du MINSANTE ; 2010.
16. MINSANTE : Arrêté n° 1737/A/MINSANTE/SG/DROS du 28 novembre 2013 fixant le montant des frais d'évaluation des protocoles de recherche soumis aux comités d'éthique de la recherche en santé humaine pour autorisation éthique. MINANT; 2013.
17. Recherche dans les urgences sanitaires mondiales : questions éthiques ; rapport abrégé. Nouveau Conseil de bioéthique ; 2020.

18. Comité pour la recherche en santé humaine : Exigences administratives pour une demande d'autorisation éthique. Yaoundé : CNERSH ; 2013.
19. Des lignes directrices pour l'enregistrement des médicaments traditionnels dans la Région africaine de l'OMS. Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique ; 2010.
20. Déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale : principes éthiques pour la recherche médicale impliquant des sujets humains. Jama20l3, 310(20):2191-2194.
21. Maître Pierre Boubou : Code civil camerounais. Douala : Éditions Avenir ; 2006.
22. africain Forum de réglementation des vaccins (AVAREF) : Modèle d'évaluation clinique pour les applications d'essais cliniques 2019.
23. Général Lignes directrices pour les méthodologies de recherche et d'évaluation de la médecine traditionnelle Genève : Organisation mondiale de la Santé, WHO/EDM/T RM/2000.1 ; 2000.
24. Décision N° 0689/D/MINSANTE/SG/DROS du 29 juillet 2009 fixant les conditions de délivrance de l'Autorisation administrative de recherche en santé humaine au Cameroun. Yaoundé : Ministère de la Santé Publique ; 2009.
25. Lettre circulaire N°D36-13/LC/MINSANTE/SG/DROS/YC du 9 février 2011 relative à la mise en œuvre de la recherche opérationnelle en santé au Cameroun. Yaoundé : Ministère de la Santé Publique ; 2011
26. Loi N° 2000/010 du 19 décembre 2000 régissant les archives. Yaoundé : Journal Officiel du Cameroun ; 2000
27. Décision N° 0732/D/MLNSANTE/CAB Mise en place de la Plateforme de coordination des structures de l'Autorité Nationale de Réglementation Pharmaceutique. Yaoundé : Ministère de la Santé Publique ; 2017.

ANNEXES

Annexe 1 : Grille d'évaluation éthique d'un projet de recherche.

Titre du projet de recherche

……
……

……
……
……
…… ……

Établissement :
……
… ……

Nom de l'enquête principale
:…….

Nom du parrain :
……
……

Type de projet : Étudiant national international

Qualité du Document :
……

Date d'évaluation : ……/……../…….

Type d'évaluation : Normale Accélérée Suivi des modifications du projet

CRITÈRE D'ÉVALUATION				
1. VALEUR SOCIALE	Oui	Non	N / A	Commentaires/Suggestions
Le thème pertinent aux objectifs de recherche en santé des populations?				
Le projet est-il conforme aux besoins prioritaires en matière de santé nationale et/ou mondiale ?				
Le projet a-t-il un bénéfice direct et indirect pour les populations ?				
Le plan de diffusion des résultats implique-t-il les participants, la communauté, les autorités sanitaires locales et nationales, les partenaires travaillant dans le domaine de				

la santé concerné et la communauté scientifique ?				
2. VALIDITÉ SCIENTIFIQUE				
OBJECTIFS DE COHÉRENCEHYPOTHÈSES - QUESTIONSPLAN DE RECHERCHE-ANALYSE				
La question de recherche découle-t-elle de sa justification ?				
Les hypothèses permettent-elles de répondre aux questions de recherche ?				
Les objectifs permettent-ils de répondre aux questions de recherche ?				
Le plan d'étude proposé et la méthode de sélection des participants sont-ils adaptés pour atteindre les objectifs fixés ?				
Le processus d'étude découle-t-il des objectifs et des hypothèses ? Le processus reflète-t-il les caractéristiques des matières étudiées ?				
Le plan d'analyse estime-t-il correctement les indicateurs des objectifs spécifiques fixés ?				
Les outils de collecte répondent-ils aux objectifs ? Chaque objectif possède-t-il les variables attendues dans l'outil de collecte ?				
2.2. SÉLECTION DES PARTICIPANTS				
La méthode de sélection des participants est-elle adaptée				

pour atteindre les objectifs fixés ?				
La sélection des participants, l'estimation de la taille de l'échantillon et les méthodes de mesure proposées contribuent à minimiser les biais de sélection. informations, fluctuations d'échantillonnage et facteurs de confusion ?				
La procédure d'étude prévoit-elle une sélection équitable des participants ?				
Les personnes éligibles ou incluses correspondent-elles aux bénéficiaires directs de la recherche ?				
Les personnes les plus exposées au risque sont-elles exclues ?				
La sélection des participants est-elle effectuée de manière à ne pas influencer le résultat ?				
2.3. CAS PARTICULIER D'UN ESSAI CLINIQUE				
Quelle est la phase du procès ? Précisez PHASE 1;2;3 ou 4				
Les résultats des phases précédentes sont-ils décrits ?				
La méthode de randomisation proposée permet-elle une répartition équilibrée des participants à l'étude ?				
L'intervention, le contrôle et les mesures des variables d'intérêt sont-ils clairs et précis ?				
Le produit a-t-il été clairement décrit ? Le choix des variables d'intérêt est-il justifié ?				

Si la recherche nécessite des examens paracliniques, une procédure de contrôle qualité est-elle prévue et décrite ?				
2.5 FIABILITÉ ET VALIDITÉ DE L'INSTRUMENT				
Le cas échéant : l'instrument à tester est-il annexé ou les éléments à collecter sont-ils au minimum décrits ?				
Les tests préalables des instruments sont-ils décrits ? L'instrument est-il disponible ?				
L'instrument est-il pertinent par rapport aux objectifs de l'étude ?				
2.5. PERSPECTIVE DE RECHERCHE – TYPE DE RECHERCHECLINIQUE				
Dans quelle perspective se situe la recherche ? De quel type de recherche s'agit-il ? (Cochez la(les) case(s) correspondante(s) Recherche observationnelle (descriptive. analytique ? Recherche interventionnelle Essai thérapeutique, essai vaccinal, évaluation de matériel biomédical Recherche ? Etude nationale, régionale ou institutionnelle ? Recherche multi-pays ?				
3. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES				
Un chapitre intitulé « considération éthique » est-il inclus dans le protocole ?				
Si oui, ce chapitre comprend-il les éléments suivants : la justification éthique du protocole, l'identification des enjeux ou risques éthiques, les mesures prises pour minimiser les risques, les textes d'exigences				

réglementaires applicables, les conclusions des évaluations éthiques antérieures, le plan de diffusion les résultats et le plan améliorant l'accès des populations cibles aux conclusions de la recherche ?				
L'identification des questions éthiques est-elle appropriée ?				
ANALYSE RISQUES/BÉNÉFICES				
Quels sont les bénéfices directs et indirects de l'étude ?				
Le projet comprend-il un inventaire des bénéfices attendus en termes d'amélioration de l'efficacité et de la sécurité ?				
Le projet comprend-il un inventaire des bénéfices attendus en termes d'amélioration de l'accès aux soins ou en termes de prestation de soins ?				
Cet inventaire a-t-il été réalisé au niveau individuel (physique, physiologique, psychologique, émotionnel, dignité et droits) ?				
Cet état des lieux a-t-il été réalisé sur le plan social (perturbations des normes et organisations familiales, sociales et culturelles ?				
) ? Cet inventaire a-t-il été réalisé au niveau environnemental (pourrait avoir un impact sur les individus ou la société ?				
Les bénéfices sont-ils raisonnables par rapport aux risques (existe-t-il une alternative ou une procédure				

permettant d'améliorer le rapport risque/bénéfice ?				
5. RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ				
La confidentialité est-elle assurée ?				
Des outils de collecte de données, des procédures de collecte, d'analyse et de présentation des résultats conçues pour éviter l'identification des participants ?				
L'accès aux bases de données est-il réservé à l'équipe de recherche ?				
Le système de codage est-il approprié (dans le cas où il existe un registre de codes) ?				
6. AVIS D'INFORMATION				
Existe-t-il une brochure d'information en anglais et en français ?				
La notice d'information comprend-elle les informations suivantes ?				
Noms du titre du projet et adresse complète du chercheur principal				
procédures d'étude (mode et heure d'administration du questionnaire. prélèvement d'échantillons, échantillonnage, randomisation, analyse des données, durée de la collecte et du suivi des données, fréquence des visites) : une description des avantages et des risques de l'étude. temps impliqué: la possibilité pour le participant de refuser et de retirer son consentement à				

tout moment sans encourir de sanction : indemnisation éventuelle et justification du montant ; l'adresse des personnes à contacter en cas de soucis ou de survenance de problèmes (adresse email, adresse géographique, numéro de téléphone mobile et fixe de l'investigateur principal et du comité d'éthique compétent) Est-il prévu qu'une copie de l'avis soit remise au participant				
6.1. CONSENTEMENT/ASSENTEMENT				
L'étude prévoit-elle l'auto-collecte du consentement ou la possibilité pour un membre de l'équipe de lire et d'expliquer les documents de consentement au participant ?				
Tous les documents de consentement/assentiment sont-ils disponibles en français et en anglais ?				
Ces documents contiennent-ils les informations suivantes : le titre du projet ; la phrase d'acceptation; un espace pour le nom du participant ; la méthode de consentement (verbal ou écrit)				
espace pour la signature du participant et des éventuels témoins ; la date de signature par le participant/représentant légal ; le nom de la personne qui obtient le consentement				
la possibilité d'accepter ou de refuser le consentement pour l'utilisation de leurs données ou échantillons pour des études ultérieures.				
La langue et la langue utilisées sur les documents de				

consentement/assentiment sont-elles simples et compréhensibles pour le participant et/ou son représentant ?				
La traduction des documents de consentement dans les dialectes locaux est-elle clairement indiquée ?				
La procédure pour obtenir le consentement est-elle clairement décrite dans le protocole ?				
Cette procédure expose-t-elle le participant à : la subordination, l'induction, la pression et/ou l'exploitation ?				
L'étude prévoit-elle l'auto-collecte du consentement ou la possibilité pour un membre de l'équipe de lire et d'expliquer les documents de consentement au participant ?				
La procédure de consentement permet-elle au participant de poser des questions de clarification avant de participer ?				
Le lieu où le consentement est recueilli respecte-t-il la confidentialité et le confort du participant ?				
Si l'étude nécessite le consentement verbal du participant/représentant légal, la procédure prévoit-elle la validation du consentement, notamment par la signature du formulaire par un témoin et par la personne qui recueille le consentement ?				
? Existe-t-il une documentation du consentement/assentiment				

adaptée à chaque type de participant à l'étude et à chaque source de données ?				
Sources de données directes : adultes (21 ans et plus), enfants (enfants de 12 ans), adolescents (12 à 20 ans), personnes vulnérables, acteurs de situations d'urgence ?				
Source de données indirectes (dossiers patients, base de données, bibliothèque de sérums ou biobanque) ?				
Communauté ou groupe ?				
Le formulaire comprend : la date de signature du participant/représentant légal, le nom du participant, le nom de la personne qui recueille le consentement, la déclaration d'engagement du participant ?				
La procédure prévoit-elle la possibilité d'accepter ou de refuser le consentement pour l'utilisation de leurs données ou échantillons pour des études ultérieures ?				
Dans le cas où le participant est un mineur de moins de 12 ans. La notice d'information contenant des informations générales est-elle destinée à obtenir le consentement offert au parent ou au tuteur ?				
Un formulaire de consentement parental est-il proposé ?				
Si le participant est un mineur âgé de 12 à 20 ans : un formulaire d'accord est-il proposé à l'enfant ?				

Un formulaire de consentement parental est-il proposé ?				
Dans le cas du consentement d'un mineur émancipé (Particulier <21 ans, mineur marié, et par décision légalement valable des parents dès l'âge de quinze ans) : l'étude prévoit-elle d'appliquer la même procédure de consentement que chez l'adulte ?				
En cas de consentement de groupes/personnes vulnérables (toute personne présentant une situation sanitaire, physique, sociale et/ou économique ne lui permettant pas d'assumer son autonomie et/ou de donner librement son consentement : enfants, femmes enceintes, nouveau-nés , fœtus, jeunes sans abri, personnes atteintes de troubles mentaux/psychiatriques, défavorisés économiquement ou éducativement, marginalisés, personnes en phase terminale, détenus, etc.), à l'exception des notices d'information contenant des informations générales, l'étude fournit-elle un formulaire de consentement permettant la tuteur pour autoriser la personne à participer à l'étude ?				
L'étude donne-t-elle la possibilité aux participants vulnérables ayant retrouvé leur autonomie de donner leur consentement ?				

En cas de consentement des personnes en situation d'urgence médicale (urgences prévisibles - les personnes en situation d'urgence imprévisible sont classées parmi les groupes vulnérables), le recueil du consentement est-il prévu avant que l'urgence ne survienne ?				
CAS D'EXEMPTION/RENONCIATION AU CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ. La source de données est-elle indirecte dans les situations suivantes :				
Impossibilité d'accéder au(x) participant(s) ; risque mineur de violation de l'autonomie et de la confidentialité ; études observationnelles et écologiques qualitatives où la cible est un groupe et non un individu.				
L'utilisation de registres/bases de données sanitaires est-elle autorisée par les institutions qui les hébergent ?				
La procédure de confidentialité utilisée protège-t-elle l'accès ou l'utilisation des informations personnelles dans les registres/bases de données ?				
La renonciation au consentement éclairé affecte-t-elle les droits et le bien-être des participants à la recherche ?				
L'étude implique-t-elle des échantillons biologiques et/ou des données personnelles obtenus avec le consentement				

des participants pour une utilisation ultérieure ?				
PARTENARIAT COLLABORATIF POUR AMÉLIORER L'ACCÈS AUX RÉSULTATS DE LA RECHERCHE				
7.1. ACCORD DE PARTAGE DE DONNÉES (DSA)				
Les données proviennent et/ou sont utilisées par plusieurs institutions ?				
Existe-t-il un accord de partage de données signé par toutes les parties prenantes ?				
L'étude prévoit-elle que la base de données collectée soit hébergée au Cameroun ?				
Existe-t-il des procédures de sécurisation des données collectées ?				
Ordre des auteurs dans les publications				
est-ce spécifié dans le DSA ?				
Cet ordre des auteurs dans les publications est-il juste ?				
L'accès à la base de données collectée est-il équitable (accès des enquêteurs locaux à la base de données de tous les sites d'une étude multi-pays ou multicentrique) ?				
7.2 ACCORD DE TRANSFERT DE MATÉRIEL (MTA OU ACCORD DE TRANSFERT DE MATÉRIEL)				
Existe-t-il un MTA comprenant au moins les informations suivantes ?				
La nature, la quantité et la fréquence du transfert des échantillons ?				
La description des échantillons en termes d'origine, de volume, de méthode et de durée de stockage et de transport ?				
Les noms et adresses de l'expéditeur et de son institution ?				

Le mode de destruction ?				
Les conditions de transformation des produits dérivés ?				
Les conditions de partage avec d'autres laboratoires ?				
Equité dans le partage des bénéfices générés par les produits issus du matériel biologique transféré (propriété intellectuelle, brevet d'exploitation et commercialisation) ?				
Des références à la loi applicable à la sécurité des échantillons et à la personne responsable ?				
Le document d'accord MTA est-il signé par les responsables suivants : l'expéditeur, le destinataire et l'agent de sécurité de l'échantillon ?				
7.1. GARANTIE DE PARTAGE DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE (études multi-pays et multi-institutions) Existe-t-il un plan de collaboration entre les acteurs (gouvernement, autorités sanitaires sponsors et communauté) garantissant l'accès de la population aux résultats de la recherche sur les plans financier, technologique (plateforme technique) et formation des niveaux de ressources humaines ?				
Existe-t-il un plan pour renforcer les capacités des co-enquêteurs camerounais ?				

Existe-t-il un plan de transfert de technologies et de compétences ?				
CONSIDÉRATIONS				
8.1 COMPÉTENCES DU (DES) CHERCHEUR(S) ET IMPLICATION DANS LA RECHERCHE				
8.1. Le chercheur principal possède-t-il les compétences et l'expérience requises pour mener la recherche ?				
Présente-t-il un profil répondant aux exigences de la recherche ?				
Sa responsabilité est-elle assumée dans le cadre de l'étude ?				
Y a-t-il une présentation de l'équipe de recherche ?				
Les CV des membres de l'équipe sont-ils inclus dans le projet ?				
L'équipe de recherche est-elle compétente pour atteindre les objectifs de recherche ?				
8.3. CHRONOGRAMME DES ACTIVITÉS				
Un calendrier des activités est-il joint au protocole ?				
La planification de la collecte et de l'analyse des données est-elle décrite et cohérente ?				
La durée de la recherche permet-elle d'obtenir les résultats attendus afin de résoudre la problématique de l'étude ?				
8.4 8.4. BUDGET				
Y a-t-il un budget attaché au projet ?				
Ce budget est-il détaillé ?				

Ce budget est-il cohérent avec la durée de l'étude ?				
Ce budget est-il suffisant pour réaliser les travaux ?				
Ce budget prévoit-il la restitution des résultats de l'étude ?				
8.5. ACCORD DE PRINCIPE DES SITES DE RECHERCHE				
Existe-t-il un accord de principe entre sites de recherche portant la signature de leur responsable ?				
9. DISPOSITIONS FINALES				
9.1. DOMAINE DE COMPÉTENCE DE L'ÉVALUATEUR (préciser)				
9.2 Conclusion				
9.3. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES				

Annexe 2 : Grille de suivi éthique d'un projet de recherche				
Section 1 : Général				
Date de la visite sur le terrain				
Noms des individus rencontrés				
Noms des superviseurs				
Titre de l'étude				
Type d'étude				
Promoteur				
Chercheur principal Co-chercheurs				
Durée prévue de l'étude				
Source de financement de l'étude				
Le recrutement des participants a-t-il commencé ? Si non, donnez des détails.				
Combien de participants ont été recrutés à ce jour ?				
Le recrutement des participants se poursuit-il ?				
Combien de participants reste-t-il à recruter ?				
Y a-t-il des abandons de l'étude ? Si oui, donnez des détails.				
Les participants recrutés reçoivent-ils toujours des visites/soins ? Si oui. donne des détails.				
(besoin de l'étude, bénéfices attendus, risques encourus) : et dans un langage clair, compréhensible et adapté au niveau de compréhension de la population ciblée par la recherche ?				
3.6. La personne concernée est-elle informée de ce qu'il adviendra des données collectées, de qui y aura accès et du moment où elles seront détruites ?				

3.7. Le sujet a-t-il la possibilité de poser des questions pour mieux clarifier ses interrogations ?				
3.8. Le sujet a-t-il le temps de réfléchir à son acceptation (lui laisse-t-il un délai entre la transmission de l'information et la signature du formulaire de consentement) ?				
3.9. L'information est-elle transmise au participant par un membre de l'équipe de recherche ?				
3.10. L'information est-elle transmise au participant par une personne indépendante de l'équipe de recherche ?				
3.11. Les individus décident-ils eux-mêmes de participer à l'étude indépendamment de toute considération des coûts et des avantages ?				
3.12. Les sujets sont-ils soumis à des menaces/pressions/manipulations pour obtenir leur acceptation ?				
3.13. Les sujets reçoivent-ils une récompense/une promesse injustifiée et inappropriée pour leur participation ?				
3.14. Dans le cas d'une recherche impliquant plus d'une phase de collecte de données, le consentement des participants est-il renouvelé tout au long de la participation à l'étude ?				
3.15. Les sujets sont-ils informés du caractère volontaire de leur participation ?				
3.16. Les participants sont-ils libres de reconsidérer leur décision à tout moment ?				

3.17. Pour les recherches impliquant des personnes incapables de donner leur consentement volontaire, les conditions suivantes sont-elles respectées :				
- consentement/autorisation du représentant légal ?				
- consentement pour les enfants ou les personnes fragiles et vulnérables ?				
3.18. tous les sujets participant à l'étude ont signé des formulaires de consentement éclairé ?				
Section 4:Analyse des risques et des avantages	Oui	Non	N / A	Observation
4.1. Les sujets sont-ils informés de tous les risques anticipés, ainsi que des mesures qui seront prises pour les réduire ?				
4.2. Les sujets sont-ils informés des avantages ou bénéfices attendus de l'étude ?				
4.3. La sécurité et le bien-être des participants sont-ils assurés ?				
4.4. L'utilisation/la collecte de matériel biologique est-elle justifiée ?				
4.5. Les connaissances scientifiques				
4.6. Y a-t-il eu des problèmes imprévus liés à l'étude ?				
4.7. Les sujets reçoivent-ils une compensation, d'une nature et d'une valeur justifiées, en raison de leur participation à la recherche ?	*			
4.8. La vie privée des participants est-elle respectée ?				
Section 5 : Sélection des sujets	**Oui**	**Non**	**N / A**	**Observations**

5.1. Le choix du site de recherche est-il justifié ?				
5.2. La recherche implique-t-elle des mineurs ?				
5.3. La recherche implique-t-elle des sujets/groupes vulnérables (toute personne ayant une situation sanitaire, physique, sociale et/ou économique ne lui permettant pas d'assumer son autonomie et/ou de donner librement son consentement : enfants, femmes enceintes, nouveau-nés, fœtus, sans-abri) jeunes, personnes souffrant de troubles mentaux/psychiatriques, défavorisés sur le plan économique ou éducatif, marginalisés, personnes en				
5.4. Les personnes ou les groupes recrutés sont-ils susceptibles de bénéficier de la recherche ?				
5.5. Les personnes en situation vulnérable bénéficient-elles d'un traitement équitable ?				
5.6. Les critères d'inclusion sont-ils justifiés par la question de recherche ?				
6.2. Les formulaires de consentement, les données physiques, les données numériques, les bases de données, les biobanques sont-ils conservés de manière à				
6.3. L'accès aux données est-il réservé aux personnes dûment autorisées ?				
Section 7 : Adhésion au protocole de recherche	**Oui**	**Non**	**N / A**	**Observations**
7.1. Le promoteur de l'étude a-t-il commandé des audits				

internes/externes du projet de recherche ?				
7.2. Un gestionnaire désigné ou un comité de suivi possédant l'expertise pertinente a-t-il été nommé pour superviser l'étude ?				
7.3 Existe-t-il un système de gestion des données pour l'étude ?				
Une base de données est-elle disponible ?				
Existe-t-il des procédures pour l'intégrité des données ?				
7.5 Existe-t-il un système d'archivage de tous les documents et activités essentiels réalisés dans le cadre de l'étude ? Si oui, lesquels ? -Rapports de suivi- Rapports de réunions- Rapports d'avancement- Rapports d'assurance qualité				
7.6 Existe-t-il un système de déclaration des événements indésirables au comité d'éthique et à l'autorité de réglementation ? Si oui, les formulaires de notification des événements indésirables sont-ils disponibles ?				
7.7 Y a-t-il eu des événements indésirables liés à l'étude ? Si Quel est le nombre d'événements indésirables notifiés au comité d'éthique et à l'autorité de régulation ? Des rapports sur les événements indésirables graves sont-ils disponibles ? Y a-t-il une cohérence entre les données enregistrées dans les formulaires de déclaration de cas et celles contenues dans				

les formulaires de notification ? Les réponses du comité d'éthique et de l'autorité de régulation sont-elles disponibles ?				
7.8. Les prélèvements d'échantillons, les études d'imagerie médicale ou d'autres tests sont-ils effectués comme décrit dans le protocole de recherche approuvé ?				
7.9. Y a-t-il eu des changements dans le protocole approuvé par le comité d'éthique et les autorités réglementaires ? Une preuve écrite de l'acceptation des modifications du protocole par le comité d'éthique est-elle disponible ? Les modifications du protocole approuvées par le comité d'éthique ont-elles été notifiées aux autorités réglementaires ?				
Section 8 : Site d'étude				
8.1. Le site dispose-t-il des équipements et infrastructures nécessaires à cette étude ?				
-Y a-t-il un espace dédié aux examens physiques et aux prélèvements biologiques ?				
-Les équipements et instruments nécessaires sont-ils disponibles et appropriés ?				
-Des lits d'hôpitaux sont-ils disponibles ?				
- Existe-t-il une zone d'urgence bien équipée avec des médicaments à administrer en cas d'urgence ?				
- Les médicaments à administrer en cas d'urgence				

sont-ils conservés en fonction de leur durée de conservation ?				
8.2. Les laboratoires sont-ils suffisamment équipés pour effectuer les tests requis ?				
- - Les espaces destinés à la réception, à la préparation et au stockage jusqu'au moment de l'analyse des échantillons sont-ils appropriés ?				
- - L'état de qualification et d'étalonnage des équipements et instruments de laboratoire est-il valide pour une utilisation pour l'analyse d'échantillons ?				
- Des contrats de sous-traitance ont-ils été signés ?				
- Les procédures de stockage et de manipulation des échantillons sont-elles respectées ?				
- Les échantillons des participants sont-ils traçables ?				
8.3. Le site répond-il aux normes d'hygiène et de biosécurité ?				
- Disponibilité de toilettes et d'installations de lavage ;				
Présence d'un système d'élimination des déchets ;				
Section 9 : Personnel de recherche	Oui	Non		N / A
9.1. Le personnel de recherche a-t-il reçu une formation avant le début de l'étude ?				
9.2. Toutes les responsabilités du personnel (promoteur, enquêteurs, autres membres du personnel) et l'organigramme ont-ils été décrits ?				
Le cas échéant, existe-t-il des preuves de la délégation de				

tâches au personnel en fonction de ses qualifications et de son expérience ?				
9.3. Le profil du personnel répond-il aux exigences ?				
- Les documents relatifs aux qualifications du personnel, y compris le personnel contractuel, sont-ils disponibles ?				
- L'expérience et la formation du personnel sont-elles appropriées ?				
Y a-t-il suffisamment de personnel pour mener l'étude ?				

Date de la descente sur le terrain					
Noms des personnes rencontrées					
Nom et adresse du site					
Noms des superviseurs					
Article		Non	Indicateur	Réponse	Observation
1	Disponibilité de ressources pour la protection des participants à la recherche lors de la mise en œuvre des projets de recherche menés dans	1.1	Proportion de chercheurs titulaires d'au moins un diplôme (PhD) couvrant leur domaine de recherche.		

	l'organisation .				
		1.2	Proportion de chercheurs ayant reçu au moins 40 heures de formation en éthique de la recherche pour la santé.		
		1.3	Proportion de chercheurs ayant reçu une formation couvrant les aspects éthiques spécifiques de leur domaine de recherche.		
		1.4	Proportion de chercheurs disposant de documents réglementaires sur la protection des participants à la recherche.		
		1,5	Proportion des projets de recherche menés par l'organisme qui intègrent des outils assurant la protection des participants.		
2	Évaluation éthique et administrative des projets de recherche mis en œuvre dans	2.1	Proportion de projets de recherche mis en œuvre ayant obtenu une autorisation éthique délivrée par un comité d'éthique compétent		

	l'institution de recherche				
		2.2	Proportion de projets de recherche ayant bénéficié d'une Autorisation administrative de recherche (AAR) délivrée par le Ministère de la Santé		
		2.3	Proportion de projets de recherche avec échange de matériel biologique entre établissements et avec accord de transfert de matériel		
		2.4	Proportion de projets de recherche avec échange de données entre établissements et avec accord de partage de données		
		2.5	Proportion d'essais cliniques enregistrés dans une base de données publique locale et/ou internationale (Registre panafricain des essais cliniques au minimum)		
		2.6	Proportion de projets de recherche terminés qui ont soumis un rapport final au comité d'éthique concerné		

3	Diffusion des résultats	3.1	Proportion de projets de recherche terminés dont les résultats ont été diffusés aux communautés cibles de la recherche		
		3.2	Proportion de projets de recherche achevés dont les résultats ont été diffusés aux décideurs/autorités sanitaires		
		3.3	Proportions de projets de recherche terminés, dont les résultats ont été présentés lors de conférences scientifiques nationales		
		3.4	Les proportions de projets de recherche terminés, y compris les résultats, sont accessibles dans au moins un journal scientifique/bibliothè que en accès gratuit.		

Annexe 4 : Lignes directrices pour le suivi du comité d'éthique par DROS

Non	Article	Non	Indicateur	Réponse	Observation

1	Accès à l'évaluation éthique	1.1	Proportion de régions couvertes par un comité d'éthique pour la recherche en santé humaine (CERSH)		
		1.2	Proportion de régions couvertes par un CERSH		
		1.3	Proportion de CERSH mis en place conformément à la réglementation		
		1.4	Proportion de CERSH disposant d'un espace de bureau pour la réception et l'évaluation des protocoles1.6 Proportion de CERSH disposant d'un calendrier de réunions publiques		
		1,5	Proportion de CERSH disposant d'un calendrier de réunions publiques		
		1.6	Proportion du CERSH ayant respecté le calendrier des réunions publiques au cours des 12 derniers mois		
		1.7	Proportion de CERSH avec procédures opératoires standardisées et évaluation des protocoles		
		1.8	Proportions d'hôpitaux de		

			première et deuxième catégories disposant d'un CERSH		
		1.9	Proportion de CERSH ayant une structure adaptée à celle recommandée par la réglementation		
		1.10	Proportion de CERSH ayant une composition proche de celle recommandée par la réglementation		
		1.11	Proportion de CERSH constitués qui sont fonctionnels		
2	Sélection et formation des membres		2.1. Proportion de membres sélectionnés selon les lignes directrices		
		2.2	Proportion de membres formés à l'évaluation éthique		
		2.3	Proportion de membres cumulant 40 heures de formation et d'éthique de la recherche au cours des 36 derniers mois		
		2.4	Proportion de membres formés aux bonnes pratiques cliniques au cours des 36 derniers mois		

		2.5	Proportion de membres formés à l'évaluation des essais cliniques de médicaments au cours des 36 derniers mois		
		2.6	Proportion de membres formés à l'évaluation des essais cliniques de vaccins au cours des 36 derniers mois		
		2.7	Proportion de membres formés à l'évaluation des essais cliniques de médecines traditionnelles au cours des 36 derniers mois		
3	Planification et tenue de réunions		3.1. Proportion de CERSH avec un calendrier annuel		
		3.2	Proportion de CERSH ayant un calendrier annuel rendu public		
		3.3	Proportion du CERSH organisant au moins 80 % des réunions prévues à ce jour		
		3.5	Proportion du CERSH détenant au moins 80 % des réunions avec au moins 80 % de ses membres		

		3.6	Proportion de réunions du CERSH détenant au moins 80 % des réunions correctement convoquées		
		3.7	Proportion de CERSH dotés de procédures opérationnelles standardisées pour l’évaluation éthique		
		3.8	Proportion du CERSH utilisant le guide d'évaluation éthique et administrative des protocoles de recherche en santé humaine du ministère de la Santé pour l'évaluation éthique		
		3.9	Proportion de réunions d'évaluation avec déclaration préalable de conflit d'intérêts Proportion de réunions d'évaluation		
		3.10	avec déclaration préalable de confidentialité		
		3.11	Nombre de protocoles de recherche reçus au cours des 12 derniers mois		
		3.12	Nombre de protocoles de recherche éligibles à un examen éthique		

			au cours des 12 derniers mois		
		3.12	Proportion de protocoles de recherche transmis pour évaluation selon la procédure prévue par les directives en vigueur		
		3.13	Proportion de protocoles évalués dans les délais fixés par les directives en vigueur et bénéficiant d'une autorisation éthique		
		3.14	Proportion de protocoles évalués dans les délais fixés par les directives		
		3.16	Proportion de réunions d'évaluation éthique avec rapport		
		3.17	Proportion de réunions d'évaluation éthique archivées en soft et hard		
		3.18	Proportion de réunions d'évaluation éthique avec rapport partagé avec les parties prenantes prévues dans les directives applicables		

		3.19	Proportion d'évaluation répondant à l'éthique avec rapport indiquant le mode de prise de décision pour chaque protocole évalué.		
4	Financement des comités d'éthique	4.1	Montant total du financement reçu au cours des 12 derniers mois		
		4.2	Proportion de lignes de financement correspondant à celles prévues par la réglementation		
		4.3	Pourcentage du montant du financement reçu correspondant aux montants prévus par règlement		
		4.4	Proportion des versements effectués aux membres du CERSH selon la réglementation en vigueur		
5	Archivage	5.1	Proportion de CERSH recevant des dossiers de demande d'autorisation éthique par voie électronique		
		5.2	Proportion de CERSH recevant des dossiers de demande d'autorisation		

			éthique par voie électronique		
		5.3	Proportion de CERSH procédant à un archivage électronique des dossiers de demande d'habilitation éthique		
		5.4	Proportion de CERSH disposant d'une base de données électronique des dossiers de demandes d'autorisation éthique reçus		
6	Communication		6.1. Proportion de CERSH joignable par contact téléphonique dédié		
		6.2	Proportion de CERSH joignable par contact email dédié		
		6.3	Proportion du CERSH accessible par boîte postale dédiée		
		6.4	Proportion de CERSH possédant un site Internet		
		6.5	Proportion de CERSH disposant d'une page Web d'information publique		

		6.6	Proportion de CERSH disposant d'une interface de dépôt en ligne des dossiers de demande d'habilitation éthique		

Annexe 5 : Grille de revue du fonctionnement des Comités d'Ethique de la Recherche en Santé Humaine au Cameroun (CERSH)

Date de la visite sur le terrain				
Nom et adresse du comité d'éthique				
Noms des personnes				
Noms des superviseurs				
Non.	Variable	**Modalité**	**Réponse**	**commentaires**
1	Cible de l'évaluation	Catégorie FOSA 1= a Catégorie FOSA 2= b Catégorie FOSA 3= c Institut de formation= d Structure de recherche— e		

2	Type de comité	National = a Régional = b Institutionnel = c		
3	Date de création du comité	Date : JJ/MM/AA AA		
4	Pouvez-vous nous remettre une copie du procès-verbal/document officiel constitutif	Oui=l, non = 2,		
5	Date du dernier renouvellement du		Date : JJ/MM/AAAA	
6	Pouvez-vous nous remettre une copie du rapport de renouvellement ?	Oui = 1. non = 2,		
7	Pouvez-vous nous remettre une copie de la décision	Oui=l, non = 2,		
8,	Pouvoir de signature de la décision de conclusion	Ministre de la Santé		
		Président du conseil d'administration = 4 Autre = 5		
9	Nombre total de membres du comité	Nombre		
dix	Nombre total de membres du comité assistant actuellement aux réunions	Nombre		
11	Nombre de femmes au comité	Nombre		

12	Nombre de médecins dans le comité	Nombre		
13	Nombre de statisticiens au sein du comité	Nombre		
14	Nombre de membres représentatifs de	Nombre		
15	Nombre de membres ne travaillant pas* dans la structure qui héberge le comité	Nombre		
16	Nombre de membres du comité ayant reçu au moins une formation en évaluation éthique	Nombre		
17	Nombre de membres du comité ayant reçu au moins 40 heures de formation en évaluation éthique	Nombre		
18	Pouvez-vous nous donner une copie du calendrier des réunions du comité de l'année dernière?	Oui= 1, non - 2,		
19	Ce calendrier est-il rendu public ?	Oui=l, non = 2,		

20	Si le calendrier est public, de quelle source	Affiche = un		
	pouvons-nous le vérifier ?	Site Web = b Forum		
21	Combien de réunions étaient prévues	Nombre		
	au cours des 12 derniers mois ?			
22	Combien de réunions ont eu lieu au cours des 12 derniers mois ?	Nombre		
23	Nombre de réunions tenues par le comité au cours des 12 derniers mois avec procès-verbal	Nombre		
24	Le comité dispose-t-il d'une adresse physique pour soumettre des demandes d'examen éthique ?	Oui=L non = 2,		
25	Le comité dispose-t-il d'une ligne téléphonique	Oui=l, non = 2,		
26	Le comité a-t-il une adresse e-mail ?	Oui=l, non = 2,		
27	Le comité a-t-il un site Internet ?	Oui—], non = 2.		

28	Le comité a-t-il une boîte postale ?	Oui=l, non=2.		
29	Le comité dispose-t-il d'un compte bancaire pour déposer les frais d'évaluation du protocole ?	Oui=l, non = 2,		
30	Le comité dispose-t-il d'une salle de réunion pour l'évaluation du protocole ?	Oui=L non = 2,		
31	Le comité a-t-il un secrétariat ?	Oui=l, non = 2,		
32	Le comité dispose-t-il d'un ordinateur ?	Oui^l, non = 2,		
33	Le comité a-t-il une imprimante ?	Ou NI, non - 2,		
34	Le comité dispose-t-il d'un système d'archivage des documents ?	Oui=l, non=2.		
35	Le comité dispose-t-il de procédures opérationnelles standard pour	Oui = 1, non = 2,		
	fonctionnement et évaluation éthique ?	•		

36	Le comité a-t-il la liste des pièces ? requis pour l'évaluation éthique	Oui=l, non = 2,		
37	Nombre de demandes d'examen éthique reçues au cours des 12 dernières	Nombre		
38.	Nombre de demandes d'examen éthique reçues au cours des 12 derniers mois jugées recevables			
39.	Nombre de demandes d'examen éthique reçues au cours des 12 derniers mois jugées recevables et examinées			
40.	Nombre de demandes d'examen éthique reçues au cours des 12 derniers mois jugées recevables, examinées avec autorisation éthique délivrée			
41.	Nombre de demandes d'examen éthique reçues au cours des 12 derniers mois jugées recevables,			

	examinées et rejetées			
42.	Durée moyenne d'évaluation d'un protocole			
43.	43. Nombre de projets de recherche pour les essais cliniques de phase 1 examinés au cours des 12 derniers mois			
44.	Nombre de projets de recherche pour les essais cliniques de phase 2 examinés au cours des 12 derniers mois			
45.	Nombre de projets de recherche pour des essais cliniques de phase 3 examinés au cours des 12 derniers mois			
46.	Nombre de visites sur site, pour évaluation avant approbation d'un essai clinique de phase 1, réalisées			

47.	Nombre d'essais cliniques de phase 1 suivis après approbation au cours des 12 derniers mois*			
48.	Nombre de projets de recherche suivis après approbation au cours des 12 derniers mois			
49.	Nombre de rapports annuels sur le fonctionnement du comité disponibles			

Annexe 6 : Formulaire de déclaration de conflit d'intérêts par les représentants des établissements de recherche

A. CONFLIT D'INTÉRÊTS

1. L'équipe de recherche est une entité de collaboration entre des membres de diverses disciplines et institutions qui sont tenus de déclarer tout conflit d'intérêts.
2. Un conflit d'intérêts survient lorsqu'un membre a un intérêt qui pourrait fausser son opinion, mettre en danger le participant à l'étude et nuire à la réputation de l'équipe de recherche. Les conflits d'intérêts peuvent inclure des intérêts personnels, professionnels, financiers ou autres.
3. Il est de la responsabilité de chaque membre de l'équipe de recherche de déclarer toute situation de conflit d'intérêts pouvant survenir, réel ou apparent. Les conflits potentiels qui se développent pendant la durée de l'étude doivent également être divulgués. Il convient toutefois d'éviter autant que possible l'apparence d'un conflit d'intérêts.

Les éléments suivants doivent être pris en compte lors de l'évaluation de l'existence ou non d'un conflit d'intérêts :

• Emploi : emploi actuel ou emploi datant des 12 derniers mois (employé, consultant ou autre bénéficiaire d'honoraires, membre du conseil d'administration ou du comité consultatif) au sein d'une institution ou d'un

organisme directement impacté par les résultats de la recherche ou qui pourrait en bénéficier financièrement.

• Avantage financier : personne qui a reçu ou pourrait recevoir un avantage financier direct d'un montant autre que sa rémunération, de la part d'une personne, d'une institution ou d'un organisme impliqué dans des activités.

similaires à ceux pour lesquels il est sollicité dans le cadre des recherches envisagées se trouve en situation de conflit d'intérêts.

• Propriété intellectuelle : La propriété intellectuelle, telle que les droits d'auteur, les brevets liés à des activités similaires à celles de la recherche envisagée, peut être considérée comme un conflit d'intérêts.

• Parents ou associés : Un conflit d'intérêts peut exister si un proche parent ou associé professionnel d'un membre de l'équipe de recherche bénéficie ou pourrait bénéficier d'autres avantages que ceux générés par ladite recherche.

• Désaccords de longue date : Un conflit d'intérêt peut exister lorsqu'un membre de l'équipe de recherche a des différends scientifiques ou personnels de longue date avec un autre, ce qui peut compromettre la mise en œuvre de la recherche.

B. ENGAGEMENT CONCERNANT LES CONFLITS D'INTÉRÊTS

NOM: ---------- ----------

Employeur principal : ---------- ----------

J'ai lu le formulaire de conflit d'intérêts ci-joint.

Je certifie par la présente que je n'ai aucun conflit d'intérêts.

Signature: Date:

Annexe 7 : Formulaire d'engagement de confidentialité

A. CONFIDENTIALITÉ

1. Les documents et données mis à disposition par l'équipe de recherche et qui ne sont pas dans le domaine public, ainsi que les discussions résultant de l'analyse des données, sont strictement confidentiels et ne doivent pas être divulgués ou discutés avec quiconque n'est pas membre de l'équipe de recherche. l'équipe de recherche.

2. Les informations confidentielles obtenues en tant que membre de l'équipe de recherche ne peuvent être utilisées par ledit membre à son bénéfice personnel ou au bénéfice de sa famille.

B. ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ

NOM:

Employeur principal :

J'ai lu le formulaire de confidentialité ci-joint :

Je comprends parfaitement la nature du processus de confidentialité et m'engage à ne pas divulguer les documents, données et discussions confidentiels associés aux travaux de cette recherche.

Signature:

Date:

Annexe 8 : Aperçu de l'accord de transfert de matériel à des fins de recherche impliquant des êtres humains

Dans le cadre des missions de l'Institution X, établissement public scientifique et technologique, elle s'engage à concéder des droits d'utilisation non exclusifs à des fins de recherche non commerciales à des tiers appartenant à la communauté scientifique, tels que décrits ci-dessous.

Concrètement, l'Institution X donne son accord pour le transfert du matériel biologique décrit, notamment le chercheur responsable dudit matériel biologique (ci-après dénommé le « Scientifique »), au profit de l'établissement et du demandeur (ci-après collectivement dénommés les « DESTINATAIRES » et décrits ci-dessous), sous réserve de l'acceptation préalable par le destinataire des termes et conditions du présent accord (ci-après « Accord »).

Institution Employeur du candidat	Nom
	Adresse physique ----------

	Tél ;
	Fax;
	E-mail;
Demandeur du matériel original	Nom
	Fonction
	Adresse physique
	Tél ;
	Fax
	E-mail
Locaux à partir desquels les échantillons seront préparés pour l'expédition	Nom
	Adresse
	Tél
	Fax
	E-mail
Origine du matériel et quantité demandée.	Source du matériau (humain, animal, bactérie ?).
	Description de l'échantillon (tissus/cellules, volume/poids par unité).
	Quantité totale d'échantillons à expédier.

	Périodicité
Institution employant le bénéficiaire.	Nom
	Fonction
	Adresse physique ----------
	Tél :
Le chercheur bénéficiaire.	Nom
	Adresse physique
	Tél
	Fax
	E-mail
Adresse des locaux où se déroulera la recherche.	Nom
	Adresse physique
	Tél
	Fax
	E-mail: ----------
Recherche à entreprendre par le demandeur à partir du matériel original (peut être complétée par une	

annexe, qui fera partie intégrante de l'accord).	

DÉFINITIONS

Applications commerciales : vente, location, licence ou autre transfert du matériel ou des modifications à une organisation à but lucratif. Les Applications Commerciales incluent également l'utilisation du Matériel ou des Modifications par toute organisation, y compris le BÉNÉFICIAIRE, pour l'exécution de contrats de recherche, l'interrogation de bibliothèques de composés, la production ou la fabrication de produits commerciaux ou la conduite d'activités de recherche entraînant des ventes, des locations. , licences ou transferts du matériel ou des modifications à une organisation à but lucratif.

(ii) Descendant : descendants non modifiés du Matériel, tels qu'un virus à partir d'un virus, une cellule à partir d'une cellule ou un organisme à partir d'un organisme.

(iii) Dérivés non modifiés : substances créées par le BÉNÉFICIAIRE qui constituent une sous-unité fonctionnelle non modifiée, ou un produit exprimé par le Matériau original. Quelques exemples : sous-clones de lignées

cellulaires non modifiées, sous-produits exprimés par ADN/ARN, ou anticorps monoclonaux sécrétés par des hybridomes de lignées cellulaires.

(iv) Matériel : matériel original, descendants non modifiés et matériaux dérivés. Le Matériel ne comprend pas : a) les Modifications, b) les autres substances créées par le BÉNÉFICIAIRE à l'aide du Matériel et qui ne sont ni des Modifications, ni des Descendants, ni des Dérivés non modifiés.

(v) Matériel original : le matériel de recherche transféré par le fournisseur accompagné des informations connexes.

(vi) Modifications : Substances créées par le BÉNÉFICIAIRE qui contiennent/incorporent le Matériel.

CONDITIONS D'ACCORD

1) SUJET

1.1. Le BÉNÉFICIAIRE reconnaît que le présent Accord vise à encourager la coopération scientifique visant le développement d'applications du Matériel Original ainsi que l'échange de données techniques.

1.2. L'Institut Fournisseur s'engage à fournir au BÉNÉFICIAIRE le Matériel Original dans les conditions prévues au présent Contrat.

2) FOURNITURE DU MATÉRIEL ORIGINAL

2.1. Le scientifique enverra le matériel original à l'adresse à l'attention du demandeur.

2.2. Le fournisseur et le Scientifique ne pourront être tenus responsables d'éventuels dommages liés au transport. Dans le cas où le Matériel Original n'arrive pas ou arrive à l'Adresse dans des conditions telles qu'il est inutilisable, le Scientifique renverra le Matériel Original à l'Adresse à l'attention du Demandeur.

2.3. Les frais d'expédition du Matériel Original seront inclus, le cas échéant, dans les conditions financières prévues au présent Contrat.

3) CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Si le matériel collecté fait partie de tissus biologiques humains ou est identifiable, les participants à la recherche doivent être informés de la finalité, de la justification du transfert, des objectifs de la recherche qui sera menée, des modalités précises, des risques, des quantités, de la durée et de l'adresse. . les lieux de conservation et de transfert et les personnes qui en sont responsables. Ils doivent en même temps être informés de leur liberté de refuser le prélèvement et de la possibilité pour eux de décider de retirer leur échantillon à tout moment et sans risque. Ils doivent également être informés des modifications apportées aux objectifs du protocole de recherche et des modifications pouvant entraîner des risques supplémentaires avant sa mise en œuvre.

4) APPROBATION DU COMITÉ D'ÉTHIQUE ET DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Si la recherche implique la collecte et le transfert de matériel biologique humain d'un établissement à un autre, cela doit être précisé dans le protocole de recherche et soumis pour évaluation au comité d'éthique et à la Division de recherche opérationnelle en santé. (DROS) en même temps que le « Material Sharing Agreement (MTA) »

Toutes modifications ultérieures du protocole et/ou du MTA doivent être préalablement approuvées par le comité d'éthique et le DROS.

5) UTILISATION

5.1. Le BÉNÉFICIAIRE s’engage à ce que le Matériel :

(a) est utilisé uniquement aux fins de la recherche décrite dans le présent accord ;

(b) n’est pas distribué ou transmis à un tiers à quelque fin que ce soit ;

(c) né. n'est pas utilisé pour d'autres recherches sans l'avis du FOURNISSEUR ;

(d) est utilisé conformément à la réglementation internationale et camerounaise relative au transfert de matériel biologique

(e) est utilisé exclusivement chez le BÉNÉFICIAIRE et par les scientifiques travaillant dans le laboratoire du BÉNÉFICIAIRE ou sous sa responsabilité directe ;

(f) est accessible au FOURNISSEUR même si le chercheur actuellement responsable de l'institut BÉNÉFICIAIRE n'est plus sous contrat avec son employeur.

5.2. Le BÉNÉFICIAIRE a le droit, sans aucune restriction, de distribuer les substances qu'il a créées à partir du Matériel Original, dans la mesure où ces substances ne sont pas des Descendants, des Dérivés Non Modifiés ou des Modifications.

5.3. EN AUCUN CAS, le BÉNÉFICIAIRE ne pourra apporter de Modifications pour des applications Commerciales sans l'accord préalable et écrit du FOURNISSEUR.

5.4. Le BÉNÉFICIAIRE reconnaît que le Matériel fait ou peut faire l'objet d'une demande de brevet.

Sauf dans les cas prévus dans le présent Accord, aucune licence expresse ou implicite ou autre droit n'est accordé au DESTINATAIRE dans les brevets, demandes de brevet, secrets commerciaux ou autres droits de propriété du FOURNISSEUR.

5.5. Le BÉNÉFICIAIRE reconnaît que le présent Contrat ne peut être interprété comme constituant une licence à son bénéfice ni un engagement ou une obligation de conclure tout accord ultérieur.

6) PROPRIÉTÉ

6.1. L'institution fournissante conserve la propriété du Matériel, y compris du Matériel contenu ou incorporé dans les Modifications.

Par ailleurs, l'institut fournisseur conserve tous les droits qui pourraient lui être conférés par les lois sur la propriété intellectuelle sur les inventions, notamment brevetables, qui pourraient résulter de l'utilisation par le BÉNÉFICIAIRE du Matériel Original.

6.2. Les Modifications réalisées conjointement par l'institut fournisseur et le BÉNÉFICIAIRE, ou par le BÉNÉFICIAIRE seul, sont la copropriété de l'institut fournisseur et du BÉNÉFICIAIRE.

6.3. Le BÉNÉFICIAIRE conserve la propriété des substances qu'il a créées seul à partir du Matériel ou des Modifications, à l'exception des Descendants, des Dérivés Non Modifiés ou des Modifications (c'est à dire qui ne contiennent pas le Matériel d'Origine, des Descendants ou du Dérivé Non Modifié). Un accord de copropriété sera négocié pour celles de ces substances qui résultent d'efforts de collaboration conjoints entre l'institut fournisseur et le BÉNÉFICIAIRE.

6.4. À l'exception des dispositions des points 6.1, 6.2 et 6.3 ci-dessus, la propriété de tout résultat de recherche, brevetable ou non, dépendra de la contribution inventive des participants à leur obtention.

Dans le cas où tout ou partie des résultats de la Recherche pourraient être protégés par une nouvelle demande de brevet désignant un ou plusieurs

inventeurs de l'institut fournisseur et du BÉNÉFICIAIRE, les parties se concerteront afin de définir les modalités de dépôt d'une telle demande de brevet. , ainsi que ses conditions d'exploitation.

6.5. Le BÉNÉFICIAIRE s'engage à ne pas déposer sans accord écrit de l'institut fournisseur, en son nom ou celui d'un tiers, dans quelque pays que ce soit, de demande de brevet ou de droit de propriété intellectuelle (droit d'auteur, marque, etc.) relatifs au Matériel.

6.6. Le BÉNÉFICIAIRE s'engage à fournir gratuitement et dans les meilleurs délais à l'institut fournisseur les Modifications résultant de l'utilisation du Matériel.

7) PUBLICATION - CONFIDENTIALITÉ

7.1. Le présent Accord n'empêchera ni ne retardera la publication des résultats de recherche résultant de l'utilisation du Matériel ou de ses modifications. Le BÉNÉFICIAIRE remettra à l'institut prestataire une copie de tout projet de publication.

7.2. Conformément aux usages scientifiques, la contribution des agents de l'institut fournisseur qui a fourni le Matériel ou de leurs éventuels collaborateurs, sera expressément mentionnée dans toute intervention orale ou écrite relative aux résultats d'utilisation du Matériel, soit par des remerciements, soit en tant que co-auteurs, selon la formule la plus appropriée. L'origine du

Le matériel ainsi que l'indication des éventuels brevets correspondants doivent figurer dans ces divulgations.

7.4. Le BÉNÉFICIAIRE s'engage à respecter et maintenir le caractère strictement confidentiel de toute information identifiée comme confidentielle reçue du Laboratoire Fournisseur.

Le BÉNÉFICIAIRE garantit le respect de l'institut prestataire par son personnel et ou toute personne attachée à quelque titre que ce soit à son service du caractère confidentiel desdites informations confidentielles.

Le BÉNÉFICIAIRE s'engage à utiliser les informations confidentielles uniquement dans le cadre du présent Contrat.

Les dispositions de 7.4 prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

8) CONDITIONS FINANCIÈRES

Le Matériel est transmis :

□ Gratuit

□ En contrepartie de la somme de……..FCFA pour le remboursement des frais de préparation et d'expédition. Dans ce cas, l'institut fournisseur adressera une facture, qui mentionnera les modalités de paiement (délai, compte), à l'établissement à l'adresse mentionnée en première page des présentes à l'attention du Demandeur ou de toute autre personne expressément désignée. (Cocher la case correspondante)

9) GARANTIES

9.1. Le BÉNÉFICIAIRE accepte le Matériel Original tel quel et reconnaît qu'il est de nature expérimentale et qu'il doit donc être utilisé avec prudence et précaution, puisque toutes ses caractéristiques ne sont pas connues et qu'il peut présenter des propriétés dangereuses. L'INSTITUT DES FOURNISSEURS NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT. DE PLUS, AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE N'EST ACCORDÉE PAR L'INSTITUT FOURNISSEUR QUANT À LA CAPACITÉ COMMERCIALE DU MATÉRIEL OU À SON ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU CONTRE TOUTE INFRACTION. L'INSTITUT FOURNISSEUR, ses administrateurs, employés ou agents n'assument aucune responsabilité et ne prennent aucune mesure à l'égard du Matériel ou de son utilisation par le BÉNÉFICIAIRE. Ce dernier défendra, indemnisera et dégagera de toute responsabilité l'institut fournisseur, ses administrateurs, employés et agents de tout dommage, réclamation ou responsabilité pouvant résulter de l'utilisation du Matériel ou des informations s'y rapportant.

9.2. L'institut prestataire ne garantit pas que l'utilisation du Matériel ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle de tiers.

10)TERMES DE L'ACCORD

10.1. Le présent accord entrera en vigueur à la dernière des dates indiquées sur la page de signature et prendra fin à la première des dates suivantes : (a) 2 ans à compter de la date de signature des présentes, ou (b) à la fin des travaux de recherche effectués. par le BÉNÉFICIAIRE utilisant le Matériel ou (c) dans les 30 jours suivant l'envoi par l'une des parties d'un avis écrit de résiliation, à condition que :

-Si le Contrat est résilié en vertu de (a) ou (b), le BÉNÉFICIAIRE cessera d'utiliser les Matériels et, selon les instructions de l'institution fournissante,

restituera ou détruira tout Matériel restant. Le BÉNÉFICIAIRE pourra, à sa discrétion, détruire les Modifications, ou rester lié par celles-ci. termes du Contrat en ce qui concerne les Modifications.

-Si l'institut fournisseur résilie le Contrat en vertu du (c) pour des raisons autres que le non-respect des termes du Contrat ou pour des causes telles que la connaissance d'un risque imminent pour la santé ou la contrefaçon d'un brevet, L'institut fournisseur peut, à la demande du BÉNÉFICIAIRE, accorder une prolongation de la Convention pour une durée maximale d'un an, afin de permettre l'achèvement des travaux en cours.

10.2. A l'issue de ce délai ou à la date d'expiration effective, le BÉNÉFICIAIRE cessera d'utiliser le Matériel et, selon les instructions de l'institut fournisseur, restituera ou détruira tout Matériel restant. Le BÉNÉFICIAIRE peut, à sa discrétion, détruire les Modifications, ou rester lié par les termes du Contrat en ce qui concerne les Modifications.

11) DIVERS

11.1. Le présent Contrat est régi par les lois du Cameroun et celle du pays de l'institution du BÉNÉFICIAIRE. Les tribunaux camerounais sont compétents pour connaître de tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du Contrat que les parties n'auraient pas pu résoudre à l'amiable.

11.2. Le présent Contrat constitue l'intégralité de l'Accord entre l'institut prestataire et le BÉNÉFICIAIRE en ce qui concerne son objet et remplace et annule toutes déclarations, négociations, engagements, communications orales ou écrites, acceptations, ententes et accords antérieurs, relatifs aux dispositions auxquelles le présent Contrat s’applique ou prévoit, qu’elle soit constituée ou non. Si une disposition du présent Accord s'avère inapplicable pour quelque raison que ce soit, les dispositions pertinentes seront modifiées pour les rendre exécutoires et ces modifications n'affecteront pas l'applicabilité (i) de cette disposition dans d'autres circonstances ou (ii) les autres clauses dans tous les cas. circonstances.

Institution du fournisseur Signature	Destinataire Signature

Nom Titre Date	Signature d'un représentant dûment autorisé pour engager l'institution/entreprise par sa signature. Nom Titre Date
Lu et approuvé par le scientifique. Signature Titre Date	Lu et approuvé par le demandeur. Signature Titre Date

Annexe 9 : Liste de contrôle d'inspection pour les essais cliniques

Section 1 : Généralités	
Date d'inspection	
Nom et adresse du site clinique.	
Nom et adresse du laboratoire (clinique, analytique).	

Noms des personnes rencontrées.	
Noms des inspecteurs.	
Référence (Annexe)	
Titre de l'étude	
Numéro d'identification du protocole, version du protocole	
Médicament/produit à l'étude	
Numéro d'enregistrement au Registre Panafricain des Essais Cliniques	
Phase d'essai	
Parrainer	
Chercheur principal	
Co-enquêteur	
Étape de l'étude inspectée (début, pendant, fin)	

Section 2 : Système de gestion des données	**Oui**	**Non**	**Partiel**	**N'est pas applicable**	**Observations**
2.1. L'étude a fait l'objet d'inspections					
2.2 Organisation des audits internes/externes					

dans le cadre de l'étude					
2.3. Existe-t-il un système de gestion des données pour l'étude ? Nom de la base de données et/ou outils de gestion de la base de données ; politique d'intégrité des données ; Les données et résultats ont été examinés et considérés comme exhaustifs, complets et fiables (avis des inspecteurs).					
2.4. Existe-t-il une documentation et des archives sur toutes les activités réalisées dans le cadre de l'étude ? Les politiques, procédures et responsabilités ont été documentées et suivies ; Les documents relatifs au produit médical expérimental, y compris la licence d'exportation ou l'autorisation d'importation, étaient disponibles ; Les pièces justificatives des achats, le bordereau d'expédition, les conditions de					

stockage lors du transport des produits expérimentaux étaient disponibles ; Le bordereau de réception sur place, les certificats d'analyses, la fiche de stock et le registre de distribution des produits expérimentaux étaient disponibles ; Gestion des écarts et violations, principes de gestion des risques et actions correctives et préventives ; Des dossiers de qualification et de formation des salariés et contractuels étaient disponibles ; Protection contre les risques de dégradation par le feu, l'eau, l'humidité et la détérioration					
2.5. Existe-t-il des rapports surles activités réalisées dans le cadre de l'étude ? lequel? Les rapports du gérant suivi Rapports de réunions					

Rapports d'assurance qualité couvrant l'examen des données et des informations					
Forces:					
Points faibles:					
3.1. Y a-t-il eu des changements dans le protocole approuvé par le comité d'éthique et les autorités réglementaires ? Des preuves de l'acceptation écrite du protocole et de ses annexes ou amendements par tous les chercheurs étaient disponibles ; Notification des modifications du protocole aux autorités ; La liste des changements. Points forts Points faibles					
Section 4 : Approbation éthique et réglementaire					
4.1. Existe-t-il un document relatif à l'approbation du comité d'éthique et à l'autorité de réglementation avant le début de l'étude ?					
4.2 4.2. Existe-t-il un système de					

déclaration des événements indésirables au comité d'éthique et à l'autorité de régulation ? Rapports d'événements indésirables graves Réponses du comité d'éthique et de l'autorité de régulation					
Points forts:					
Points faibles					
Section 5 : Le site d'essai					
5.1 a-t-il été approuvé ou non pour effectuer des tests s? -Autorisation de l'autorité étendue ; -L'adresse correcte de l'autorité ; -La durée de validité de l'autorisation -L'authenticité des signatures et cachets de l'autorité ; -Inscription du site.					
5.2 Le site dispose-t-il des équipements et des structures nécessaires à cet effet ? Présence d'un espace dédié aux examens physiques et équipé des instruments					

nécessaires et calibrés ; Accès contrôlé au niveau de la clinique et de la pharmacie ; Présence de lits d'hospitalisation ; Zone d'urgence bien équipée avec les médicaments nécessaires à administrer en cas d'urgence ; Les médicaments à administrer en urgence étaient stockés en fonction de leur durée de conservation et le matériel d'intervention était approprié.					
5.3. Le site répond-il aux normes d'hygiène et de biosécurité ? Des toilettes et des lavabos étaient disponibles ; Présence d'un système d'élimination des déchets. Cuisines et salles à manger équipées.					
Section 6 : Gestion de la pharmacie et du produit expérimental					
6.1. Existe-t-il des procédures de gestion des titrants au sein de la pharmacie ? Registres d'entrée et de sortie des entrées au sein de la pharmacie. Des procédures opératoires					

standardisées* ont été détaillées et décrivaient les différentes activités en pharmacie. -Les conditions de stockage étaient adaptées, selon les besoins, à la conservation des produits.					
6.2. La distribution et l'administration des produits expérimentaux ont-elles été réalisées selon un mode opératoire standardisé et randomisation,sans risque de confusion ? Les produits médicaux expérimentaux étaient correctement étiquetés : Feuille de randomisation et diagramme					
Points forts					
Points faibles:					
Section 7 : Personnel de recherche					
7.1. Toutes les responsabilités du personnel et l'organigramme ont-ils été décrits ? Du promoteur ; Les enquêteurs; Autres membres du personnel; Organigramme					

Des preuves de délégation de tâches au personnel en fonction de leurs qualifications et de leur expérience étaient disponibles					
7.2. Le profil du personnel répond-il aux exigences ? Documents relatifs aux qualifications y compris le personnel contractuel ; Expérience et formation appropriées ; Le nombre d'employés était suffisant pour réaliser le test.					
7.3. Existe-t-il un système de suivi-évaluation ?					
7.4. Un responsable du suivi possédant l'expérience appropriée a été nommé pour suivre l'étude.					
Fortpoints:					
Points faibles					
Article 8 : Objet					
8.1. Existe-t-il un formulaire d'information sur l'étude ? Sur les avantages du test : -Le produit médical expérimental ; - Événements indésirables possibles ;					

- Assurances et autres questions via le formulaire d'information ; - Les coordonnées du chercheur principal ou du secrétariat ont été communiquées aux sujets					
8.2. Tous les sujets participant à l'étude ont-ils signé des formulaires de consentement éclairé (ICF) ? FCE contenait toutes les informations requises présentées de manière à pouvoir être comprises par les sujets. Traducteur; Bonne version signée ;					
Points forts: Points faibles:					
Section 9 : Prise en charge des événements indésirables					
9.1 Y a-t-il une cohérence entre les résultats et les données enregistrées dans les fiches d'observation et celles contenues dans les fiches de notification ? Présence du formulaire de notification ; Présence d'un rapport de cas ;					

Responsable du suivi des effets indésirables ; Comité thérapeutique.					
9.2. Comment fonctionne votre système de gestion des événements indésirables ? Des échantillons, y compris du sang et de l'urine, ont été prélevés, des radiographies pulmonaires ou d'autres les tests ont été effectués comme requis ; Les événements indésirables, les médicaments concomitants, la posologie et le prélèvement d'échantillons ont été enregistrés avec précision. Points forts: Points faibles:					
Section 10 : Laboratoire d'analyse					
10.1. Les laboratoires étaient-ils suffisamment équipés pour effectuer les tests requis ? Automates ; Le matériel nécessaire ; Contrats en place pour la sous-traitance ; Respect des procédures de stockage et de					

manipulation des échantillons ; Des registres d'équipement ont été conservés ; Les documents étaient appropriés pour la qualification et l'étalonnage des équipements et instruments de laboratoire ; Ressources nécessaires pour réaliser les analyses souhaitées ; Le statut de qualification et d'étalonnage était valide au moment de l'utilisation pour la validation de la méthode et l'analyse des échantillons.					
10.2. Comment les échantillons de laboratoire sont-ils gérés ? Les données de base ont été enregistrées avec précision ; Les espaces destinés à la réception et à la conservation (-20 ou - 70° degrés Celsius jusqu'au moment de l'analyse) des échantillons, à la préparation des échantillons et à l'analyse étaient appropriés ;					

Les congélateurs utilisés pour conserver les échantillons étaient qualifiés ; Les fichiers étaient traçables ; Les méthodes de test étaient					

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

DECISION N° 4 9 8 / D/ MINSANTE/SG/DROS/DAJC DU 04 OCT 2023
rendant exécutoire les Lignes Directrices pour les Essais Cliniques au Cameroun.

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n°96/03 du 04 janvier 1996 portant loi cadre dans le domaine de la santé ;
Vu la loi n°2022/008 du 27 Avril 2022 relative à la recherche médicale impliquant la personne humaine au Cameroun ;
Vu le décret n°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018 ;
Vu le décret n° 2013/093 du 03 avril 2013 portant organisation du Ministère de la Santé Publique ;
Vu le décret n° 2019/002 du 04 janvier 2019 portant réaménagement du Gouvernement ;
Vu l'arrêté N° 977/A/MINSANTE/SESP/SG/DROS du 18 avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Comités d'Ethique de la Recherche pour la Santé Humaine au sein des structures relevant du ministère en charge de la santé publique ;
Vu l'arrêté N° 1737/ A/MINSANTE/SG/DROS du 28 novembre 2013 fixant les modalités des frais d'évaluation des protocoles de recherche soumis aux comités d'éthique de la recherche pour la santé humaine pour l'obtention d'une clairance éthique ;

Considérant les nécessités de service,

DECIDE:

ARTICLE 1.- La présente décision rend exécutoire les lignes directrices pour les essais cliniques au Cameroun.

ARTICLE 2.- Les lignes directrices susvisées sont jointes en annexe de la présente décision.

ARTICLE 3.- Les lignes directrices pour les essais cliniques au Cameroun feront l'objet d'une actualisation en tant que de besoin, à l'initiative du Ministre chargé de la Santé Publique.

ARTICLE 4.- La présente décision qui prend effet à compter de la date de signature, sera enregistrée puis communiquée partout où besoin sera, en français et en anglais.-/

Yaoundé, le _____

REPUBLIQUE DU CAMEROUN Republic of Cameroon PAIX-TRAVAIL-PATRIE Peace-Work-Fatherland LE MINISTRE The Minister Ministry of Public Health MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE,

Dr. MANAOUDA Malachie